



Nuansa  
Fajar  
Cemerlang



Optimal

# Asuhan Kebidanan Kasus Patologis Pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah



dr. Evi Istiqamah, M.Biomed.

Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.SiT., MH., CBC., CPM

Nuril Absari, S.SiT., M.Kes.

Royani Chairiyah, S.SiT., M.Kes., M.Keb.

Ni Putu Riza Kurnia Indriana, SST., M.Kes.

Rahmah Fitria, S.ST., M.Keb.

Brivian Florentis Yustanta, SST., M.Kes.

Melly Damayanti, SST., M.Keb.

# **ASUHAN KEBIDANAN KASUS PATOLOGIS PADA BAYI, BALITA, DAN ANAK PRASEKOLAH**

**dr. Evi Istiqamah, M.Biomed**

**Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.SiT, MH, CBC, CPM**

**Nuril Absari, S.SiT, M.Kes**

**Royani Chairiyah, S.SiT, M.Kes, M.Keb**

**Ni Putu Riza Kurnia Indriana, SST., M.Kes**

**Rahmah Fitria., S.ST.,M.Keb**

**Brivian Florentis Yustanta., SST., M.Kes**

**Melly Damayanti, SST., M.Keb**



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**

**ASUHAN KEBIDANAN KASUS PATOLOGIS  
PADA BAYI, BALITA, DAN ANAK PRASEKOLAH**

Penulis:

dr. Evi Istiqamah, M.Biomed  
Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.SiT, MH, CBC, CPM  
Nuril Absari, S.SiT, M.Kes  
Royani Chairiyah, S.SiT, M.Kes, M.Keb  
Ni Putu Riza Kurnia Indriana, SST., M.Kes  
Rahmah Fitria., S.ST., M.Keb  
Brivian Florentis Yustanta., SST., M.Kes  
Melly Damayanti, SST., M.Keb

Desain Cover:

Ivan Zumarano

Tata Letak:

Achmad Faisal

ISBN:

978-623-8411-01-6

Cetakan Pertama:

**April, 2023**

Hak Cipta 2023

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Copyright © 2023**

**by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**Nuansa Fajar Cemerlang**  
**Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F**  
**Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah**  
**Jakarta Barat**

Website: [www.nuansafajarcemerlang.com](http://www.nuansafajarcemerlang.com)

Instagram: @bimbel.optimal

## PRAKATA

Anak adalah amanah dari Allah *subhaanahu wa ta'ala* yang dititipkan kepada orang tuanya. Untuk itu, anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun rohani. Setiap manusia diciptakan untuk menjadi hamba-Nya. Anak merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah *subhaanahu wa ta'ala*. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Selain sebagai anugerah dan nikmat dari Allah *subhaanahu wa ta'ala*, anak juga menjadi ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Anak merupakan keturunan dari orang tua. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari orang tuanya. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk mendidik, menjaga, melindungi anak dengan baik dengan memberikan apa yang dibutuhkan anak.

Menurut pandangan Islam, badan yang sehat tersebut tidak hanya akan menghasilkan kemampuan berfikir yang baik, tetapi juga menghasilkan sikap mantap untuk terus optimis dan penuh harapan dalam menghadapi tantangan kehidupan dan dalam pergaulannya dengan orang lain. Atas dasar alasan-alasan tersebut maka Islam menganjurkan agar kita melakukan langkah yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak dan menuntun mereka sepanjang hidupnya secara sistematis dan terorganisir.

Melindungi dan meningkatkan kesehatan anak merupakan hal yang sangat penting. Anak-anak perlu diberikan lingkungan yang stabil untuk berkembang. Ini termasuk kesehatan dan gizi yang baik, serta kesempatan untuk belajar dan tumbuh-berkembang. Menjaga kesehatan anak melalui investasi kesehatan jangka panjang dapat menjadi hal terpenting yang dapat dilakukan orang tua. Sebab, melihat anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik adalah hal yang paling membahagiakan bagi para orang tua.

Salah satu kasus yang diangkat adalah anemia merupakan kasus gangguan pada darah yang umum terjadi akibat kekurangan sel darah merah. Pada anak, anemia dapat menyebabkan mereka lesu dan tidak bersemangat dalam beraktivitas. Kasus anemia pada anak pun cukup jamak terjadi. Menurut Kemenkes, 1 dari 3 anak di bawah lima tahun di Indonesia mengalami anemia. Anak-anak memang menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kondisi anemia, khususnya karena defisiensi besi. Anemia bisa menyebabkan masalah pada tumbuh kembang anak jika tidak segera diobati.

Buku berjudul asuhan kebidanan pada bayi, balita dan anak prasekolah mencoba menyuguhkan dan mengemas beberapa hal penting agar kita memahami bahwa kasus pada anak harus segera ditangani. Di dalam buku ini akan dibahas semuanya mulai dari hal dasar, bagaimana mengenal tanda –tanda kelainan pada anak hingga bagaimana kita

dapat membaca penanganan yang dapat dilakukan ketika anak terkena kasus patologis tersebut.

Buku ini mengajarkan kita untuk mewaspadai penyakit pada anak yang dapat merugikan tumbuh kembang anak - anak kita kelak. Mengajarkan pula bagaimana antisipasi/penanganan yang dapat dilakukan pada anak kita ketika anak kita terkena kpenyakit baik itu yang disebabkan oleh infeksi dan non infeksi. Buku ini dapat menjadi harapan baru yang bisa dilakukan orang tua untuk masa depan anak lebih cerah banyak prestasi cemerlangnya dengan mengatasi kasus patologis yang terjadi pada anak.

Akhirul kalam Kesempurnaan hanya milik Allah *subhaanahu wa ta'ala*. Kekurangan dan kekhilafahan adalah milik manusia. Terimakasih saya haturkan kepada penulis yang telah membuat buku ini seapik mungkin agar menjadi salah satu solusi bahan baca menambah wawasan kita terkait kasus patologis pada anak. Penulis merupakan dosen yang memiliki perhatian pada kesehatan anak. Semoga Allah memberkahi dan memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadaNya. Aamiin Yaa Rabbal 'aalamiin.

Makassar, 04 September 2023

Dr. Sundari,SST., M.P.H  
Ketua Prodi D3 Kebidanan FKM UMI

## DAFTAR ISI

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>PRAKATA .....</b>                                      | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                    | <b>v</b>   |
| <b>BAB 1 CEGAH STUNTING PADA ANAK .....</b>               | <b>1</b>   |
| A. PENDAHULUAN .....                                      | 2          |
| B. DEFINISI STUNTING .....                                | 2          |
| C. PENYEBAB STUNTING .....                                | 3          |
| D. MANIFESTASI KLINIK .....                               | 4          |
| E. PENILAIAN STATUS GIZI .....                            | 4          |
| F. DAMPAK STUNTING .....                                  | 5          |
| G. PENCEGAHAN STUNTING .....                              | 6          |
| H. REKOMENDASI RENCANA AKSI INTERVENSI STUNTING .....     | 7          |
| I. PENANGANAN STUNTING .....                              | 8          |
| J. KEBERHASILAN INTERVENSI STUNTING BEBERAPA NEGARA ..... | 11         |
| K. REFERENSI.....                                         | 13         |
| <b>BAB 2 IMUNISASI BAYI BALITA DAN ANAK.....</b>          | <b>15</b>  |
| A. DEFINISI IMUNISASI .....                               | 16         |
| B. TUJUAN IMUNISASI.....                                  | 17         |
| C. DAMPAK TIDAK DIBERIKAN IMUNISASI.....                  | 18         |
| D. HAMBATAN IMUNISASI .....                               | 18         |
| E. JENIS-JENIS IMUNISASI .....                            | 19         |
| F. JADWAL IMUNISASI .....                                 | 24         |
| G. PERSIAPAN DALAM PEMBERIAN IMUNISASI .....              | 26         |
| H. PENYIMPANAN VAKSIN .....                               | 27         |
| I. REFERENSI.....                                         | 28         |
| <b>BAB 3 MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT .....</b>         | <b>29</b>  |
| A. PENDAHULUAN .....                                      | 30         |
| B. TUJUAN MTBS .....                                      | 30         |
| C. MANFAAT MTBS.....                                      | 31         |
| D. TUJUAN MTBS .....                                      | 31         |
| E. TATALAKSANA MTBS .....                                 | 31         |
| F. BATUK ATAU SUKAR BERNAPAS .....                        | 32         |
| G. PEMERIKSAAAN DIARE .....                               | 38         |
| H. PEMERIKSAAN MALARIA .....                              | 40         |
| I. PEMERIKSAAN PENYAKIT TELINGA PADA ANAK .....           | 43         |
| J. MEMERIKSA STATUS GIZI .....                            | 43         |
| K. PEMERIKSAAN ANEMIA .....                               | 44         |
| L. PEMERIKSAAN PEMBERIAN VITAMIN A .....                  | 44         |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| M. MENILAI MASALAH/KELUHAN LAIN .....                                                                            | 45        |
| N. MERUJUK ANAK .....                                                                                            | 45        |
| O. KUNJUNGAN ULANG.....                                                                                          | 46        |
| P. REFERENSI.....                                                                                                | 46        |
| <b>BAB 4 PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM MERAWAT BAYI, BALITA, DAN ANAK</b>                                           |           |
| <b>PRASEKOLAH .....</b>                                                                                          | <b>47</b> |
| A. PENDAHULUAN .....                                                                                             | 48        |
| B. DEFINISI PENDIDIKAN KESEHATAN .....                                                                           | 49        |
| C. MACAM-MACAM PENDIDIKAN KESEHATAN PADA BAYI, BALITA DAN ANAK<br>PRASEKOLAH .....                               | 49        |
| D. REFERENSI.....                                                                                                | 59        |
| <b>BAB 5 YOU SHOULD KNOW! EVIDENCE BASED DALAM ASKEB BAYI, BALITA, DAN<br/>ANAK PRA SEKOLAH .....</b>            | <b>61</b> |
| A. WHAT IS EVIDENCE BASED .....                                                                                  | 62        |
| B. EVIDENCE BASED DALAM ASKEB BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH .....                                            | 63        |
| C. YOU CAN FIND THEM EVERYWHERE BUT PLEASE DON'T USE IT TO YOUR<br>CHILDREN.....                                 | 65        |
| D. REFERENSI.....                                                                                                | 69        |
| <b>BAB 6 POLA ASUH ORANG TUA DAN KECANDUAN SMARTPHONE PADA ANAK .....</b>                                        | <b>71</b> |
| A. PENDAHULUAN .....                                                                                             | 72        |
| B. POLA ASUH ORANG TUA .....                                                                                     | 73        |
| C. KECANDUAN SMARTPHONE PADA ANAK .....                                                                          | 77        |
| D. POLA PENGAWASAN ORANG TUA DALAM PENGGUNAAN SMARTPHONE /<br>INTERNET ( <i>INTERNET PARENTING STYLE</i> ) ..... | 82        |
| E. HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DAN KECANDUAN SMARTPHONE PADA<br>ANAK.....                                       | 83        |
| F. KERANGKA BERPIKIR.....                                                                                        | 85        |
| G. KESIMPULAN .....                                                                                              | 86        |
| H. REFERENSI.....                                                                                                | 86        |
| <b>BAB 7 ANEMIA ANTARA NON INFEKSI DAN INFEKSI .....</b>                                                         | <b>89</b> |
| A. PENDAHULUAN .....                                                                                             | 90        |
| B. DEFINISI ANEMIA, SIKLUS HIDUP DAN PEMBENTUKAN ERITROSIT .....                                                 | 91        |
| C. PENYEBAB ANEMIA PADA ANAK.....                                                                                | 95        |
| D. DAMPAK ANEMIA PADA ANAK .....                                                                                 | 100       |
| E. GEJALA ANEMIA PADA ANAK (TANDA SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF) .....                                                  | 101       |
| F. PENANGANAN ANEMIA PADA ANAK.....                                                                              | 102       |
| G. REFERENSI.....                                                                                                | 104       |

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB 8 DETEKSI DINI KOMPLIKASI DAN PENANGANAN AWAL KEGAWATDARURATAN<br/>PADA NEONATUS, BAYI DAN BALITA .....</b> | <b>107</b> |
| A.    PENDAHULUAN .....                                                                                            | 108        |
| B.    KOMPLIKASI YANG TERJADI PADA NEONATUS, BAYI DAN BALITA.....                                                  | 111        |
| C.    UPAYA PENCEGAHAN KOMPLIKASI ATAU KEGAWATDARURATAN NEONATAL,<br>BAYI DAN BALITA .....                         | 122        |
| D.    KESIMPULAN .....                                                                                             | 124        |
| E.    REFERENSI.....                                                                                               | 125        |
| <b>PROFIL PENULIS.....</b>                                                                                         | <b>127</b> |



# **BAB 1**

## **CEGAH STUNTING PADA ANAK**

**Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T, MH, CBC, CPM**



# CEGAH STUNTING PADA ANAK

**Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T, MH, CBC, CPM**

## **A. PENDAHULUAN**

Kualitas sumber daya manusia secara signifikan turun akibat stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius. Menurut data WHO pada tahun 2017, terdapat > 155 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting di seluruh dunia. Pada beberapa daerah di Indonesia stunting masih menjadi masalah dan angka obesitas pada bayi meningkat serta prevalensi anak di bawah usia 2 tahun.

Salah satu negara yang mengalami beban ganda gizi buruk (DBM) adalah Indonesia. Stunting dikatakan sebagai salah satu gejala beban ganda gizi mencakup kondisi kelebihan gizi seperti kelebihan berat badan pada suatu keluarga atau individu. Seringkali, perawakan pendek tidak dianggap sebagai suatu masalah, namun kondisi stunting dapat mengakibatkan berbagai perubahan patologis. (Predergast, A.I and Humprey, 2015)

Unit PSG (Pemantau Status Gizi) Kementerian Kesehatan melakukan riset di mana hasilnya menyebutkan bahwa sebanyak 29% balita di Indonesia mempunyai status gizi pendek atau sangat pendek. Ada tiga provinsi yang memiliki angka stunting tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur/NTT (41,2%), Sulawesi Barat (38,4%) dan Kalimantan Selatan (37,2%). (Kementerian Kesehatan RI, 2016)

Anak-anak yang pendek atau stunting, biasanya anak-anak dengan tingkat pendidikan rendah, pendapatan rendah, dan kualitas hidup buruk, serta anak-anak yang lebih rentan terhadap penyakit tidak menular, merupakan indikator bahwa penduduk suatu negara akan menjadi kurang produktif di masa depan. (Siti Helmyati dkk, 2022)

## **B. DEFINISI STUNTING**

1. Stunting adalah gizi buruk kronis, yang dimulai saat anak masih dalam kandungan atau segera setelah lahir namun tidak muncul hingga anak berusia 2 tahun, menyebabkan kegagalan tumbuh kembang pada balita dan menyebabkan anak menjadi pendek untuk anak seusianya. (Pakpahan, 2021)
2. Stunting (bertubuh pendek) adalah kekurangan gizi kronis masa kanak-kanak yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan kognitif anak secara permanen dan mengakibatkan kerugian jangka panjang yang dapat menghalangi anak mencapai potensi pertumbuhan maksimalnya. (UNICEF, 2018)
3. Stunting adalah suatu kelainan ketika tubuh dan otak gagal berkembang akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan, menyebabkan anak menjadi lebih pendek

dibandingkan anak-anak lain seusianya dan berpikir lebih lambat, dengan z skor  $< -2$  SD (pendek) atau  $< 3$  SD (sangat pendek). (Kementerian Kesehatan RI, 2016)

### **C. PENYEBAB STUNTING**

Faktor penyebab stunting yaitu :

1. Nutrisi tambahan yang tidak mencukupi meliputi :
  - a. Kualitas makanan yang buruk  
Defisiensi mikronutrien, kurangnya variasi dan konsumsi pangan hewani, serta kandungan makanan pendamping yang tidak bergizi dan rendah kalori.
  - b. Teknik pemberian makan yang tidak memadai  
Gizi yang tidak memadai selama dan setelah sakit, kualitas makanan yang tidak sesuai, dan pemberian makanan yang tidak teratur.
  - c. Keamanan makanan dan minuman  
Buruknya kebersihan, makanan yang disiapkan secara tidak aman, dan tercemarnya makanan serta minuman.
2. Penyakit infeksi  
Bayi dan balita sering terjangkit ISPA, diare, dan cacingan.
3. Faktor ibu (maternal)  
Variabel ibu antara lain gizi prakonsepsi yang kurang, gizi buruk selama hamil dan menyusui, usia saat hamil terlalu muda atau tua, ibu tinggi badan kurang atau pendek, infeksi, masalah kesehatan jiwa, IUGR, kelahiran dini, BBLR, jarak kelahiran dekat, dan hipertensi. Selain itu, rendahnya pendidikan ibu dapat berdampak pada pengetahuan pengasuhan dan pengasuhan anak, cara menyajikan makanan, penyiapan bahan dan menu makanan yang sesuai kebutuhan.
4. Faktor genetik  
Komponen penting untuk mencapai hasil proses pertumbuhan yang berkualitas ditentukan oleh telur yang sudah dibuahi.
5. Faktor lingkungan rumah  
Mencakup aktivitas dan stimulasi yang tidak mencukupi, pemberian perawatan yang buruk, distribusi makanan yang tidak memadai, pengasuhan yang rendah, dan fasilitas air dan sanitasi yang di bawah standar.
6. Pemberian ASI Eksklusif  
Diawali dengan pemberian metode Inisiasi Menyusu Dini (IMD). ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI yang cukup, pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berumur 24 bulan.
7. Faktor sosial ekonomi  
Rendahnya tingkat sosial ekonomi akan berdampak pada pilihan pangan keluarga sehingga menyebabkan kurang bervariasi dan dikonsumsi dalam jumlah

yang lebih sedikit, terutama yang penting bagi tumbuh kembang anak antara lain sumber protein, vitamin dan mineral. Rata-rata tinggi badan balita perempuan 6,7 cm dan balita laki-laki 7,3 cm, hal tersebut dapat diartikan bahwa tinggi badan balita lebih pendek dari standar rujukan WHO. Pasalnya, anak-anak Indonesia di bawah usia lima tahun masih mengonsumsi lebih sedikit kalori dan protein dibandingkan angka kecukupan gizi harian (AKG).

8. Terbatasnya program pembelajaran usia dini yang berkualitas, ANC (antenatal care), dan layanan kesehatan lainnya.

Anak-anak cenderung tidak mengunjungi Posyandu secara teratur dan mereka belum mempunyai akses terhadap imunisasi yang memadai. (Bappenas, 2018)(TNP2K, 2017)

#### **D. MANIFESTASI KLINIK**

Ciri-ciri stunting yaitu:

1. Anak lebih pendek dari rata-rata anak lain seusianya
2. Proporsi tubuh normal dan anak terlihat lebih kecil dibandingkan anak lain seusianya
3. Berat badan yang rendah dibandingkan anak lain seusianya
4. Pertumbuhan tulang anak tertunda
5. Pertumbuhan gigi anak terhambat
6. Tes perhatian dan memori belajar anak yang buruk
7. Terlambatnya gejala pubertas seperti terlambat haid. (Kementerian Kesehatan RI, 2018)

#### **E. PENILAIAN STATUS GIZI**

Keadaan status gizi ditentukan oleh keseimbangan zat gizi yang dikonsumsi sesuai kebutuhan yang digunakan untuk berbagai proses biologis. Metode penilaian status gizi yang paling sering digunakan adalah penilaian antropometri karena paling sederhana, praktis, aman serta dapat digunakan dengan jumlah sampel yang besar. Ini juga paling murah, mudah diangkut, dan tahan lama. Beberapa indikator status gizi dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan.

Tiga indikator pengukuran untuk pertumbuhan bayi dan anak, antara lain:

1. Indikator Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Berat badan berhubungan erat dengan usia dan tinggi badan, indikator ini dapat membantu mengidentifikasi masalah gizi secara umum. Perawakan pendek (merupakan masalah gizi kronis) atau penyakit infeksi (termasuk masalah gizi akut) keduanya dapat mengakibatkan berat badan rendah seiring bertambahnya usia.

2. Indikator Tinggi Badan atau Panjang Badan Menurut Umur (TB/U)

Mengidentifikasi permasalahan gizi kronis karena berlangsung dalam waktu lama seperti kemiskinan, gaya hidup yang buruk, dan kekurangan konsumsi pangan dalam waktu lama sehingga menyebabkan anak menjadi lebih pendek. Status stunting menggunakan pengukuran antropometri berupa panjang atau tinggi badan menurut umur.

### 3. Indikator Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Memberikan gambaran indikasi masalah gizi akut karena peristiwa yang terjadi dalam waktu yang singkat seperti terjadi wabah penyakit dan kelaparan sehingga anak menjadi kurus. Indikator BB/TB ini untuk mengidentifikasi kurus dan gemuk.

**Tabel 1.1 Klasifikasi Status Gizi Menurut WHO, 2007**

| Indeks                                                                        | Kategori Status Gizi | Ambang Batas (Z-score)      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Berat badan menurut umur (BB/U)</b>                                        | Gizi buruk           | < -3SD                      |
|                                                                               | Gizi kurang          | ≥ -3SD sampai dengan < -2SD |
|                                                                               | Gizi baik            | ≥ -2SD                      |
| <b>Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)</b>                               | Sangat kurus         | < -3SD                      |
|                                                                               | Kurus                | -3SD sampai dengan -2SD     |
|                                                                               | Normal               | -2SD sampai dengan 2SD      |
|                                                                               | Gemuk                | > 2SD                       |
| <b>Panjang badan menurut umu (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)</b> | Sangat pendek        | < -3SD                      |
|                                                                               | Pendek               | -3SD sampai dengan -2SD     |
|                                                                               | Normal               | -2SD sampai dengan 2SD      |
|                                                                               | Tinggi               | > 2SD                       |

Sumber : (Kementerian Kesehatan RI, 2010)

## F. DAMPAK STUNTING

### 1. Jangka pendek

Stunting bisa menyebabkan gagal tumbuh karena mengakibatkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, terjadi hambatan perkembangan otak dan sistem motorik, ukuran tubuh tidak ideal dan kelainan metabolisme.

### 2. Jangka panjang

Penyakit tidak menular seperti Diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke akan meningkat risikonya, pada kasus gizi buruk bisa menimbulkan gangguan pertumbuhan berupa pendek dan kurus. Stunting menyebabkan penurunan kapasitas intelektual akibat terganggunya struktur dan fungsi saraf dan sel otak secara permanen sehingga mempengaruhi penyerapan pelajaran. (Bappenas, 2018) Anak-anak yang mengalami pertumbuhan awal yang normal dapat mengalami gangguan pertumbuhan pada usia 4-6 tahun dan memiliki risiko 14 kali lipat untuk menjadi pendek pada usia sebelum pubertas. Sebaliknya, anak-anak yang mengalami pertumbuhan pendek dini pada usia 0-2 tahun dan terus menjadi pendek pada usia 4-6 tahun memiliki risiko 27 kali lipat untuk terus menjadi pendek sebelum masa pubertas. (Bappenas, 2018)

## G. PENCEGAHAN STUNTING

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Gizi ditetapkan pemerintah sebagai kebijakan pencegahan stunting di mana fokus utamanya pada kelompok usia pertama 1000 hari kehidupan, antara lain:

1. Pemberian minimal 90 tablet tambah darah kepada ibu hamil
2. Pemberian makanan tambahan selama kehamilan
3. Memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil
4. Persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan yang ahli)
5. Melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
6. Memberikan ASI kepada bayi secara eksklusif
7. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pada bayi > 6 bulan - 2 tahun
8. Pemberian vitamin A dan imunisasi dasar lengkap
9. Memantau pertumbuhan balita
10. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. (Keputusan Presiden, 2013)

Upaya pencegahan stunting meliputi 3 hal yaitu :

### 1. Pola asuh

Pentingnya pemberian informasi gizi dan kesehatan sebelum dan selama kehamilan, pemeriksaan kehamilan rutin, persalinan di rumah sakit, IMD segera setelah lahir, bayi diberikan kolostrum, pemberian ASI eksklusif sampai anak berusia 2 tahun, pemberian ASI secara *on demand* sesuai usia anak, imunisasi dan pemberian pelayanan kesehatan yang baik.

### 2. Pola makan

Mencakup kurangnya keanekaragaman, rendahnya nilai gizi, dan terbatasnya ketersediaan pangan. Perlu diperkenalkan ungkapan “Isi Pringku” yang berarti porsi makan yang mengandung sayur dan buah sebanyak setengah piring, protein sebanyak setengah piring (nabati atau hewani), di mana porsinya lebih yang banyak dibandingkan dengan karbohidrat.

### 3. Sanitasi serta akses air bersih

Kebiasaan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, tidak buang air besar sembarangan, mudahnya akses terhadap sanitasi dan air bersih sehingga meminimalkan risiko ancaman penyakit infeksi. (Kemenkes RI, 2018)

## H. REKOMENDASI RENCANA AKSI INTERVENSI STUNTING

Rekomendasi rencana aksi intervensi stunting terdiri dari lima pilar yaitu:

**Tabel 1.2 Lima Pilar Penanganan Stunting**

| Pilar 1                                     | Pilar 2                                                                                          | Pilar 3                                                                         | Pilar 4                                                  | Pilar 4                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara | Kampanye Nasional Berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas | Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi Program Nasional, Daerah dan Masyarakat | Mendorong kebijakan “ <i>Nutritional Food Security</i> ” | Pemantauan dan Evaluasi |

### **Pilar 1 : Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara**

Memerlukan komitmen dari pemerintah dalam implementasi strategi, kebijakan, dan target nasional dan regional (provinsi atau kabupaten/kota), serta penggunaan Sekretariat SDGs dan TNP2K sebagai lembaga koordinasi dan pengendalian program intervensi stunting.

### **Pilar 2 : Kampanye Nasional Berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas**

Penelitian dan pengalaman di negara lain disebutkan bahwa salah satu strategi yang dapat menurunkan prevalensi stunting adalah inisiatif nasional yang menggunakan media, penjangkauan keluarga, atau keduanya untuk mendidik masyarakat.

### **Pilar 3 : Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi Program Nasional, Daerah dan Masyarakat**

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program serta kualitas layanan program Puskesmas, Posyandu, PAUD, BPSPAM, PKH, dll. Secara khusus, dukungan untuk ibu hamil, menyusui, dan balita pada 1000 HPK serta insentif untuk pelaksanaan program intervensi stunting di daerah sasaran yang efektif menurunkan angka stunting harus ditingkatkan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa harus digunakan semaksimal mungkin untuk mengalokasikan dana subnasional ke solusi stunting yang paling penting.

### **Pilar 4 : Mendorong kebijakan “*Nutritional Food Security*”**

Pilar ini berfokus pada :

1. Adanya dorongan dalam kebijakan untuk menjamin akses terhadap makanan padat gizi, terutama di daerah dengan tingkat stunting yang tinggi.
2. Implementasi program komprehensif untuk meningkatkan pangan, pupuk, dan bioenergi
3. Lebih sedikit makanan yang terkontaminasi yang dikonsumsi
4. Memulai PMT atau pemberian makanan tambahan
5. Infrastruktur untuk pasar makanan dimaksudkan untuk diinvestasikan di tingkat perkotaan dan pedesaan melalui kemitraan dengan perusahaan, dana desa, dll.

#### **Pilar 5 : Pemantauan dan Evaluasi**

Hal ini mencakup pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan dan kualitas layanan program intervensi stunting, pengukuran dan publikasi hasil dan kemajuan intervensi stunting secara berkala setiap tahun untuk memastikan akuntabilitas, penganggaran dan perencanaan berbasis hasil pada program-program di tingkat pusat dan daerah, serta pengendalian intervensi stunting. (Pakpahan, 2021)(TNP2K, 2017)

### **I. PENANGANAN STUNTING**

Fokus penanganan stunting pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai sejak konsepsi hingga usia 2 tahun (periode emas/*golden periode*/waktu kritis). Kerusakan permanen (*window of opportunity*) akan terjadi apabila masa ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Kerangka intervensi stunting meliputi :

1. Intervensi gizi spesifik
  - a. Ibu hamil
    - 1) Pemberian makanan tambahan untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis.
    - 2) Pemberian suplementasi zat besi dan asam folat.
    - 3) Mengatasi kekurangan iodium.
    - 4) Penanggulangan infeksi kecacingan.
    - 5) Pencegahan dan penatalaksanaan klinis malaria.
    - 6) Pembatasan konsumsi kafein selama hamil.
    - 7) Pemberian konseling atau edukasi gizi.
    - 8) Pencegahan, deteksi, tata laksana klinis dan dukungan gizi bagi ibu dengan HIV.
    - 9) Suplementasi kalsium bagi ibu hamil.
  - b. Ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan
    - 1) Perawatan kolostrum dan promosi IMD.
    - 2) Mendukung dan memberikan penyuluhan tentang pemberian ASI secara eksklusif.
    - 3) Bimbingan dan edukasi gizi untuk ibu menyusui.

- 4) Mendukung ibu dan anak dengan HIV melalui pencegahan, deteksi, manajemen klinis, dan perawatan gizi).
- c. Ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan
  - 1) Mendukung pemberian ASI dan bentuk nutrisi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.
  - 2) Pengobatan kecacingan pada ibu dan anak.
  - 3) Pemberian suplemen zink kepada anak-anak.
  - 4) Fortifikasi makanan dengan zat besi dan suplementasi zat gizi mikro.
  - 5) Pencegahan dan pengobatan malaria pada ibu dan anak.
  - 6) Memastikan bahwa anak-anak menerima semua vaksinasi mereka (imunisasi lengkap).
  - 7) Pengobatan dan pencegahan diare pada anak.
  - 8) Menerapkan pedoman rumah sakit ramah anak.
  - 9) Menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
  - 10) Pemberian suplemen vitamin A pada anak usia 6-59 bulan.
  - 11) Penatalaksanaan malnutrisi akut berat pada anak.
  - 12) Pemantauan tumbuh kembang anak.
2. Intervensi gizi sensitif
 

Berbagai kementerian dan lembaga melakukan inisiatif pembangunan di luar sektor kesehatan (yang menyumbang 70% dari tindakan pencegahan stunting). Intervensi gizi sensitif meliputi:

  - a. Penyediaan air bersih dan sanitasi
    - 1) Mengumpulkan informasi tentang fasilitas air bersih.
    - 2) Pendataan cakupan akses air bersih.
    - 3) Pemetaan sanitasi.
    - 4) Pengadaan sarana air bersih.
    - 5) Pelatihan sanitarian.
    - 6) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
  - b. Ketahanan pangan dan gizi (PMT pada ibu hamil yang mengalami KEK).
    - 1) Memasukkan paket makanan dan kegiatan PKH Plus untuk keluarga hamil.
    - 2) Memberikan emansipasi ekonomi mikro kepada keluarga ibu hamil yang mengalami KEK.
    - 3) Meningkatkan pendidikan perempuan.
    - 4) Meningkatkan layanan KB.
    - 5) Menawarkan PMT untuk ibu hamil KEK dengan biaya yang terjangkau.
    - 6) Menciptakan produk PMT khusus untuk ibu hamil.
  - c. Keluarga Berencana (KB)
    - 1) Melakukan pelatihan tentang kontrasepsi kepada tenaga kesehatan.
    - 2) Mengadvokasi dan mengedukasi perempuan yang sudah menikah berusia 15 hingga 24 tahun tentang kontrasepsi.

- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pemakaian kontrasepsi.
- d. Jaminan kesehatan masyarakat
  - 1) Menyusun informasi masyarakat miskin yang berhak mendapatkan program kesehatan.
  - 2) Menyiapkan sarana dan prasarana Puskesmas dan rumah sakit sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat kurang mampu.
  - 3) Mengawasi dan memantau pelaksanaan Jamkesmas.
- e. Jaminan persalinan dasar
  - 1) Mengumpulkan informasi tentang orang hamil yang memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
  - 2) Menyediakan infrastruktur dan fasilitas untuk klinik dan rumah sakit yang memberikan layanan kepada ibu hamil.
  - 3) Mengawasi dan mengelola Jampersal.
- f. Intervensi remaja perempuan
  - 1) Mempersiapkan remaja perempuan yang akan menikah dengan memberikan penyuluhan
  - 2) Memberikan bantuan teknis kepada instruktur kursus calon pengantin.
- g. Fortifikasi pangan (penambahan vitamin A)
  - 1) Meningkatkan konsumsi makanan kaya vitamin A
  - 2) Menerapkan fortifikasi vitamin A pada minyak goreng curah dan media potensial lainnya
  - 3) Mengembangkan peraturan dan produk yang banyak mengandung minyak sawit merah.
- h. Pendidikan gizi masyarakat (promosi menyusui dan konseling individu/masyarakat)
  - 1) Melarang media massa memasang iklan susu formula
  - 2) Implementasi PP ASI ditingkatkan pengawasannya
  - 3) Tempat kerja dan fasilitas umum menyiapkan ruang ASI
  - 4) Melakukan penegakan hukum PP ASI
- i. Pengentasan kemiskinan (kegiatan pemberian cash bersyarat/conditional cash transfer dengan pendidikan gizi)
  - 1) Penambahan komponen intervensi gizi dan penyuluhan gizi pada kegiatan PKH
  - 2) Melakukan integrasi modul tentang gizi pada PNPM generasi
  - 3) Melakukan perluasan cakupan kegiatan PKH dan PNPM generasi
  - 4) Peningkatan kerjasama pada sektor kesehatan dengan sosial, dagri dan pendidikan
  - 5) Melakukan pelatihan petugas kesehatan di daerah pelaksana PKH dan PNPM generasi. (TNP2K, 2017)

## J. KEBERHASILAN INTERVENSI STUNTING BEBERAPA NEGARA

Sejumlah negara telah menerapkan program intervensi terhadap kelompok rentan stunting berupa gizi spesifik dan gizi sensitif. Program-program yang dilaksanakan oleh negara ini telah terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan kekayaan dan kemiskinan dalam masyarakat. Komitmen politik, kolaborasi multi-sektor, pemberian layanan terpadu, dan keterlibatan masyarakat dalam program semuanya berdampak pada keberhasilan program pengurangan stunting.

### 1. Brazil

Brazil sudah mengalami perbaikan kondisi dan status kesehatan dalam tiga dekade terakhir karena didukung kemajuan ekonomi yang pesat (penghasilan penduduk meningkat). Angka stunting anak usia di bawah 5 tahun menurun dari 37,1% (1974) menjadi 7,1% (2007), angka gizi kurang usia 1-2 tahun turun dari 20% menjadi 5%, anak yang mengalami wasting < 2%. Ada lima hal yang menyebabkan penurunan angka malnutrisi yaitu:

- a. Meningkatnya daya beli keluarga dengan meningkatkan minimum penghasilan dan program *cash-transfer*.
- b. Meningkatkan edukasi pada wanita.
- c. Meningkatkan dan memperluas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- d. Mengekspansi sistem air dan sanitasi meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi makanan keluarga petani.

Struktur politik, desentralisasi yang efisien, keterlibatan dan keuangan masyarakat, kebijakan dan inisiatif nasional untuk meningkatkan akses terhadap layanan sosial, serta suplementasi dan fortifikasi zat gizi mikro yang direkomendasikan oleh WHO untuk diterapkan pada pangan lokal merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan Brasil. (Acosta, 2011b)

### 2. Peru

Angka stunting turun pada tahun 2005 dari 22,9% menjadi 17,9%, anak malnutrisi turun sampai 9% pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Beberapa strategi yang dilakukan yaitu mengimplemnetasikan program CRECER (Strategi Nasional Melawan Anak Malnutrisi)) mulai tingkat nasional sampai distrik meliputi sektor kesehatan, edukasi, air, sanitasi, perumahan, agrikultura dan kerjasama dengan nonpemerintah, dilakukan juga program cash-transfer agar masyarakat miskin mampu meningkatkan daya beli kebutuhan rumah tangga, meningkatkan pendidikan, mampu membuka akses pelayanan kesehatan dan gizi. Hal tersebut membuktikan bahwa reformasi politik yang terjadi di Peru untuk mendukung integrasi nutrisi ke strategi proteksi sosial sangat mendukung. (Acosta, 2011a)(Chaparro, M.P and Estrada, 2012)

### 3. Bolivia

Program yang dilakukan yaitu Zero undermalnutrition yang melibatkan banyak sektor di berbagai level yaitu meliputi promosi ASI eksklusif, penggunaan makanan tambahan yang difortifikasi pada usia 6-23 bulan, intervensi peningkatan ketahanan pangan dan gizi, akses terhadap air bersih, sanitasi, edukasi, perawatan kesehatan dan gizi. Program ini mendukung keberlanjutan pertanian keluarga termasuk guinea pig dan ayam, produksi makanan pokok, kacang-kacangan dan sayuran, partisipasi keluarga dengan mengupayakan mengkonsumsi makanan hasil produksi sendiri dan mengaplikasikan 10 kunci makanan aman dan sehat. Dalam 8 bulan program implementasi survei menunjukkan bahwa 80% keluarga yang memiliki anak < 5 tahun dan mengkonsumsi hasil tani keluarga terbukti mampu menurunkan angka stunting yaitu dari 18,5% menjadi 13,5% pada anak di bawah 2 tahun.

### 4. India (Negara Bagian Maharashtra)

India adalah negara yang mempunyai jumlah anak stunting < 5 tahun terbesar di dunia yaitu 61,7 juta jiwa. Pada tahun 2005 angka stunting turun dari 44% menjadi 22,8% (tahun 2012) disebabkan misi kesehatan anak dan gizi Ibu Rajmata Jijau yang dicanangkan pada tahun 2005. Ada 3 point pada misi tersebut yaitu:

- a. Advokasi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan (HPK)
- b. Menyediakan sarana kebijakan untuk pemerintah berdasarkan bukti nyata hasil intervensi
- c. Menyediakan platform untuk mendorong konvergensi dengan tujuan untuk menurunkan malnutrisi

Misi ini meningkatkan keberlanjutan program dengan mempromosikan program berbasis komunitas dan dikelola langsung oleh komunitas, mendorong perubahan perilaku melalui penggunaan teknologi dan media (baik tradisional maupun modern), menggunakan materi pendidikan, dan pengumpulan data rutin untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi kesenjangan sosial. Salah satu dari enam target gizi global yang ditetapkan WHO pada tahun 2025 adalah mengurangi angka stunting pada anak usi di bawah 5 tahun hingga 40%. Mengurangi angka stunting merupakan prioritas dalam agenda nutrisi internasional.

## K. REFERENSI

- Acosta, A. . (2011a). *Analysing Succes in The Fight Against Malnutrition in Peru*.
- Acosta, A. . (2011b). *Examining The Political, Institutional and Governance Aspects of Delivering A National Multi-Sectoral Response to Reduce Maternal and Child Malnutrition*.
- Bappenas. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*.
- Chaparro, M.P and Estrada, L. (2012). Mapping The Nutrition Transition In Peru : Evidence for Decentralized Nutrition Policies. *Rev Panam Salud Publica*, 32(3), 241–244.
- Kemendes RI. (2018). *Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi*. <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/cegah-stunting-dengan-perbaikan-pola-makan-pola-asuh-dan-sanitasi>
- Kementerian Kesehatan RI. (2010). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Buku Pedoman Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gejala Dan Mencegah*. <https://promkes.kemkes.go.id/?p=8486> diakses 17 Desember 2022
- Keputusan Presiden, Pub. L. No. 42 (2013).
- Pakpahan, J. P. (2021). *Cegah Stunting dengan Pendekatan Keluarga*. Gava Media.
- Predergast, A.I and Humprey, J. . (2015). Stunting Persists Despite Optimal Feeding. *Nestle Nutrition Institute Workshop Series 2015*, 81, 99–110.
- Siti Helmyati dkk. (2022). *Stunting Permasalahan dan Penangannya*. Gajahmada University Press.
- TNP2K. (2017). *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. TNP2K-Unit Komunikasi.
- UNICEF. (2018). *Stunting*. <http://unicef.in/Whatwedo/10/Stunting>



# **BAB 2**

## **IMUNISASI BAYI BALITA DAN ANAK**

**Nuril Absari,S.SiT,M.Kes**



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**

# IMUNISASI BAYI BALITA DAN ANAK

Nuril Absari,S.SiT,M.Kes

## A. DEFINISI IMUNISASI

Imunisasi berasal dari kata imun,dimana artinya adalah kekebalan terhadap penyakit yang akan terjadi.seorang anak yang akan di imunisasi akan kebal terhadap penyakit tertentu berbeda dengan anak yang tidak diberi imunisasi. Imunisasi adalah pemberian vaksin kepada anak untuk mencegah penularan penyakit tertentu. Vaksin adalah zat yang berfungsi membantu membentuk kekebalan tubuh atau imunitas terhadap infeksi sejumlah penyakit menular.Vaksin berasal dari kuman yang dilemahkan atau dimatikan (Pertiwi,2021).

Imunisasi merupakan program pemerintah yang wajib dilaksanakan, dimana imunisasi efektif untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri,sehingga Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah ternyadinya penyakit pada bayi balita dan anak.

Imunisasi merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya suatu penyakit, sehingga dibutuhkan nya vaksin yang dapat merangsang pembentukan zat antibody seperti yang diberikan kepada bayi balita dan anak. Adapun imunisasi yang diberikan kepada bayi balita dan anak seperti vaksin BCG (Bacillus Calmette Guerin), Hepatitis B, DPT (Difteri,Pertusis,Tetanus),campak dan polio.

Menurut Kemenkes (2020), Pemerintah memfasilitasi pelayanan imunisasi secara rutin berdasarkan program yang telah dibuat diantaranya imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan untuk mendapatkan kekebalan awal secara aktif, sedangkan imunisasi lanjutan adalah imunisasi ulangan untuk mempertahankan kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan (booster).

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan ,masih utuh atau bagiannya atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan.(kemenkes 2017

Di Indonesia program imunisasi yang terorganisasi sejak tahun 1956,pada tahun 1974 dinyatakan bebas dari cacar, (Kemenkes, 2015). Imunisasi dikembangkan menjadi PPI (Program Pengembangan Imunisasi) pada tahun 1977, dalam upaya mencegah penularan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti tuberkolosis,difteri,pertusis,campak,polio, tetanus,serta hepatitis B. (Permenkes ,2017).

Berdasarkan laporan imunisasi rutin 2021 menunjukkan penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 9,5% dari 93,7% di tahun 2019 menjadi 84,2% di tahun 2021.dari tahun 2019 dari 72,7% terjadi penurunan sebesar 14,2% menjadi

65,3% di tahun 2020 untuk penyakit campak. Dampak penurunan cakupan tersebut dikarenakan peningkatan jumlah anak yang belum lengkap status imunisasinya.

Bulan imunisasi anak nasional atau disingkat BIAN merupakan Ada dua jenis imunisasi yang telah ditemukan terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Vaksin campak rubella dosis tunggal digunakan untuk mengimunisasi banyak orang tanpa memandang status imunisasi mereka saat ini, sesuai rekomendasi dari pasien.
2. Kegiatan imunisasi kejar berupa pemberian satu atau jenis imunisasi anak usia 12 sampai dengan 59 bulan.

## **B. TUJUAN IMUNISASI**

Tujuan imunisasi adalah mencegah terjadinya penyakit seperti Difteri, Tetanus, Hepatitis dan campak, sekaligus menghilangkan terjadinya virus dan bakteri yang menyebar pada kelompok masyarakat yang mudah terpapar. Tercapainya target Universal Child Immunization (UCI) yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% baik di desa maupun di perkotaan, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi balita dan anak. Menurut sriatmi dkk (2021), imunisasi perlu dilakukan hal ini dikarenakan imunisasi cepat aman dan sangat efektif (relatif Murah atau Cost Effektive), sekali diberikan imunisasi dimana kemampuan tubuh melawan penyakit akan lebih baik, apabila tidak diimunisasi maka anak beresiko lebih tinggi terkena penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan dan bahkan kematian

Imunisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit tidak hanya melindungi seseorang tetapi juga masyarakat, dan komunitas atau yang disebut dengan herd immunity (Kemenkes, 2022). Bagi Negara asing imunisasi sangat diwajibkan hal sehingga dijadikan salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran di sekolah tujuannya adalah agar semua anak dan warga sekolah terlindung dari penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin sehingga dapat menikmati hak belajarnya secara penuh di sekolah.

Menurut buku saku Tenaga kesehatan (2022), tujuan imunisasi adalah

1. Menghentikan virus transmisi, termasuk campak dan rubella, di salah satu kabupaten di Indonesia pada tahun 2023 dan mendapatkan sertifikasi eliminasi campak pada tahun 2025, meskipun tidak ada anak yang rentan campak dan rubella.
2. Mempertahankan Indonesia bebas polio dan mewujudkan eradikasi polio pada tahun 2026.
3. Mengendalikan penyakit difteri dan pertussis.

### **C. DAMPAK TIDAK DIBERIKAN IMUNISASI**

1. Anak yang tidak diberikan imunisasi sangat rentan terjadinya penyakit, dimana penyakit tersebut bias dicegah pada saat bayi lahir salah satu nya pemberian vaksin. Anak yang tidak diberikan imunisasi sangat rentan terkena penyakit seperti hepatitis, BCG dan batuk rejan serta difteri.
2. Penularan penyakit menjadi lebih tinggi misalkan anggota keluarga sedang terkena penyakit TBC, sehingga sangat beresiko menulari anak yang tidak imunisasi dibandingkan dengan anak yang menerima imunisasi. Orang dewasa atau masyarakat sekitar merupakan sumber infeksi utama pada balita, sehingga daapat menyebabkan kematian pada bayi balita dan anak.
3. Penyebaran wabah penyakit di lingkungan masyarakat, seperti dikalangan kelompok rentan yang dapat berkembang luas ke masyarakat. Pemerintah sangat mewajibkan memberikan imunisasi kepada anak agar penyakit dan kematian tidak bertambah.
4. Kualitas hidup terjadi penurunan dimana kesakitan dapat dicegah dengan vaksin yang mengakibatkan komplikasi, misalkan campak dapat mengakibatkan kebutaan adapun polio yang dapat terjadi kelumpuhan.
5. Penurunan harapan hidup  
Anak yang yang tidak di imunisasi lengkap dapat terjadi penurunan angka harapan hidup dimana beresiko terjadinya penyakit tertentu, sebaliknya yang diimunisasi lengkap sampai anak berusia lima tahun dapat memiliku harapan hidup lebih lama apabila tidak terkena penyakit. nilai harapan hidup sangat berperan penting terhadap peningkatan suatu penyakit seperti yang terjadi di papua, anak yang tidak diberi imunisasi lebih mudah terserang penyakit , berbeda dengan anak yang diberikan imunisasi secara rutin.

### **D. HAMBATAN IMUNISASI**

Perbedaan persepsi pada masyarakat tentang imunisasi merupakan suatu hambatan, dimana orang tua merasas ketakutan apabila anak demam,sering sakit, keluarga tidak mengizinkan,tempat imunisasi jauh, tidak tahu tempat imunisasi,sibuk dengan kegiatan (Kemenkes, 2015).

Pelayanan kesehatan seperti imunisasi harus terjangkau oleh masyarakat, dan dari segi dana bisa gratis, mudah terjangkau, dan memberikan informasi kepada masyarakat.

Menurut Sariatmi dkk, pemahaman tentang imunisasi yang dapat menyebabkan efek samping membahayakan seperti efk farmakologis,atau kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) serangkaian gejala atau reaksi tubuh yang tidak diinginkan yang muncul. adapun efek samping imunisasi & KIPI:

- a. Reaksi Tubuh pasien yang tidak diinginkan muncul setelah pemberian vaksin
- b. Dapat terjadi dengan tanda & Kondisi yang berbeda-beda

- c. Gejala efek samping dapat bertingkat dari ringan hingga yang serius seperti anafilaktik (alergi parah) yang dialami terhadap kandung vaksin.
- d. KIPi ringan bersifat lokal, berupa rasa nyeri, kemerahan dan Pembengkakan (infeksi) di area tubuh setelah imunisasi
- e. Respon sistemik dapat berupa demam, lemas, atau rasa tidak enak badan.

## **E. JENIS-JENIS IMUNISASI**

### **1. IMUNISASI Menurut IDAI (2020)**

Imunisasi merupakan imunisasi awal yang diberikan kepada bayi sebelum berusia satu tahun. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR (Kemenkes RI, 2018).

Imunisasi dasar merupakan salah satu imunisasi wajib yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adapun imunisasi yang wajib diberikan sampai umur 9 bulan, meliputi:

#### **a. Hepatitis B (HB-0)**

##### **1) Definisi**

Imunisasi yang diberikan pada bayi baru lahir sebanyak 1 kali suntikan, HB-0 salah satu vaksin yang dapat mencegah terjadinya seseorang terkena virus hepatitis B dapat menyebabkan sakit parah dibagian perut yaitu peradangan pada hati secara akut atau mengandung HbsAg dalam bentuk cair. Menurut Soedjatmiko dkk (2020), Bayi yang tidak mendapatkan vaksin HB pada siang hari memiliki risiko infeksi 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan bayi yang memiliki kekebalan pada siang hari.

##### **2) Waktu Pemberian**

Berdasarkan jadwal IDAI tahun 2017 imunisasi Vaksin hepatitis B ini dianjurkan diberikan dalam waktu umur 12 jam setelah lahir, setelah pemberian Vit K, sedangkan jadwal imunisasi tahun 2020 vaksin HB sebaiknya diberikan pada semua bayi baru lahir sebelum berumur 24 jam.

Pemberian imunisasi Hb o harus tepat waktu apabila dosis pertama diberikan 7 hari setelah bayi lahir, bayi yang lahir daribu HbsAg ( + ) beresiko infeksi meningkat 8,6 kali dibandingkan dengan pemberian vaksin setelah bayi lahir. (Soedjatmiko, 2020).

Berdasarkan WHO (2017), bayi dengan berat lahir kurang 2000 gr, imunisasi HB sebaiknya ditunda sampai berumur 1 bulan atau lebih, hal ini dikarenakan apabila bayi di vaksin Hb maka imun tubuhnya tidak

merespon seperti bayi dengan berat badan normal 2500 grm , tetapi apabila bayi sudah berusia 1 bulan madan respon imun sudah adekuat.

3) Cara dan dosis pemberian

Pemberian imunisasi hepatitis B yaitu Pemberian dapat diberikan secara intramuskular dengan dosis 0,5 ml atau 1 Hb Pid, antara paha lateral dan paha anterior. Dosis akan diberikan antara jam 0 dan 7 hari setelah itu diberikan pada interval 4 minggu atau 1 bulan.

4) Efek Samping

Imunisasi HB-0 memiliki efek samping seperti reaksi lokal diataralain rasa sakit dibagian penyutikan, kemerahan, bengkak disekitar penyutikan. Reaksi tersebut bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari.

b. DPT dan Hib

1) Definisi

Imunisasi DPT dan Hib merupakan vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit difteri tetanus , pertusis dan imunisasi haemophilus influenzae tipe B, yang merupakan infeksi akibat bakteri pada hidung dan tenggorokan sehingga dapat terjadi kerusakan pada bagian jantung, ginjal serta otak, pertusis suatu penyakit batuk rejan dimana terdapat bakteri sehingga terjadi infeksi pada bagian paru, dan tetanus suatu infeksi yang menyerang bagian saraf sehingga terjadi kekakuan pada otot serta hepatitis B mengakibatkan pneumonia atau peradangan pada paru-paru dan meningitis atau peradangan otak .

2) Jadwal pemberian

Imunisasi DPT dan Hib diberikan sebanyak 3 kali pada saat usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan kemudian dilanjutkan pada usia 18 bulan dan usia 5 tahun.

3) Cara dan dosis

Imunisasi DPT dan Hib disuntikan secara Intramuskular (IM) dibagian otot yaitu paha atas bagian depan dimana dosis yang diberikan sebanyak 0,5 ml, pemberian vaksin dibagian bokong perlu dihindari hal ini dapat berakibat luka syaraf.

4) Efek Samping

Imunisasi DPT hib memiliki efek samping seperti reaksi lokal yang ringan, demam dan nyeri pada bagian penyuntikan.

c. Imunisasi BCG

1) Definisi

Immunisasi BCG adalah immunisasi untuk mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis, penyakit TBC terdiri dari TBC otak dan TBC Miller yang terjadi di bagian Paru-paru atau Tulang.

2) Waktu pemberian

Immunisasi BCG diberikan segera bayi lahir sebelum bayi berusia 1 bulan, tetapi apabila bayi terlambat diberikan imunisasi BCG maka harus dilakukan uji Tes *Mantoux* untuk melihat apakah anak ini mengandung *mycobacterium* atau tidak, apabila negatif maka bisa dilakukan pemberian vaksin BCG, sebanyak 1 kali.

3) Cara dan dosis pemberian

Imunisasi BCG hanya diberikan 1 kali yang dimana 1 ampul vaksin diberikan 4 ml pelarut, dengan dosis 0,05 ml secara intracutan di daerah insertion deltonid muscle sebelah kanan.

4) Efek samping

Bayi yang sudah diberikan imunisasi BCG memiliki efek samping seperti terjadinya pembengkakan kelenjar betah benih di ketiak atau leher bagian bawah, demam pada tubuh, tetapi efek samping tersebut bisa hilang dalam beberapa hari.

d. Imunisasi polio/IPV

1) Definisi

Imunisasi polio merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit poliomyelitis dimana dapat menyebabkan terjadinya kelumpuhan pada bayi anak dan balita. Virus polio dapat menyerang sistem saraf pusat khususnya pada balita yang belum melakukan vaksinasi polio. Kandungan vaksin imunisasi ini adalah dengan cara virus dilemahkan.

2) Waktu pemberian

Imunisasi polio diberikan sebanyak 4 kali yaitu pada saat bayi lahir, bayi umur 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. pemberian imunisasi berikutnya akan diberikan pada usia 18 bulan dan 5 tahun, imunisasi polio selalu dibarengin dengan imunisasi DPT.

3) Cara dan dosis pemberian

Pemberian imunisasi polio diberikan secara oral melalui mulut, dimana diberikan dengan cara menggunakan penetes (Dropper) sebanyak 2 kali tetes untuk 1 kali dosis, apabila Vaksin polio yang sudah dibuka maka tidak boleh digunakan pada hari berikutnya dikarenakan kandungannya sudah tidak efektif.

4) Efek samping

Imunisasi polio memiliki efek samping seperti pusing, diare ringan, dan sakit otot tetapi untuk efek samping ini sangat jarang terjadi pada kasus pemberian imunisasi polio.

e. Imunisasi Campak

1) Definisi

Imunisasi campak merupakan vaksin yang digunakan untuk mencegah imunisasi campak dimana memberikan kekebalan pada penyakit campak atau measles, gondong dan rubella. Imunisasi campak memiliki kandungan virus campak yang dilemahkan seperti campak strain edmonston. campak salah satu imunisasi yang dijadikan program pemerintah yang wajib diberikan. Terdapat 2 jenis vaksin yang digunakan dalam mencegah campak yaitu MR ( campak dan rubella) dan MMR ( campak ,rubella dan gondong).

2) Jadwal pemberian

Pemerintah mewajibkan pemberian Imunisasi campak yang diberikan pada saat bayi berumur 9 bulan, namun menurut IDAI (Ikatan Dokter anak indonesia ) mengatakan bahwa pemberian imunisasi campak sebanyak 3 kali, disaat anak berumur 18 bulan dan 5-7 tahun dengan pemberian vaksin MR/MMR imunisasi ini disebut dengan imunisasi lanjutan.

3) Cara dan dosis pemberian

Pemberian imunisasi campak berdasarkan usia yaitu pada saat anak berusia 9 bulan yaitu imunisasi campak dengan dosis 0,5 ml yang disuntikan di bawah kulit Subkutan (SC), sedangkan imunisasi booster diberikan pada saat anak berumur 18 bulan dan 5-7 tahun dengan dosis 0,5 ml dengan cara intramuskular (IM).

4) Efek samping

Imunisasi campak memiliki efek samping seperti demam, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah ,nyeri otot diareja penyutikan, lemes dan terjadi nyeri serta kemerahan di arean penyutikan.

## 2. IMUNISASI TAMBAHAN

Immunisasi tambahan merupakan immunisasi yang tidak wajib diberikan, tetap hanya dapat diberikan berdasarkan hasil, pemantauan dan evaluasi. Seperti :

- a. Backlog Fighting , upaya aktif untuk melengkapi imunisasi dasar pada anak umur 1-3 tahun.
- b. Crush program, kegiatan yang ditujukan untuk wilayah yang memerlukan intervensi secara cepat khususnya pada masalah yang terjadi angka kematian bayi tinggi.
- c. Pekan imunisasi nasional, merupakan kegiatan pemerintah seperti kegiatan pekan imunisasi nasional polio (tOPV) pada tahun 2016 diseluruh provinsi, dimana cakupan mencapai 96,5% secara nasional.

### 3. IMUNISASI PENTAVALEN

Imunisasi pentavalen adalah imunisasi kombinasi antara imunisasi DPT-HB-Hib, dimana tidak melakukan suntikan beberapa kali hanya satu suntikan saja, vaksi pentavalen mencegah 7 penyakit menular yaitu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, tuberculosis, polio dan campak. Imunisasi pentavalen diberikan pada usia 2, 3 dan 4 bulan. Pemberian vaksi pentavalen sebaiknya diberikan pada bayi usia dibawah 6 bulan, tetapi apabila anak lupa diberikan imunisasi pentavalen saat anak berusia 1 tahun segera lakukan imunisasi dosis pertama selanjutnya dosis kedua dengan jarak 4 minggu, kemudian dosis ketiga 6 bulan.

Program imunisasi nasional pada tahun 2013 telah ditetapkan, dimana telah dikeluarkannya keppres RI nomor 23/MENKES/SK/I/2013, tentang pemberian imunisasi difteri, pertusis, hepatitis B, Haemophilus Influenza tipe b (Pentavalen) kedalam imunisasi program imunisasi nasional. Pentavalen merupakan pengembangan dari vaksin tetraavalen (DPT-HB) sehingga terdapat delapan antigen yang dapat diberikan pada anak, yaitu hepatitis B, polio oral (OPV), BCG, difteri, tetanus, pertusis, Hib, Campak, kedelapan antigen tersebut mencakup dalam lima jenis vaksin, yaitu Hepatitis B (uniject) OPV, BCG, kombinasi DPT/HB/Hib (pentavalen dan campak).

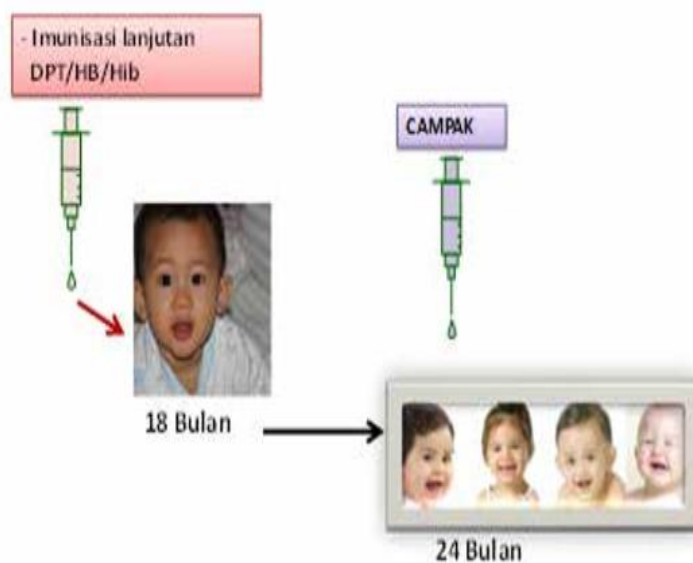
Pemberian imunisasi pentavalen masih tergolong rendah hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan hal yang penting terbentuknya perilaku seseorang.

### 4. IMUNISASI LANJUTAN

Menurut Kemenkes (2015), Imunisasi lanjutan merupakan imunisasi ulang yang tingkat kekebalannya lebih dan dapat memperpanjang masa perlindungan, imunisasi lanjutan diberikan kepada anak usia dibawah tiga tahun atau disebut dengan batita, dan anak sekolah SD. Imunisasi lanjutan sering disebut dengan imunisasi pentavalen, dimana imunisasi ini merupakan pengembangan vaksin seperti DPT-HB dengan penambahan antigen haemophilus influenza type b (Hib)

Berikut adalah contoh polis asuransi liabilitas:

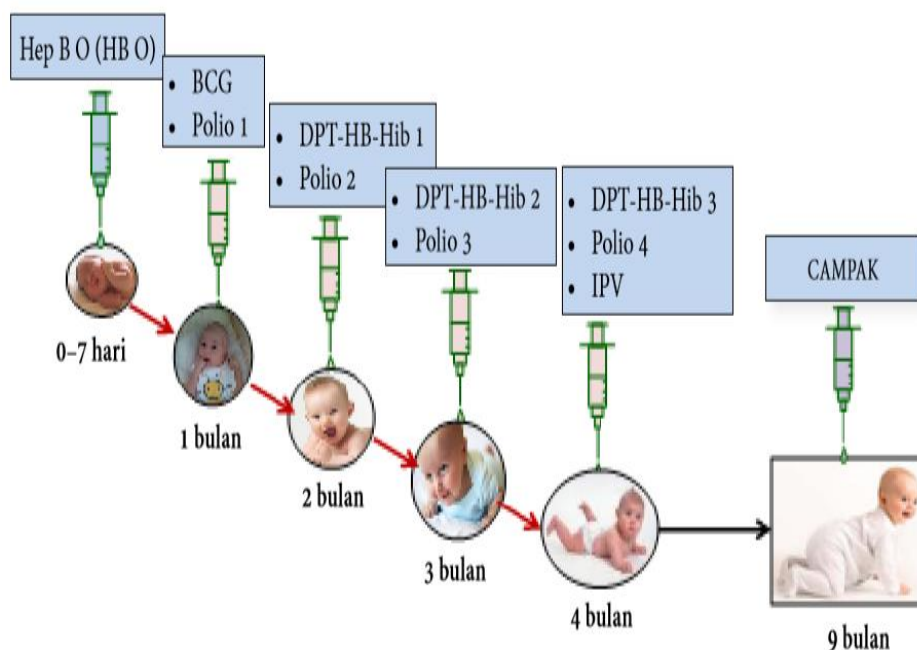
- a. DPT/HB/Hib pada umur 18 Bulan
- b. Campak 24 Bulan
- c. Campak dan DT di Saat anak kelas 1 SD
- d. TD saat anak kelas 2 & 5 SD



**Gambar 2.1 Jadwal Imunisasi Lanjutan pada Usia Batita (Hardiati dkk,2015)**

#### **F. JADWAL IMUNISASI**

Berdasarkan IDAI (2020), bahwa jadwal imunisasi terdapat perubahan dari rekomendasi sebelumnya dapat dilihat tabel dibawah ini.



**Gambari 2.2 Jadwal Imunisasi Dasar umur 0-12 Bulan (Hardiati dkk,2015)**

## PELAYANAN IMUNISASI

| UMUR                                           | BULAN                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
|                                                | 0                                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 18 | 2+ |  |
| Jenis Vaksin                                   | Tanggal Pemberian dan Paraf Petugas |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| Hepatitis B (< 24 jam)<br>No Batch:            |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| BCG<br>No Batch:                               |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| Polio tetes 1<br>No Batch:                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| DPT-HB-Hib 1<br>No Batch:                      |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| Polio tetes 2<br>No Batch:                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| DPT-HB-Hib 2<br>No Batch:                      |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| Polio tetes 3<br>No Batch:                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| DPT-HB-Hib 3<br>No Batch:                      |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| Polio tetes 4<br>No Batch:                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| Polio suntik (IPV)<br>No Batch:                |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| Campak – Rubella (MR)<br>No Batch:             |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| DPT-Hib-HB lanjutan<br>No Batch:               |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| Campak – Rubella (MR)<br>lanjutan<br>No Batch: |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |

### Keterangan:

- Jadwal tepat pemberian imunisasi dasar
- Waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar
- Waktu Pemberian imunisasi bagi anak di atas 1 tahun yang belum lengkap
- Waktu yang tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar

Gambar 2.3 Jadwal imunisasi Buku KIA kemenkes 2020

## Jadwal Imunisasi Anak Umur 0-18 tahun Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Tahun 2020

| Imunisasi   | Umur   |   |   |   |   |       |    |   |    |                                     |                             |    |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
|-------------|--------|---|---|---|---|-------|----|---|----|-------------------------------------|-----------------------------|----|---|----------|---|---|---|---|----|--------------------------|-------------------------------|----|----|----|
|             | Bulan  |   |   |   |   |       |    |   |    | Tahun                               |                             |    |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
|             | Lahir  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6  | 9 | 12 | 15                                  | 18                          | 24 | 3 | 5        | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12                       | 14                            | 15 | 16 | 18 |
| Hepatitis B | 1      |   | 2 | 3 | 4 |       |    |   |    |                                     | 5                           |    |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
| Polio       | 0      | 1 | 2 | 3 |   |       |    |   |    |                                     | 4                           |    |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
| BCG         | 1 kali |   |   |   |   |       |    |   |    |                                     |                             |    |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
| DTP         |        | 1 | 2 | 3 |   |       |    |   |    |                                     | 4                           |    |   | 5        |   |   |   |   |    |                          | Td / Tdap                     |    |    |    |
| Hib         |        | 1 | 2 | 3 |   |       |    |   |    |                                     | 4                           |    |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
| PCV         |        | 1 | 2 |   |   |       |    |   | 4  |                                     |                             |    |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
| Rotavirus   |        | 1 | 2 |   |   | 3 (p) |    |   |    |                                     |                             |    |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
| Influenza   |        |   |   |   |   | 1     |    |   |    |                                     | Diulang setiap tahun 1 kali |    |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
| MR / MMR    |        |   |   |   |   |       | MR |   |    |                                     | MR / MMR                    |    |   | MR / MMR |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
| JE          |        |   |   |   |   |       | 1  |   |    |                                     |                             | 2  |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
| Varisela    |        |   |   |   |   |       |    |   |    | 2 kali, interval 6 minggu - 3 bulan |                             |    |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
| Hepatitis A |        |   |   |   |   |       |    |   |    | 2 kali, interval 6 - 36 bulan       |                             |    |   |          |   |   |   |   |    |                          |                               |    |    |    |
| Tifoid      |        |   |   |   |   |       |    |   |    |                                     | 1                           |    |   |          |   |   |   |   |    |                          | Diulang setiap 3 tahun 1 kali |    |    |    |
| HPV         |        |   |   |   |   |       |    |   |    |                                     |                             |    |   |          |   |   |   |   |    | 2 kali                   |                               |    |    |    |
| Dengue      |        |   |   |   |   |       |    |   |    |                                     |                             |    |   |          |   |   |   |   |    | 3 kali, interval 6 bulan |                               |    |    |    |

avaliatiah.com - sumber : www.idai.or.id

Gambar 2.4 Jadwal Imunisasi IDAI 2020 Dari Website Resmi IDAI

#### Ket Gambar 2.4



- Jadwal tepat pemberian imunisasi
- Waktu yang masih diperbolehkan untuk melakukan imunisasi
- Waktu yang blum diperbolehkan untuk imunisasi
- Waktu pemberiaan imunisasi bagi anak diatas 1 tahun yang belum lengkap

### G. PERSIAPAN DALAM PEMBERIAN IMUNISASI

Persiapan pemberian imunisasi berdasarkan tempat pelayanan menurut buku saku tenaga kesehatan pos pelayanan BIAN (bulan imunisasi anak nasional) (2022).

#### 1. Tempat pelaksanaan

Pemberian immunisasi dilaksanakan di fasilitas pelayanan tenaga kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit, pemerintah, klinik, rumah sakit swasta, praktik bidan dan dokter anak, dan lainnya. Pos pelayanan imunisasi merupakan suatu program pemerintah yang biasanya dilakukan di sekolah atau satuan pendidikan, pos pelayanan komunitas seperti posyandu, lapangan drive thru, puskesmas keliling, atau pelayanan kesehatan bergerak lainnya.

#### 2. Penyiapan vaksin dan logistic

Vaksin dan logistic yang perlu disiapkan sebelum dilakukan imunisasi adalah

- a. Vaksin : jumlah vaksin di sesuaikan berdasarkan perhitungan kebutuhan
- b. Pelarut vaksin : sesuaikan jumlah vaksin campak rubella
- c. Dropper : sesuaikan jumlah vaksin polio
- d. Sput, Safety box,kapas : disesuaikan berdasarkan kebutuhan
- e. Formulir pencatatan dan pelaporan cakupan dan logistic
- f. APD,masker,: sesuaikan jumlah tim medis

g. Alat pengukur suhu : sesuaikan dengan kebutuhan

Sebelum melakukan pemberian pastikan vaksin dalam keadaan baik seperti :

- a. Belum kadaluarsa
- b. VVM masih A atau B
- c. Disimpan pada suhu yang direkomendasikan
- d. Label masih ada
- e. Tidak terendam air

3. Langkah –langkah melarutkan vaksin

- a. Menyimpan larutan di lemari es dengan suhu 2-8<sup>0</sup> C sehari minimal 12 jam sebelum pelayanan
- b. Simpan pearut dalam vaccine carrier agar pada saat pelaksanaan suhu vaksin tetap terjaga
- c. Vaksin yang telah dilarutkan hanya bisa diberikan pada saat sasaran sudah datang dan langsung di imunisasikan
- d. Menggunakan 1 ADS 5 mililiter untuk melarutkan satu vial vaksin
- e. Mengganti spuit suntik pada saat akan disuntikan ke sasaran
- f. Cek kembali apakah 5 mililiter cairan pelarut vaksin terhisap dalam ADS, apabila sudah maka dapat mencampurkan dengan serbuk vaksin kering seperti campak rubella
- g. Pelarut dimasukan secara pelan ke dalam botol vaksin agar tidak terjadi gelembung udara.
- h. Catat tanggal dan jam pelarut pada vial vaksin.
- i. Memperhatikan sterilisasi dan asptik pada saat melakukan prosedur.
- j. Vaksin campak rubella yang sudah dilarutkan hanya bisa digunakan dalam waktu 6 jam
- k. Vaksin harus dibuang apabila terkontaminas seperti vial jatuh terkena meja atau tempat yang tidak steril

4. Perencanaan safety box

Safety box merupakan tempat menampung bekas alat suntik dan vial, safety box yang disiapkan berukuran **2,5 liter** yang dapat menampung 50 alat suntik bekas, sedangkan ukuran **5 liter** dapat menampung sampai 100 alat suntik bekas. (Hardianti,2015)

## H. PENYIMPANAN VAKSIN

Dalam menjaga kualitas vaksin agar tetap terjaga dibutuhkan tempat penyimpanan vaksin seperti cool box disposable, cool box reusable, cold pack, vaksin carrier, thermos. Adapun cara penyimpanan vaksin:

- a. Vaksin polio disimpan pada suhu -150 s/d -250C pada freeze room.
- b. b. Vaksin hepatitis B khususnya bidan desa dapat disimpan pada suhu ruangan dan terlindung dari sinar matahari langsung.

## I. REFERENSI

- Ahmad dkk 2017, determinan yang mempengaruhi status imunisasi pentavalen (DPT/HB/Hib) booster di wilayah kerja puskesmas kampala kabupaten sinjai.[http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NzUyY2M1MzJhNmZiMjQ3Mzk3NDNiNjU2NWNlMGViMzVlMz1Yzg2Zg==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NzUyY2M1MzJhNmZiMjQ3Mzk3NDNiNjU2NWNlMGViMzVlMz1Yzg2Zg==.pdf).
- Hardianti dkk, BUKU AJAR IMUNISASI GAVI KEMENKES file:///F:/TUGAS%20CHAPTER%20BUKU%20NEONATUS/03Buku-Ajar-Imunisasi-06-10-2015-small.pdf. 2015
- Itsa. faktor-faktor yang berhubungan dengan status imunisasi lanjutan pentavalen (DPT-HB-Hib) di Wilayah Kerja Puskesmas Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun 2018
- Kementerian kesehatan peraturan menteri kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ,2017, [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/PMK\\_No.\\_12\\_ttg\\_Penyelenggaraan\\_Imunisasi\\_.pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._12_ttg_Penyelenggaraan_Imunisasi_.pdf). 2017
- Kementerian kesehatan peraturan menteri kesehatan Kemenkes petunjuk teknis bulan imunisasi anak nasional (BIAN) file:///C:/Users/user/Downloads/files34450Juknis%20Pelaksanaan%20BIAN%202022%20(1).pdf. 2020
- Miko dkk. Jadwal Imunisasi anak Umur 0-18 Tahun Rekomendasi IDAI file:///C:/Users/user/Downloads/1900-6059-2-PB%20(2).pdf. 2020
- Sriatmi ,dkk ,Buku Saku mengenal imunisasi rutin lengkap [https://doc-pak.undip.ac.id/11407/1/Mengenal\\_IMUNISASI\\_RUTIN LENGKAP.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/11407/1/Mengenal_IMUNISASI_RUTIN LENGKAP.pdf). 2020
- Tiani dkk,peran petugas kesehatan dalam pemberian vaksinasi pentavalen jurnal ilmu keperawatan 2016

# **BAB 3**

## **MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT**

**Royani Chairiyah, S.SiT, M.Kes, M.Keb**



## **MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT**

Royani Chairiyah, S.SiT, M.Kes, M.Keb

### **A. PENDAHULUAN**

Integrated Management of Sick Toddlers (MTBS) atau dalam bahasa Inggris, Integrated Management Of Childhood Illness (IMCI) adalah penatalaksanaan melalui pendekatan terpadu dalam pengelolaan balita sakit yang mencari pelayanan kesehatan, dengan mempertimbangkan berbagai klasifikasi penyakit, status gizi, status imunisasi, serta penanganan balita sakit dan penyuluhan yang ditawarkan (Depkes RI., 2008)

Ada strategi yang cukup efektif untuk menghentikan sebagian besar kematian ini, dan itu adalah mengobati anak-anak dengan penyakit seperti pneumonia, diare, campak, dan malaria di rawat jalan, terutama puskesmas, menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Cara lain untuk berpikir tentang manajemen terpadu balita sakit adalah pendekatan terpadu yang mencakup upaya kuratif untuk kondisi seperti pneumonia, diare, campak, malaria, dan kekurangan gizi serta upaya promosi dan pencegahan seperti imunisasi, penyediaan vitamin A, dan konseling pemberian makan yang bertujuan menurunkan angka kematian bayi dan balita dan menekan morbiditas yang disebabkan oleh penyakit ini. (Depkes RI, 2006)

MTBS adalah teknik untuk mengelola balita yang sakit daripada program kesehatan. Dalam upaya untuk menurunkan angka kematian, morbiditas, dan gangguan bayi dan balita, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengakui bahwa strategi MTBS sangat cocok untuk diadopsi di negara-negara berkembang. (Prasetyawati, 2012)

### **B. TUJUAN MTBS**

Meningkatkan standar perawatan untuk layanan kesehatan dasar dan mendukung perluasan perkembangan kesehatan anak untuk secara signifikan menurunkan tingkat morbiditas dan mortalitas global terkait dengan penyakit utama yang mempengaruhi anak-anak di bawah usia lima tahun. MTBS yang dilaksanakan dengan baik dapat mempromosikan dan meningkatkan pengetahuan bagi para ibu dalam merawat anak-anak mereka di rumah dan upaya mengoptimalkan sistem rujukan dari komunitas ke fasilitas perawatan primer dan rumah sakit sebagai rujukan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019) Ini juga dapat meningkatkan upaya penemuan kasus awal, penanganan, dan manajemen pengobatan.

### C. MANFAAT MTBS

Inisiatif MTBS adalah tindakan yang diambil untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas sekaligus meningkatkan standar layanan kesehatan esensial, seperti di Puskesmas. Lebih dari 100 negara telah mengadopsi MTBS, yang telah terbukti:

1. Menurunkan angka kematian balita;
2. Meningkatkan status gizi; dan
3. Meningkatkan penggunaan pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan efisiensi profesional kesehatan.
5. Memberikan layanan yang lebih baik dengan biaya lebih murah.

Selain itu, ada tiga elemen kegiatan MTBS yang terpisah dan menguntungkan, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan profesional dalam administrasi kejadian yang melibatkan anak sakit (tenaga kesehatan yang bukan dokter juga dapat menilai dan menangani pasien jika telah mendapatkan pelatihan).
2. Meningkatkan sistem perawatan kesehatan (mewujudkan penyatuan berbagai program kesehatan ke dalam satu ujian MTBS)
3. Meningkatkan praktik perawatan masyarakat dan keluarga dan mencari bantuan untuk anak-anak yang sakit (meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam layanan kesehatan).

### D. TUJUAN MTBS

Target MTBS adalah anak usia 0-5 tahun dan dibagi menjadi dua kelompok sasaran, yaitu: a. kelompok usia 1 hari sampai 2 bulan (usia < 2 bulan) b. kelompok usia 2 bulan sampai 5 tahun

### E. TATALAKSANA MTBS

Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) memerlukan sejumlah proses untuk mengobati kekurangan gizi balita, pneumonia, diare, malaria, dan campak.

Langkah-langkah untuk manajemen terpadu balita sakit dijelaskan di bawah ini:

**Menilai dan membuat klasifikasi anak sakit “Menilai anak” berarti melakukan penelian terhadap tanda dan gejala sakit yang muncul pada anak usia 2 bulan-5 tahun dengan cara anamnesis dan pemeriksaan fisik (Depkes RI, 2006)**

Proses anamnesis dan pemeriksaan fisik tersebut dimulai dari:

- a. Dapatkan usia anak.
- b. Beri tahu ibu tentang masalah kesehatan yang dialami anak-anak mereka
- c. Cari bendera merah yang khas.

Berikut ini adalah tanda bahaya umum pada anak sakit: (Depkes RI, 2006)

- a. Anak tidak dapat menetek atau minum. Jika seorang anak tidak dapat mengisap atau menelan ketika diberi minum atau menetek, mereka akan menunjukkan gejala "tidak bisa minum atau menetek".
  - b. Anak selalu "memuntahkan semuanya" terlihat pada balita yang tidak bisa menelan apa pun. Kalau saja apa yang dikonsumsi (makanan atau cairan) dikeluarkan lagi. Tidak ada indikasi generalisasi jika anak masih bisa menelan sejumlah kecil cairan.
  - c. Kejang pada anak-anak  
Lengan dan kaki anak menegang selama kejang karena otot-otot menyempit.
  - d. Seorang anak letargis atau tidak sadar. Seorang anak yang lelah atau tertidur sulit untuk terbangun karena ia hadir dengan ekspresi kosong atau tampaknya tidak menyadari lingkungannya.
    - 1) Tanyakan tentang empat keluhan utama anak ibu, yaitu: batuk dan masalah pernapasan, diare, demam, dan masalah telinga.
    - 2) Memeriksa dan mengkategorikan anemia dan status gizi.
    - 3) Tentukan apakah anak memerlukan vaksin dan / atau vitamin pada kunjungan dengan meninjau riwayat imunisasi anak dan pemberian vitamin A kepada anak.
    - 4) Periksa masalah atau keluhan lebih lanjut yang mungkin dimiliki anak.
- (Depkes RI, 2006)

Setelah mengevaluasi gejala dan indikator yang terlihat, lanjutkan ke mengklasifikasikan kondisinya. "Membuat Klasifikasi" mengacu pada menentukan kemungkinan penyakit atau masalah serta tingkat keparahannya. (Depkes RI, 2006)

Setelah mengevaluasi tanda dan gejala yang baru muncul, yang dikategorikan berdasarkan kelompok darurat, kategorisasi dibuat. Klasifikasi termasuk untuk dehidrasi, diare persisten, disentri, malaria, campak, DBD, masalah telinga, dan status gizi.

## **F. BATUK ATAU SUKAR BERNAPAS**

Anak-anak yang terutama mengeluh batuk dan masalah pernapasan harus dievaluasi dan diklasifikasikan karena mereka bisa menderita pneumonia atau penyakit pernapasan serius lainnya.

### **1. Penilaian anak yang batuk atau sukar bernafas meliputi:**

- a. Sudah berapa lama anak batuk atau sukar bernafas. Anak dengan batuk atau sukar bernafas selama lebih dari 30 hari berarti anak menderita batuk kronis. Kemungkinan ini adalah tanda TBC, asma, batuk rejan, pneumonia, atau

penyakit lain. Klasifikasi batuk atau sukar bernapas pada umumnya klasifikasi mempunyai tiga kolom:

- 1) Anak harus segera dirujuk jika klasifikasi mereka di kolom merah muda menunjukkan bahwa mereka membutuhkan bantuan. Kategori ini membawa banyak bobot.
  - 2) Anak yang tergolong dalam kolom kuning memerlukan penanganan khusus, seperti pemberian antibiotik, antimalaria, cairan yang dipantau, atau obat lain.
  - 3) Klasifikasi anak sebagai berada di jalur hijau menunjukkan bahwa tidak diperlukan perawatan medis tertentu; Sebaliknya, profesional kesehatan menginstruksikan ibu tentang cara merawat anak-anak di rumah. Ketika anak-anak batuk atau hanya bernapas, ada tiga kategori yang berbeda.
- b. Dengan menghitung berapa kali seorang anak bernapas dalam satu menit, adalah mungkin untuk menentukan apakah mereka bernapas dengan cepat. Usia anak menentukan seberapa cepat mereka bisa bernapas. Anak usia dua bulan hingga satu tahun hanya bisa bernapas dengan cepat hingga 50 kali per menit, sedangkan anak usia satu sampai lima tahun hanya bisa bernapas dengan cepat hingga 40 kali per menit.
- c. Tarikan dinding kedalam  
Jika dinding dada bagian bawah bergerak ke dalam saat anak menarik napas, anak dikatakan memiliki tarikan ke dalam dari dinding dada. Karena ketika seorang anak menghirup secara normal, seluruh dinding dada — atas dan bawah — dan perut bergerak ke luar. Menurut laporan, penarikan dinding dada ke dalam konstan dan mudah terlihat. Tapi itu tidak dianggap sebagai tarikan ke dalam dari dinding dada jika tarikan ke dalam terjadi tepat ketika anak menangis atau diberi makan.
- d. Stridor pada anak yang tenang  
Ketika anak itu menarik napas, buntukan kasar yang disebut stridor dapat didengar. Ketika laring, trakea, atau epiglotis membesar, itu menyebabkan penyumbatan dan stridor. Kehidupan anak dalam bahaya karena udara masuk ke paru-paru mereka. Wheezing berbeda dengan stridor. Sementara wheezing terjadi ketika Anda menghembuskan napas, stridor terjadi ketika Anda menarik napas (Depkes RI, 2006)

Setelah menyelesaikan penilaian, klasifikasi penyakit ditentukan. Untuk anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda batuk dan masalah pernapasan, ada tiga klasifikasi penyakit yang berbeda, dan mereka adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Klasifikasi Penyakit Dengan Gejala Batuk dan Sukar Bernafas**

| Gejala                                                               | Klasifikasi     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ada tanda bahaya umum<br>♣ Tarikan dinding dada kedalam<br>♣ Stridor | Pneumonia Berat |

Napas cepat

Radang Paru-Paru

Tidak ada tanda pneumonia berat atau pneumonia      Batuk Bukan Pneumonia

## 2. Menentukan tindakan dan memberi pengobatan

Menurut klasifikasi jenis penyakit yang sudah ditentukan, "menentukan tindakan dan memberikan pengobatan" mengacu pada menentukan tindakan dan pengobatan di institusi kesehatan (Depkes RI, 2006)

Jika seorang anak menderita pneumonia berat atau penyakit yang sangat serius, tindakan pertama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Ini sesuai dengan manajemen terpadu balita sakit:

- Berikan antibiotik dosis pertama Pilihan pertama adalah kontrimoksazol dan pilihan kedua adalah amoksisilin dengan kondisi dosis yang tepat yang tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 3.2 Pemberian Antibiotik Pada Penderita Pneumonia**

| Usia atau Berat Badan | Kotrimoksazol (trimetoprim + sulfametoksazol) beri 2 kali sehari selama 5 hari |                                    |                                      | Amoksisilin beri 3 kali sehari untuk 5 hari |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|                       | Tablet dewasa 80 mg Tmp + 400 mg Smz                                           | Tablet anak 20 mg Tmp + 100 mg Smz | Sirup per 5 ml 40mg Tmp + 200 mg Smz | Sirup 125 mg/5 ml                           |
| 2-4 bulan (4- <6)     | 1/4                                                                            | 1                                  | 2,5 ml (0,5 sendok takar)            | 5 ml (1 sendok takar)                       |
| 4-12 bulan (6- <12)   | ½                                                                              | 2                                  | 5 ml (1 sendok takar)                | 10 ml (2 sendok takar)                      |
| 3-5 tahun (15- <19kg) | 1                                                                              | 3                                  | 10 ml (2 sendok takar)               | 15 ml (3 sendok takar)                      |
| (0,5 sendok)          | (0,5 sendok)                                                                   | (0,5 sendok)                       | (0,5 sendok)                         | (0,5 sendok)                                |

(Sumber : Departemen Kesehatan RI,1999).

Antibiotik pilihan kedua (Amoksisilin) diberikan hanya jika obat pilihan pertama tidak tersedia atau jika obat pilihan pertama tidak menghasilkan hasil yang lebih baik.

b) Lakukan rujukan segera

Jika diagnosis hanya pneumonia, ibu diinstruksikan untuk kembali dalam dua hari dan antibiotik yang sesuai diberikan selama lima hari bersama dengan tablet hisap dan penekan batuk. Sambil menunggu temuan kategorisasi, jika ternyata pasien mengalami batuk daripada pneumonia, langkah selanjutnya adalah memberi mereka tablet hisap atau penekan batuk aman lainnya, melakukan pengujian tambahan, dan menyarankan mereka kapan harus segera kembali ke rumah sakit (Hidayah, 2008).

**3. Memberikan penyuluhan kepada ibu Pemberian konseling yang dapat dilakukan pada manajemen terpadu balita sakit umur 2 bulan - < 5 tahun umumnya adalah sebagai berikut:**

- a. Konseling pemberian makan pada anak Pemberian konseling makan pada anak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Tentukan cara terbaik untuk memberi makan bayi dengan mencari tahu seberapa sering ibu menyusui di siang hari, apakah dia juga menyusui di malam hari, dan apakah anak telah memiliki makanan atau cairan tambahan. Jika berat badan anak di bawah rata-rata, pertanyaan tentang berapa banyak makanan atau cairan yang diterima anak dan apakah diet mereka diubah dapat ditingkatkan.
  - 2) Berikan teknik menyusui yang dianjurkan ibu, yaitu sebagai berikut: ASI harus diberikan kepada bayi usia 0-6 bulan sesering yang mereka minta, setidaknya 8 kali total, dan tidak ada makanan lain yang harus ditawarkan.
  - 3) Setidaknya delapan kali ASI harus diberikan kepada anak di bawah usia enam bulan, bersama dengan dua sendok makanan pendamping yang diberikan dua kali sehari. Setelah menyusui, lebih banyak makanan ditawarkan. Makanan tambahan ini dapat berupa bubur tim yang disempurnakan dengan telur kuning, ayam, ikan, tempe, tahu, daging sapi, sayuran, atau kacang hijau.
  - 4) ASI harus diberikan kepada bayi antara usia enam dan dua belas bulan, bersama dengan bubur nasi yang dapat dilengkapi dengan makanan tinggi protein, seperti daging, unggas, ikan, dan sayuran. Pemberian makan terjadi tiga kali, dengan aturan bahwa usia 6 bulan berarti 6 sendok makan, usia 7 bulan berarti 7 sendok makan, dan seterusnya sampai usia 11 bulan. Selain itu, dua kali sehari, minuman seperti bubur kacang hijau, kerupuk, atau makanan ringan lainnya disediakan.
  - 5) ASI harus diberikan antara usia 12 dan 24 bulan, bersama dengan nasi lembek, telur, unggas, ikan, tempe, tahu, daging sapi, sayuran, dan kacang hijau. Tiga kali makan setiap hari dilengkapi dengan dua

makanan selingan makanan ringan seperti pisang, biskuit, dan makanan lainnya, serta bubur kacang hijau.

- 6) Memberi makanan yang dimakan keluarga tiga kali sehari — nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah — dimulai pada usia dua tahun lagi. Selain itu, camilan sehat ditawarkan dua kali di antara waktu makan utama.
  - 7) Ketika bayi menerima makanan tambahan dan berusia di bawah 4 bulan, ibu diberi konseling dan dianjurkan untuk menyusui sesering mungkin karena dia dapat membuat ASI yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak.
  - 8) Jika ibu menggunakan botol untuk menyusui, dia didesak untuk beralih ke gelas atau cangkir sebagai gantinya.
  - 9) Jika anak menolak untuk makan, ibu harus diberi tahu tentang cara membuat anak mau makan dan bagaimana mengamati makanan yang dinikmati anak dengan memperhitungkan makanan yang diizinkan.
  - 10) Jika bayi kekurangan gizi saat sakit, nasihati ibu untuk menyusui lebih sering dan untuk jangka waktu yang lebih lama serta memberi anak berbagai makanan dalam porsi kecil tetapi sering.
- b. Saran tentang cara minum cairan saat sakit. Ibu disarankan untuk memberi anak cairan yang dia butuhkan saat mereka tidak sehat. Ibu harus bisa menyusui lebih lama dan lebih sering jika bayi masih minum ASI. Ibu juga dapat meningkatkan kebutuhan cairan bayi mereka dengan memberi mereka sup sayuran, air pati, dan air.
- c. Konseling kunjungan ulang
- Jika anak menunjukkan salah satu gejala berikut, ibu harus menerima konseling mengenai perlunya kunjungan tindak lanjut:
- 1) Dalam waktu yang ditentukan ibu harus segera membawa balita tersebut ke petugas kesehatan.
  - 2) Pada klasifikasi pneumonia lakukan kunjungan setelah 2 hari. Begitu juga dengan klasifikasi disentri, malaria, DBD, campak, ataupun demam (Aziz Alimul Hidayat, 2008).
- d. Layanan setelah kunjungan harus disediakan. Menentukan tindakan dan pengobatan ketika anak kembali untuk kunjungan kedua disebut sebagai "tindak lanjut" (Depkes RI, 2006).
- Petugas MTBS dapat menentukan apakah anak membaik pada saat janji tindak lanjut setelah menerima obat atau perawatan lain sebelumnya. Karena beberapa anak mungkin tidak bereaksi terhadap beberapa antibiotik, obat cadangan diperlukan. Kunjungan berikutnya memerlukan tindakan yang berbeda dari kunjungan awal. Pada saat penunjukan awal, terapi biasanya juga bervariasi (Depkes RI, 2006)

Anak-anak dengan pneumonia, diare berulang, disentri, risiko malaria, campak, DBD, masalah telinga, dan status gizi biasanya menerima perawatan lanjutan (Hidayat, 2008). Dua hari setelah evaluasi awal dengan klasifikasi pneumonia, layanan tindak lanjut disediakan. Tindakan berikut dilakukan pada kunjungan berikutnya:

- a) Jika dinding dada menarik ke dalam atau ada sinyal peringatan lainnya, berikan satu dosis antibiotik pilihan kedua atau injeksi kloramfenikol dan konsultasikan dengan dokter satu kali.
- b) Jika frekuensi pernapasan atau nafsu makan anak tidak membaik, beralihlah ke antibiotik lain atau beri tahu ibu untuk kembali dalam dua hari (jika tidak ada pilihan lain atau jika anak menderita campak dalam tiga bulan terakhir, segera kirim pasien).
- c) Terus berikan antibiotik selama total 5 hari jika pernapasan melambat atau nafsu makan membaik. Dalam situasi ini, ibu harus memahami nilai dari terus minum obat bahkan jika kondisi anak mereka membaik (Depkes RI, 2006)

Bagan berikut menunjukkan bagaimana balita yang tidak sehat antara usia dua bulan dan lima tahun dikelola untuk klasifikasi pneumonia berdasarkan diskusi di atas:

#### PERIKSA TANDA-TANDA BAHAYA UMUM

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tanyakan: Lihat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisakah anak minum atau menipu?<br/>Apakah anak muncul</li> <li>2. Apakah anak selalu membisukan semuanya? lesu atau tidak sadar?</li> <li>3. 3. Apakah anak mengalami kejang?</li> </ol> | <p>Lihat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisakah anak minum atau menipu?<br/>Apakah anak muncul</li> <li>2. Apakah anak selalu memutahkan semua?<br/>letargis atau tidak sadar?</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Seorang anak dengan bendera merah umum membutuhkan perawatan segera, selesaikan penilaian ini dan segera lakukan perawatan, sehingga rujukan tidak akan terlambat.

**TANYAKAN KELUHAN UTAMA:** Apakah anak menderita batuk atau sulit bernafas?

Apakah anak menderita batuk atau sulit bernafas?

| <p>Jika demikian, tanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lihat, dengar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hitung pernapasan dalam 1 menit</li> <li>▪ Perhatikan apakah ada tarikan dinding dada ke dalam</li> <li>▪ Melihat dan mendengar kehadiran stridor</li> </ul> | <p>Klasifikasikan batuk atau sulit bernafas</p> | GEJALA                                                                                                                 | KLASIFIKASI                                 | TINDAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada tanda bahaya umum</li> <li>- Tarikan dinding dada ke dalam</li> </ul>     | <p><b>Radang paru-paru sangat berat</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan antibiotic dosis pertama yang sesuai</li> <li>- Rujuk segera</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napas cepat</li> </ul>                                                        | <p><b>Radang paru-paru</b></p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beri antibiotik yang tepat selama 5 hari.</li> <li>- Berikan tablet hisap dan penghilang batuk yang aman</li> <li>- Saran ibu Kapan harus kembali</li> </ul>                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada tanda bahaya <i>pneumonia</i> atau penyakit sangat berat</li> </ul> | <p><b>Batuk: tidak Radang paru-paru</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika batuk &gt;30 hari, lihat untuk pemeriksaan lebih lanjut</li> <li>- Memberikan tablet hisap dan sirkulasi batuk yang aman</li> <li>- Menasihati ibu kapan harus kembali</li> <li>- Tinjau kembali setelah 5 hari bila tidak ada perbaikan</li> </ul> |

## G. PEMERIKSAAAN DIARE

Langkah-langkah dalam pemeriksaan diare meliputi:

Menanyakan apakah anak menderita diare

1. Menanyakan: berapa lama, dan adakah darah dalam tinja.
2. Melihat dan meraba: lihat keadaan umum anak, apakah letargis atau tidak sadar, gelisah dan rewel, mudah marah.
3. Melihat apakah matanya cekung.
4. Memberikan minum anak, apakah tidak bisa minum atau malas minum, apakah haus dan minum dengan lahap.
5. Mencubit kulit perut untuk mengetahui turgor kulit, apakah kembalinya sangat lambat lebih dari 2 detik atau lambat.

Klasifikasi Diare:

### 1. Klasifikasi Diare Dengan Dehidrasi Berat

Penilaian 2 Atau Lebih Gejala Berikut:

- Keadaan umum lesu atau tidak sadar

- Mata cekung
- Tidak bisa minum atau malas minum
- Mencubit kulit perut kembali sangat lambat ( > 2 detik )

**Tindakan dan perawatan:**

- Tidak perlu segera dirujuk, bila puskesmas/pustu dapat melakukan infus cairan (rl/nacl) untuk terapi c.
- Jika ada klasifikasi berat lain harus di rujuk segera dan anjurkan tetap pemberian asi dan oralit selama di perjalanan.
- Bila ada kolera diberi antibiotik.

**Tabel 3.3 Infus untuk Rencana Terapi C**

| umur     | Pemberian 1 30ml/kg BB | Kemudian 70ml/kg bb |
|----------|------------------------|---------------------|
| <1 tahun | 1 jam                  | 5 jam               |
| >1 tahun | 30 menit               | 2 ½ jam             |

- Kalau anak bisa minum Oralit 5ml/Kg/jam.
- Berikan seng selama 10 hari.

**2. Klasifikasi Diare Dengan Dehidrasi Ringan/Sedang**

Penilaian 2 Atau Lebih Tanda2 Berikut:

- a. Keadaan Umum kegelisahan dan kerewalan
- b. Mata Cekung
- c. Haus, Minum Dengan Lahap
- d. Mencubit Kulit Perut Kembali Lambat (< 2 Detik )

**Tindakan dan pengobatan**

- Berikan plan fluid pada bed B (75 ml x berat anak) pada 3 jam pertama.
- Jika anak memiliki klasifikasi berat badan lain, segera rujuk ke rumah sakit dalam perjalanan memberikan oralit dan asi sesering mungkin.
- 5 hari bila revisit tidak ada perbaikan.
- Harus segera kembali ketika, semakin parah, tidak mau makan atau membungkuk, timbul demam, darah dalam tinja dan malas minum.

**3. Klasifikasi Diare tanpa dehidrasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)**

**Penilaian:**

Tidak ada tanda-tanda yang cukup untuk mengklasifikasikan sebagai dehidrasi parah atau dehidrasi ringan / sedang

**Tindakan dan Pengobatan**

- Makan dan minum dengan rencana terapi a
  - berikan cairan tambahan
  - lanjutkan menyusui

- kapan harus kembali
- Kunjungan ulang 5 hari jika tidak ada perbaikan
- Harus segera kembali ketika, semakin parah, tidak bisa makan, timbul demam, ada darah di tinja dan malas minum

#### **4. Klasifikasi Diare Selama 14 Hari Atau Lebih**

- Diare Persisten Berat (Dengan Dehidrasi)
- Diare Persisten (Tanpa Dehidrasi)

#### **KLASIFIKASI DIARE PERSISTEN BERAT**

##### Penilaian:

- Diare 14 hari atau lebih
- Diare dengan dehidrasi berat atau dehidrasi ringan/sedang

#### **Tindakan dan pengobatan**

Jika puskesmas dapat menyembuhkan dehidrasi dengan rencana terapi c untuk dehidrasi berat atau rencana terapi b untuk dehidrasi ringan/sedang dan dirujuk, tidak perlu segera merujuk

#### **KLASIFIKASI DIARE PERSISTEN**

##### Penilaian:

- DIARE 14 HARI ATAU LEBIH
- DIARE TANPA DEHIDRASI

### **H. PEMERIKSAAN MALARIA**

Langkah-langkah pemeriksaan untuk penyakit malaria meliputi: Menanyakan apakah anak demam

1. Menanyakan: sudah berapa lama anak demam
2. Menanyakan jika lebih dari 7 hari, apakah demam setiap hari
3. Menanyakan apakah pernah mendapat obat anti malaria dalam 2 minggu terakhir
4. Menanyakan apakah anak menderita campak dalam 3 bulan terakhir?
5. Melihat dan meraba adanya kaku kuduk, lihat adanya pilek, lihat adanya tanda-tanda campak saat ini (ruam kemerahan dikulit yang menyeluruh, terdapat salah satu gejala batuk pilek, atau mata merah jika anak menderita campak saat ini atau 3 bulan terakhir maka lihat adanya luka dimulut (apakah dalam atau luas), lihat adanya nanah pada mata, lihat adanya kekeruhan pada kornea)
6. Mengklasifikasi demam resiko tinggi malaria: gejala, klasifikasi dan tindakan.

- a. Melakukan pemeriksaan jika adanya tanda bahaya umum kaku kuduk merupakan gejala penyakit berat dengan demam jika hasil RDT/ mikroskopis untuk falsiparum atau mixed, beri dosis pertama suntikan artometer, jika hasil RDT/ mikroskopis negatif, tidak perlu diberi anti suntikan malaria, beri dosis pertama suntikan antibiotik, beri dosis pertama parasetamol jika demam tinggi  $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ , cegah agar gula darah tidak turun, rujuk segera
  - b. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat demam (pada anamnesis atau teraba panas atau suhu  $>37,5^{\circ}\text{C}$ ) RDT positif merupakan gejala malaria jika RDT positif falsiparum atau positif non falsiparum atau positif mixed, beri anti malaria oral yang sesuai, beri dosis pertama parasetamol jika demam tinggi ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ), nasihat kapan kembali segera, kunjungan ulang jika tetap demam setelah minum obat anti malaria 3 hari berturut-turut
  - c. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat demam (pada anamnesis atau teraba panas atau suhu  $>37,5^{\circ}\text{C}$ ) RDT negatif merupakan gejala demam: mungkin bukan malaria, maka beri dosis pertama parasetamol jika demam tinggi ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ), obati penyebab lain dari demam, jika demam tiap hari selama  $>7$  hari, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan, nasehat kapan kembali segera, kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam
7. Resiko rendah malaria
- a. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat kaku kuduk, kaku kuduk merupakan gejala penyakit berat dengan demam, jika hasil RDT/mikroskopis positif untuk falsiparum atau mixed, beri dosis pertama suntikan artometer, jika hasil RDT/mikroskopis negatif, tidak perlu diberi anti suntikan malaria, beri dosis pertama suntikan antibiotik, beri dosis pertama parasetamol jika demam tinggi  $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ , cegah agar gula darah tidak turun, rujuk segera
  - b. Memeriksa apakah tidak ada pilek, tidak ada campak, tidak ada penyebab lain dari demam, RDT positif falsiparum atau positif non falsiparum atau positif mixed, beri anti malaria oral yang sesuai, beri dosis pertama parasetamol jika demam tinggi ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ), nasihat kapan kembali segera, kunjungan ulang jika tetap demam setelah minum obat anti malaria 3 hari berturut-turut
  - c. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat pilek, campak, penyebab lain dari demam, RDT negatif merupakan penyakit demam mungkin bukan malaria, beri dosis pertama parasetamol, jika demam tinggi ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ), obati penyebab lain dari demam, jika demam tiap hari selama  $>7$  hari, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan, nasehat kapan kembali segera, kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam
8. Tanpa resiko malaria
- a. Memeriksa apakah ada tanda bahaya umum, atau kaku kuduk merupakan gejala penyakit berat dengan demam, beri dosis pertama antibiotik yang

- sesuai, cegah agar gula darah tidak turun, beri dosis pertama parasetamol jika demam tinggi ( $\geq 38,5^\circ\text{C}$ ), rujuk segera.
- b. Menentukan tindak lanjut apabila tidak ada tanda bahaya umum atau tidak ada kaku kuduk merupakan penyakit demam bukan malaria, beri dosis pertama parasetamol, jika demam tinggi ( $\geq 38,5^\circ\text{C}$ ), obati penyebab lain dari demam, jika demam tiap hari selama  $>7$  hari, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan, nasehat kapan segera kembali, kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam.
9. Pemeriksaan penyakit campak Klasifikasi campak meliputi:
- a. Memeriksa apakah ada tanda bahaya umum, atau kekeruhan pada kornea mata, atau luka dimulut yang luas dan dalam merupakan gejala penyakit campak dengan komplikasi berat, beri 1 dosis pertama vitamin A, beri dosis pertama antibiotik yang sesuai, jika ada kekeruhan pada kornea atau mata bernanah, bubuhi salep/tetes mata kloramfenikol/tetrasiklin tanpa kortikosteroid, beri dosis pertama parasetamol jika demam ( $\geq 38,5^\circ\text{C}$ ), rujuk segera
  - b. Memeriksa apakah mata bernanah atau luka dimulut merupakan gejala penyakit campak dengan komplikasi pada mata dan atau mulut, beri vitamin A, jika mata bernanah, bubuhi salep atau tetes mata kloramfenikol/tetrasiklin tanpa kortikosteroid, jika ada luka dimulut ajari cara mengobati dengan gentian violet, kunjungan ulang 2 hari
  - c. Memberikan vitamin A apabila tidak ada tanda-tanda diatas merupakan penyakit campak
10. Pemeriksaan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
- Klasifikasi Demam Berdarah Dengue meliputi:
- a. Memeriksa apakah ada tanda-tanda syok atau gelisah, muntah bercampur darah seperti kopi, berak berwarna hitam, perdarahan dari hidung atau gusi, bintik- bintik perdarahan dikulit (petekie) dan uji tourniquet positif, sering muntah merupakan tanda gejala demam berdarah dengue (DBD) jika ada syok beri oksigen 2-4 liter/menit dan beri segera cairan intravena sesuai petunjuk, jika ada syok tetapi sering muntah atau malas minum, beri cairan infus ringer laktat/ringer asetat, jumlah cairan rumatan, jika tidak ada syok, tidak muntah dan masih mau minum, beri oralit atau cairan lain sebanyak mungkin dalam perjalanan kerumah sakit, jika demam tinggi ( $\geq 38,5^\circ\text{C}$ ) beri dosis pertama parasetamol, tidak boleh golongan salisilat dan ibu profen, rujuk segera.
  - b. Melakukan pemeriksaan tindak lanjut jika demam mendadak tinggi dan terus-menerus, atau nyeri ulu hati atau gelisah, atau bintik-bintik perdarahan kulit dan uji tourniquet (-), mungkin DBD, jika demam tinggi ( $\geq 38,5^\circ\text{C}$ ) beri dosis pertama parasetamol, tidak boleh golongan salisilat dan ibu profen, nasehat

untuk lebih banyak minum (oralit/ cairan lain), nasehat kapan kembali segera, kunjungan ulang 1 hari jika tetap demam.

- c. Memberikan pengobatan apabila tidak ada satupun gejala diatas demam: mungkin bukan DBD maka obati lain penyebab dari demam, jika demam tinggi ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) beri dosis pertama parasetamol tidak boleh golongan salisilat dan ibu profen, nasehat kapan kembali segera, kunjungan 2 hari jika tetap demam.

#### **I. PEMERIKSAAN PENYAKIT TELINGA PADA ANAK**

Langkah-langkah pemeriksaan telinga pada anak meliputi: Menanyakan apakah anak mempunyai masalah telinga.

1. Menanyakan: apakah telinganya sakit.
2. Menanyakan adakah cairan/nanah keluar dari telinga, Jika ya berapa lama.
3. Melihat dan meraba, lihat adakah nanah/cairan keluar dari telinga, raba adakah pembengkakan yang nyeri dibelakang telinga.
4. Mengklasifikasikan masalah telinga berdasarkan gejala, klasifikasi penyakit, tindakan.
5. Melakukan pemeriksa apabila terdapat pembengkakan yang nyeri di belakang telinga merupakan gejala penyakit mastoiditis, beri dosis pertama antibiotik yang sesuai, beri dosis pertama parasetamol untuk mengatasi nyeri, rujuk segera.
6. Memberikan obat apabila tampak cairan/nanah keluar dari telinga dan telah terjadi kurang dari 14 hari, atau nyeri telinga merupakan infeksi telinga akut, beri antibiotik yang sesuai, beri parasetamol untuk mengatasi nyeri, keringkan telinga dengan bahan penyerap, kunjungan ulang 2 hari.
7. Melakukan tindaklanjut jika tampak cairan/nanah keluar dari telinga dan telah terjadi selama 14 hari atau lebih merupakan gejala infeksi telinga kronis, keringkan telinga dengan kain/kertas penyerap setelah dicuci dengan  $\text{H}_2\text{O}_2$  3%, beri tetes telinga yang sesuai, kunjungan ulang 5 hari.
8. Menentukan tindaklanjut apabila tidak ada sakit telinga dan tidak ada nanah keluar dari telinga maka tidak ada infeksi telinga, maka tidak perlu tindakan tambahan.

#### **J. MEMERIKSA STATUS GIZI**

Langkah-langkah dalam pemeriksaan gizi meliputi:

1. Melihat dan meraba
2. Melihat apakah anak tampak kurus atau sangat kurus
3. Melihat dan raba adanya pembengkakan di kedua punggung kaki
4. Menentukan berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, apakah:
  - a.  $\text{BB/PB (TB)} < -3 \text{ SD}$
  - b.  $\text{BB/PB (TB)} \leq -3 \text{ SD} - < -2 \text{ SD}$

c. BB/PB (TB) -2 SD - +2 SD

5. Mengklasifikasi status gizi berdasarkan gejala, klasifikasi penyakit, dan tindakan.
6. Melakukan pemeriksaan berat badan, apabila badan sangat kurus, BB/PB (TB) < -3 SD, bengkak pada kedua punggung kaki menandakan kondisi sangat kurus dan atau edema, beri air gula, hangatkan badan, beri dosis pertama vitamin A sesuai umur, bila disertai diare, berikan cairan ReSoMal atau modifikasinya, bila syok berikan glukosa 10% IV dan infus, bila ada komplikasi pada mata, beri tetes/salep mata tanpa kortikosteroid, rujuk segera, selama dalam perjalanan jaga kehangatan badan dan bila masih menyusui, teruskan ASI.
7. Melakukan pemeriksaan selanjutnya apabila badan kurus atau BB/ PB (TB)  $\geq$  -3SD - <-2SD maka anak kurus, lakukan penilaian pemberian makan pada anak, bila ada masalah pemberian makan, lakukan konseling gizi dan kunjungan ulang 5 hari, bila tidak ada masalah pemberian makan, nasehati sesuai anjuran makan anak sehat maupun sakit dan kunjungan ulang 14 hari, nasehati kapan kembali segera.
8. Melakukan pemeriksaan lanjutan apabila BB/PB (TB) -2SD - +2 SD, dan ditemukan tanda-tanda kelainan gizi diatas pertumbuhan normal, jika anak berumur kurang dari 2 tahun, lakukan penilaian pemberian makan dan nasehat sesuai anjuran makan untuk anak sehat maupun sakit, bila ada masalah pemberian makan, lakukan konseling gizi dan kunjungan ulang 5 hari, bila tidak masalah pemberian makan, anjurkan untuk menimbang berat badan secara teratur setiap bulan.

**K. PEMERIKSAAN ANEMIA**

Langkah-langkah pemeriksaan anemia pada anak meliputi:

1. Melihat tanda pucat pada telapak tangan, apakah: sangat pucat? Agak pucat?
2. Mengklasifikasikan anemia berdasarkan gejala, klasifikasi penyakit dan tindakan.
3. Memeriksa telapak tangan apabila sangat pucat merupakan anemia berat, rujuk segera bila masih menyusui, teruskan pemberian ASI.
4. Menentukan tindakan selanjutnya apabila telapak tangan agak pucat merupakan anemia lakukan penilaian pemberian makan pada anak, bila ada masalah pemberian makan, lakukan konseling gizi, dan kunjungan ulang 5 hari, beri zat besi, beri obat cacing, jika daerah resiko tinggi malaria: beri anti malaria oral, nasehat kapan kembali segera, kunjungan ulang 4 minggu, apabila tidak ditemukan tanda keputihan pada telapak tangan maka tidak anemia, tidak perlu tindakan.

**L. PEMERIKSAAN PEMBERIAN VITAMIN A**

Langkah-langkah yang perlu diketahui dalam pemberian vitamin A meliputi:

1. Jadwal suplementasi: setiap bulan februari dan agustus

2. Umur 6 sampai 11 bulan: 100.000 IU ( kapsul biru)
3. Umur 12 bulan sampai 59 bulan: 200.000 IU (kapsul merah) (Depkes RI, 2010).

#### **M. MENILAI MASALAH/KELUHAN LAIN**

Yang mungkin ada pada anak tetapi tidak dapat diklasifikasikan memakai bagan dari 4 keluhan utama, misalnya kencing berdarah, hernia, gatal- gatal, sukar berak, atau infeksi kulit.

#### **MENENTUKAN PERLUNYA DILAKUKAN RUJUKAN SEGERA MELIPUTI:**

1. Pneumonia berat/penyakit sangat berat
2. Diare dehidrasi berat
3. Diare persisten berat
4. Penyakit berat dengan demam
5. Campak dengan komplikasi berat
6. Demam berdarah dengue
7. Mastoiditis
8. Sangat kurus dan atau edema
9. Anemia berat

Menentukan tindakan/pengobatan pra rujukan dan menentukan tindakan pra rujukan meliputi:

1. Beri dosis pertama antibiotik yang sesuai
2. Beri dosis pertama suntikan artemeter untuk malaria berat (di daerah resiko tinggi/rendah malaria)
3. Beri dosis pertama vitamin A
4. Beri cairan intravena pada anak DBD dengan syok
5. Cegah agar gula darah tidak menurun (termasuk memberi ASI, susu atau air gula)
6. Beri dosis pertama suntikan antibiotik
7. Beri dosis pertama obat malaria oral (daerah resiko tinggi dan rendah malaria)
8. Beri dosis pertama parasetamol jika demam tinggi (38,5oC atau lebih) atau nyeri akibat mastoiditis
9. Beri tetes/salep mata tetrasiklin atau kloramfenikol tanpa kortikosteroid (bila ada kekeruhan kornea atau mata bernanah)
10. Beri ASI dan larutan oralit selama perjalanan kerumah sakit

#### **N. MERUJUK ANAK**

Menentukan tindakan dan pengobatan untuk anak yang tidak memerlukan rujukan meliputi:

1. Pneumonia
2. Batuk bukan pneumonia

3. Diare dehidrasi ringan/sedang
4. Diare tanpa dehidrasi
5. Diare persisten
6. Disentri
7. Malaria (resiko tinggi dan resiko rendah malaria)
8. Demam mungkin bukan malaria (resiko rendah malaria)
9. Demam bukan malaria (tanpa resiko malaria)
10. Campak dengan komplikasi pada mata atau mulut
11. Campak
12. Mungkin DBD
13. Demam mungkin bukan DBD
14. Infeksi telinga akut
15. Infeksi telinga kronis
16. Kurus
17. Anemia

#### **O. KUNJUNGAN ULANG**

Pemberian konseling meliputi:

1. Menggunakan keterampilan komunikasi yang baik
2. Mengajari ibu cara pemberian obat oral dirumah
3. Mengajari ibu cara mengobati infeksi lokal dirumah
4. Mengajari ibu cara mencampur dan memberi oralit
5. Mengajarkan makan untuk anak sehat maupun sakit
6. Menilai cara pemberian makanan anak
7. Menentukan masalah pemberian makan anak
8. Menasehati ibu tentang masalah pemberian makan anak
9. Menasehati ibu tentang pemberian cairan selama anak sakit
10. Menasehati ibu tentang penggunaan kelambu untuk pencegahan malaria
11. Menasehati ibu kapan harus kembali ke petugas kesehatan

#### **P. REFERENSI**

Depkes RI. (2008). *Laporan Analisis Determinan Penyakit Menular Langsung (Pneumonia, Thypus/ Parathypus, Hepatitis) Hubungannya dengan Mordibilitas Di Indonesia*. Jakarta. Depkes RI.

Depkes RI. (2006). *Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Modul 1 – 7, Edisi 2*. Dirjen Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Buku bagan MTBS 2019.pdf* (pp. 1–67).

# **BAB 4**

## **PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM MERAWAT BAYI, BALITA, DAN ANAK PRASEKOLAH**

**Ni Putu Riza Kurnia Indriana, SST., M.Kes**



## **PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM MERAWAT BAYI, BALITA, DAN ANAK PRASEKOLAH**

Ni Putu Riza Kurnia Indriana, SST., M.Kes

### **A. PENDAHULUAN**

Angka kematian balita merupakan salah satu tolak ukur pencapaian kesejahteraan suatu Negara. Angka kematian bayi dan balita menjadi salah satu permasalahan yang terjadi secara global. Angka ini juga menjadi target pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) untuk pembangunan kesehatan di Indonesia. Negara yang sukses dari tercapainya suatu pembangunan kesehatan keluarga dilihat dari terjadinya penurunan angka kematian bayi dan balita. Indonesia menargetkan pada tahun 2030 angka kematian balita tidak melebihi dari 25 per 1000 kelahiran hidup. Pencapaian target ini perlu upaya yang ekstra dan kerjasama yang kuat untuk semua lapisan masyarakat. Kematian ini disebabkan karena kejadian penyakit, komplikasi persalinan, penolong persalinan yang tidak kompeten dan lain sebagainya (Rahmawati, et.al, 2022).

Gangguan kesehatan yang umumnya terjadi pada bayi, balita dan anak prasekolah berupa infeksi bakteri. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada bayi, balita dan anak prasekolah yaitu melalui pendidikan kesehatan pada orang tua dengan pemberian informasi. Pemberian informasi dapat dilakukan salah satunya dengan promosi kesehatan. Promosi kesehatan tidak hanya menyampaikan pesan ataupun informasi terkait kesehatan agar masyarakat dapat mengetahui dan berperilaku hidup sehat, tetapi juga mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Informasi bagi orang tua sangat berguna dalam menjaga kesehatan anaknya. Informasi ini didapatkan melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan bagi, orang tua penting dilakukan, apalagi terkait dengan informasi tentang kesehatan anaknya. Pasangan yang menjadi orang tua perlu memahami bagaimana cara merawat anaknya baik dari bayi, balita dan anak prasekolah (Jamil S.N., Sukma, S., & Hamidah, 2017).

Pendidikan kesehatan yang perlu diketahui oleh orang tua yaitu mengenai menjaga kehangatan tubuh anaknya yang berumur 0-5 tahun yaitu, memenuhi kebutuhan imunisasi, pemenuhan kebutuhan nutrisi, kebiasaan mencuci tangan, pemberian ASI eksklusif sampai berumur 6 bulan kemudian dilanjutkan pemberian ASI sampai umur 2 tahun bersamaan pemberian makanan pendamping ASI, stimulasi tumbuh kembang anak dan menjaga kesehatan mulut dan gigi (Bruno, 2019).

## **B. DEFINISI PENDIDIKAN KESEHATAN**

Pendidikan Kesehatan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat, sebagai upaya dalam meningkatkan kemauan (*willingness*) dan kemampuan (*ability*) masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Pendidikan adalah suatu usaha persuasi atau pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat bersedia melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga serta meningkatkan derajat kesehatannya. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya tenaga kesehatan dalam membantu kliennya baik secara individu, kelompok maupun masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran dimana tenaga kesehatan sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat (Notoatmodjo, 2014).

Pendidikan kesehatan memiliki tujuan agar masyarakat melalui proses perubahan pengetahuan, perilaku, sikap yang terjadi baik secara individu, keluarga maupun masyarakat untuk berperilaku hidup sehat atau aktif untuk melakukan upaya penanganan dalam mengoptimalkan derajat kesehatannya. Pendidikan kesehatan dapat ditujukan kepada sasaran yang dilakukan secara langsung maupun menggunakan media tertentu. Apabila pemberi pendidikan tidak dapat bertemu dengan sasaran, maka bisa menggunakan media untuk mengirim pesan kesehatan yang akan diberikan. Penentuan media pendidikan yang akan digunakan tergantung dari jumlah sasaran, letak geografis, karakteristik serta adanya dukungan sumber daya. Berikut contoh media dan alat peraga yang digunakan saat memberikan pendidikan kesehatan yaitu, leaflet dan pamphlet, flyer, billboard, poster, lembar balik (Niu Flora, 2017).

## **C. MACAM-MACAM PENDIDIKAN KESEHATAN PADA BAYI, BALITA DAN ANAK PRASEKOLAH**

Pendidikan kesehatan pada bayi, balita dan anak prasekolah didasarkan pada orang tua, agar bisa merawat anaknya pada umur rentang 0-6 tahun. Pendidikan ini penting dilakukan agar orang tua mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam menjaga kesehatan anaknya dan merubah perilaku yang tidak sehat dalam mengasuh anak (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Berikut beberapa macam pendidikan kesehatan yang dapat diberikan kepada orang tua

### **1. Pemberian Imunisasi pada bayi**

Imunisasi merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman atau bibit kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan (antigen) ke dalam tubuh. Tujuan dilakukannya imunisasi yaitu sebagai upaya dalam pencegahan yang paling *cost effective*, selain dapat mencegah penyakit bagi diri sendiri tetapi juga dapat melindungi orang disekitarnya (Kemenkes RI, 2019).

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam imunisasi yaitu, orang tua anak harus ditanyakan status kesehatan anak saat ini, apakah dalam kondisi sehat atau sakit, pengalaman/reaksi terhadap imunisasi yang pernah didapat sebelumnya, penyakit yang dialami masa lalu dan masa sekarang. Orang tua harus mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, manfaat imunisasi dan efek sampingnya. Catatan imunisasi yang lalu (apabila sudah pernah mendapatkan imunisasi sebelumnya), pentingnya menjaga kesehatan melalui tindakan imunisasi. Terdapat beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan dalam memberikan imunisasi pada anak yaitu flu berat, atau panas tinggi, perubahan pada sistem imun yang tidak dapat menerima vaksin virus hidup, sedang dalam pemberian obat-obatan yang menekan sistem imun, misalnya transfusi darah dan imunoglobulin, riwayat alergi terhadap pemberian vaksin (pertusis) (Jamil S.N., Sukma, S., 2017).

Imunisasi bisa didapatkan pada posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, praktek dokter atau bidan dan rumah sakit. Beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu tuberkulosis, hepatitis B, poliomyelitis, campak, gondongan, rubella, tipus abdominalis, varicella, hepatitis A, hemophilus influenza tipe B, rotavirus dan lain sebagainya (Octa, Maita, Suputri, & Yulvia, 2014). Berikut jenis imunisasi yang diberikan kepada bayi:

a. BCG

Imunisasi ini diberikan untuk mencegah penyakit tuberkulosis yang disebabkan mycobacterium tuberculosis. Organ yang sering terkena adalah paru-paru, kelenjar, kulit, tulang, sendi dan selaput otak. Cara penularan melalui droplet atau percikan air liur. Vaksin ini diberikan pada bayi kurang dari 2 bulan. Efek samping yang terjadi yaitu reaksi pembengkakan kecil, kemerahan, abses dan timbul bekas luka. Kontraindikasi dari vaksin ini yaitu gizi buruk, demam tinggi, infeksi kulit luas, riwayat TB.

b. Hepatitis B

Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Penularan virus ini dapat melalui ASI. Efek samping dari pemberian imunisasi ini yaitu nyeri sendi/otot, bengkak, panas, mual. Kontraindikasi dari vaksin ini yaitu Pemberian kepada bayi prematur dengan berat < 2000 gram perlu diperhatikan karena biasanya tidak merespon baik terhadap vaksin. Pada kondisi tersebut biasanya vaksin diberikan saat anak berusia kronologis satu bulan.

c. Polio

Penyakit ini disebabkan oleh virus polio tipe 1, 2, dan 3 dan menyerang mielin atau serabut otot. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan pada anggota badan, saluran napas, dan otot menelan. Efek samping yang

ditimbulkan yaitu diare ringan, sakit pada otot. Kontraindikasinya dapat berupa demam, muntah/diare, konsumsi obat immunosupresif.

d. DPT (difteri, pertusis, tetanus)

Difteri disebabkan oleh *Corynebacterium Dyptheria*, Pertusis disebabkan oleh bakteri *bordetela pertusis* dan tetanus disebabkan oleh *clastridium tetani*. Penularan difteri melalui kontak fisik dan pernafasan, pertusis melalui percikan ludah yang tercemar, tetanus melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam.

**Gambar 4.1 Jadwal Pemberian Imunisasi**

| USIA ANAK | JENIS IMUNISASI                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| <24 jam   | Hepatitis 0 (HB0)                         |
| 1 bulan   | BCG, OPV1                                 |
| 2 bulan   | DPT-HB-Hib 1, OPV 2*, PCV 1, Rotavirus 1  |
| 3 bulan   | DPT-HB-Hib 2, OPV 3*, PCV 2, Rotavirus 2  |
| 4 bulan   | DPT-HB-Hib 3, OPV 4* dan IPV, Rotavirus 3 |
| 9 bulan   | Campak-Rubela                             |
| 12 bulan  | PCV 3                                     |
| 18 bulan  | Campak-Rubela, DPT-HB-Hib 4               |
| Kelas 1   | Campak-Rubela, DT                         |
| Kelas 2   | Td                                        |
| Kelas 5   | Td, HPV**                                 |
| Kelas 6   | HPV**                                     |

## 2. Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi bayi, balita dan anak prasekolah

Bayi umur 0-6 bulan membutuhkan air susu ibu (ASI) untuk pemenuhan nutrisinya. ASI merupakan makanan dan minuman yang ideal bagi bayi. ASI dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan bayi guna pertumbuhan dan perkembangannya. Komposisi dan jumlah energi yang dikandung oleh ASI akan menyesuaikan dengan pertumbuhan bayi (Bruno, 2019).

ASI yang diberikan melalui proses menyusui akan menstimulasi respon pada ibu dan bayi. Respon dan manfaat yang terjadi pada bayi saat menyusui yaitu somatostatin, gastrin dan *cholecystikinin* rilis membantu dan merangsang pertumbuhan dan perkembangan saluran pencernaan, meningkatkan penyerapan gizi dan menyebabkan rasa kenyang pada bayi. Sedangkan pada ibu terjadinya pelepasan prolaktin dapat merangsang produksi susu selama menyusui dini, sementara itu saat prolaktin dilepaskan oksitosin akan merangsang keluarnya susu, seperti reflek *let-down* dengan membaa susu ke titik pengiriman. Oksitosin juga menyebabkan kulit lokal vasodilatasi sehingga terasa hangat bagi bayi serta menyenangkan, mengantuk dan membuat sensasi pada ibu. K olostrum merupakan ASI yang dikeluarkan pada hari 1-5, yang

merupakan cairan kental berwarna kekuningan yang kaya akan protein dan vitamin A, serta berisi zat kekebalan tubuh. Kolostrum merupakan imunisasi pertama bagi bayi (Kemenkes RI, 2019).

Kebutuhan nutrisi bagi balita harus mengandung 10-15% kalori, 20-35% lemak dan sisanya karbohidrat. Asupan lemak juga perlu ditingkatkan karena struktur utama pembentuk otak adalah lemak. Lemak dapat diperoleh melalui lemak dari hewani, buah-buahan spt alpukat serta bisa juga dari margarin. Konsumsi garam untuk balita tidak lebih dari 1/6 jumlah maksimum orang dewasa sehari atau kurang dari 1 gram. Porsi makan balita juga berbeda dengan orang dewasa. Balita membutuhkan makanan dari sumber energi yang lengkap dalam jumlah lebih kecil namun sering. Bahan makanan sumber energi seperti karbohidrat, lemak serta vitamin, mineral dan serat wajib dikonsumsi anak setiap hari. Orang tua memiliki kewajiban mengatur agar semua sumber gizi tersebut ada dalam menu sehari. Susu sebagai salah satu sumber kalsium, juga penting dikonsumsi balita. Sedikitnya balita butuh 350 ml/12 oz per hari. Susu Pertumbuhan merupakan susu lengkap gizi yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak usia 12 bulan ke atas dan menjadi pelengkap menu (Mann, J., & Truswell, 2014).

Memakan snack berlebihan diantara jam makan, akibatnya tubuh masih berkecukupan dg makanan yang berasal dari snack tersebut, sehingga anak tidak merasa lapar. Perkembangan ego sang anak; anak menolak makan sbg manifestasi dari perkembangan sikap mandiri. Menu tidak bervariasi shg anak merasa bosan dengan makanan yang terhidang atau bentuk makanan tidak menarik. Tindakan yang dilakukan orang tua dalam menjaga kesehatan nutrisi balita yaitu dengan mengurangi snack atau tidak memberikan snack sama sekali diantara jam makan, menghidangkan menu yang bervariasi, mempercantik tampilan makanan, biarkan balita makan secara mandiri, jangan meminta anak makan dengan cepat, tidak perlu memberikan porsi yang banyak kepada anak yang membuat anak sulit menghabiskan. Berikan makanan secara bertahap sesuai jenis dan kandungan gizi.

Nutrisi anak prasekolah terdiri dari zat tenaga : nasi, roti, jagung, bihun, ubi, singkong dan lainnya. Zat pembangun seperti ikan, telur, daging, susu, ayam dan lainnya. Zat pengatur seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Pemberian makanan pada anak prasekolah harus memperhatikan porsi makanan yang tidak terlalu besar, makanan cukup basah (tidak terlalu kering) agar mudah ditelan anak, potongan makanan dan ukuran cukup kecil sehingga mudah dimasukkan ke dalam mulut anak dan mudah dikunyah. Tidak berduri/ bertulang kecil, sedikit/tidak pedas dan ber bumbu tajam, bersih rapi dan menarik, jenis hidangan bervariasi. Tujuan dari pemenuhan nutrisi anak agar pertumbuhan dan

perkembangan anak bisa optimal, memiliki energi untuk melakukan aktivitas serta mengatur proses tubuh (Octa et al., 2014).

### **3. Kebiasaan mencuci tangan**

Mencuci tangan menggunakan sabun merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun sehingga tangan menjadi bersih untuk memutus mata rantai kuman. Melakukan cuci tangan menggunakan sabun menjadi suatu upaya untuk pencegahan penyakit. Alasan dilakukannya cuci tangan karena tangan sering menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak secara langsung maupun tidak langsung. Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia maupun binatang, ataupun cairan tubuh lain seperti makanan/minuman yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditularkan (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Cuci tangan dilakukan dalam upaya kampanye cuci tangan sedunia yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian anak-anak dengan kasus diare yang terjadi lebih dari 5000 anak balita meninggal dunia setiap harinya di seluruh dunia. Kejadian ini terjadi akibat minimnya akses air bersih dan f sebagai akibatsilitas sanitasi dan pendidikan kesehatan. Melakukan kegiatan mencuci tangan dengan sabun bisa mengurangi beban penderitaan serta biaya yang ditanggung akibat sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Penyakit yang dapat dicegah dengan mencuci tangan menggunakan sabun yaitu diare, infeksi saluran pernafasan, pneumonia, infeksi cacing, infeksi mata dan penyakit kulit. Diare menjadi penyebab kematian kedua paling umum pada anak balita. Sebuah ulasan yang membahas sekitar 30 penelitian terkait menemukan bahwa cuci tangan dengan sabun dapat memangkas angka penderita diare hingga separuh. Tingkat keefektifan mencuci tangan dengan sabun dalam penurunan angka penderita diare dalam persen menurut tipe inovasi pencegahan adalah mencuci tangan dengan sabun (44), penggunaan air olahan (39%), sanitasi (32%), pendidikan kesehatan (28%), penyediaan air (25%), sumber air yang dioah (11%).

Penyebab terjadinya kematian pada anak balita diakibatkan karena terjadinya infeksi pada saluran pernafasan. Infeksi saluran pernafasan dapat dikurangi kejadiannya dengan melakukan tindakan mencuci tangan dengan dualangkah: patogen-patogen yang terdapat pada tangan serta permukaan di telapak dilepaskan. Menghilangkan patogen yang menyebabkan terjadinya infeksi pernafasan serta diare. Beberapa studi membuktikan bahwa dengan mencuci tangan dapat mengurangi kejadian infeksi sampai 25%. Penelitian lain di Pakistan menemukan bahwa mencuci tangan dengan sabun mengurangi

infeksi saluran pernafasan yang berkaitan dengan pneumonia pada anak-anak hingga lebih dari 50%.

#### **4. Asi eksklusif**

Makanan yang utama dan pertama yang penting dan banyak manfaat untuk diberikan bagi bayi adalah ASI. Bayi sebaiknya diberikan ASI sejak dini dari saat lahir secara eksklusif selama 6 bulan. ASI eksklusif ini diberikan tanpa dibarengi pemberian makanan lainnya selama 6 bulan. ASI ini selain sebagai sumber makanan bagi bayi, juga dapat sebagai sarana untuk mempererat jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Jalinan hubungan ini terjadi karena secara psikologis dan imunologis ketika terjadi proses menyusui adanya kemesraan yang tercipta antara bayi dan ibu yang terjalin secara harmonis.

ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan secara full kepada bayi tanpa adanya pemberian makanan lainnya yang dilakukan sejak dini setelah bayi lahir. Pemberian ASI secara eksklusif untuk bayi dilakukan sampai umur bayi 6 bulan tanpa dijadwal. Setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif, ibu bisa melanjutkan pemberian ASI sampai 2 tahun ditambah dengan memberikan makanan pendamping ASI. ASI yang diberikan untuk bayi baru lahir diberikan pada durasi waktu 2 sampai 3 jam oleh ibunya. Bertambahnya usia bayi, maka durasi waktu bayi untuk menyusui akan semakin sering karena peningkatan kapasitas perut bayi. Mula setiap 3 sampai 4 jam selama periode pertama kehidupannya (Puteri, Laila, & Hasan, 2018).

Mengetahui bayi anda sudah kenyang atau belum dalam konsumsi ASI atau susu formula, anda bisa melihat dari isyarat yang ditunjukkan oleh bayi. Jangan menggunakan patokan jam untuk panduan saat memberi bayi anda makan. Isyarat yang ditunjukkan bayi ketika bayi lapar yaitu menaruh kedua tangan atau jarinya ke dalam mulut, adanya gerakan mulut menghisap, juluran lidah bayi, memukul bibirnya, menendang atau menggeliat, atau mulai menggerakkan rahang dan mulut atau kepala untuk mencari payudara Anda. Jika ia mulai menangis, ini biasanya sinyal akhir bahwa dia ingin makan (Mann, J., & Truswell, 2014).

ASI pada keadaan normal diproduksi 10-100 cc pada beberapa hari pertama. Konsumsi ASI per hari oleh bayi sebanyak 700-800 cc, pada 6 bulan pertama ASI diproduksi lebih sedikit yaitu sekitar 700-800 cc per hari. Selanjutnya pada 6 bulan kedua produksi ASI menjadi 200-400 cc dan 200-400 cc di tahun kedua anak. ASI bermanfaat baik bagi ibu maupun bayi, berikut ASI bagi ibu dan bayi yaitu:

- a. Manfaat ASI untuk bayiupakan manfaat ASI untuk ibu dan bayi yaitu:
  - 1) ASI mengandung gizi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.
  - 2) Kandungan DHA dan AA memiliki manfaat untuk kecerdasan anak.

- 3) ASI mudah dicerna dan diserap oleh pencernaan bayi.
  - 4) Perlindungan terhadap alergi dan infeksi.
  - 5) Pemberian ASI terbukti aman, segar, bersih murna serta tidak cepat basi.
  - 6) Membantu bayi dalam merangsang reflek hisap, menelan dan pernafasan.
- b. Manfaat ASI untuk ibu:
- 1) Terbentuknya jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi.
  - 2) Mencegah terjadinya perdarahan setelah lahir serta ibu cepat dalam masa pemulihan kesehatan.
  - 3) Terjadinya risiko kanker payudara berkurang.
  - 4) Pemberian ASI mengefisienkan waktu serta biaya
  - 5) Bisa menunda terjadinya kehamilan selanjutnya.
  - 6) Pemberian ASI bisa menyehatkan kejiwaan dan psikologis ibu dan bayi
  - 7) Hisapan bayi saat menyusui pertama dapat menyebabkan kontraksinya otot rahim yang berefek kembalinya rahim ke kondisi dan ukurannya semula/ukuran normal menjadi lebih cepat.
  - 8) Memupuk kepercayaan diri ibu untuk menyusui.

ASI merupakan asupan nutrisi bagi bayi yang memiliki beragam manfaat baik untuk ibu dan bayi. Manfaat maupun keuntungan diperoleh dari ASI yaitu: Bayi lebih sehat, lincah dan tidak cengeng.

- a. Bayi menjadi sehat, aktif dan anteng.
- b. Bayi jarang sakit
- c. Menghemat biaya untuk memelihara kesehatan ibu dan bayi.
- d. Pemenuhan gizi untuk bayi terpenuhi di dalam ASI.
- e. Asi mudah dicerna oleh pencernaan bayi.
- f. Meminimalisir terjadinya alergi pada anak.
- g. Bentuknya ikatan kasih sayang antara ibu dan anak.
- h. Membantu perkembangan fisik dan mental anak.
- i. Menjadi alat kontrasepsi karena bisa menunda kehamilan.

Bayi akan mengalami kerugian apabila bayi tidak mendapatkan ASI dari ibunya. Beberapa kerugian yang terjadi bagi ibu dan bayi apabila tidak memberikan ASI yaitu:

- a. Bagi Ibu : tidak ekonomis dan tidak praktis
- b. Bagi Bayi:
  - 1) Bayi rentan akan mengalami risiko infeksi karena bayi tidak memperoleh zatkekebalan yang terkandung pada ASI.
  - 2) Bayi yang diberikan PASI, tidak sesuai dengan petunjuk penggunaannya terancam mengalami kekurangan gizi.

- 3) Pemberian PASI secara berlebihan meningkatkan bayi berisiko mengalami obesitas.
- 4) Bayi berpeluang sering mengalami sakit diare dan alergi.
- 5) Pembentukan tumbuhnya rahang dan gigi menjadi tidak baik.
- 6) Keterikatan emosional antara ibu dan bayi menjadi berkurang. Hal ini akan berdampak pada perkembangan mental anak berikutnya.

Selain pemberian ASI, hal penting yang perlu diketahui ibu dalam menyusui yaitu teknik/cara menyusui bayi. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusui bayi yaitu:

- a. Susuilah bayi pada kedua payudara secara bergantian sampai kedua payudara terasa kosong dengan waktu masing-masing 15-20 menit.
- b. Bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan pertama kelahirannya.
- c. Perhatikan posisi tubuh bayi ketika sedang menyusui dengan memastikan areola dan puting masuk seluruhnya ke dalam mulut bayi agar puting ibu tidak lecet.
- d. Susui bayi secara on demand sesuai kebutuhan bayi.
- e. Keluarkan sedikit ASI ibu sebelum mulai menyusui dan oleskan pada puting dan areola payudara. Hal ini dilakukan untuk desinfeksi area puting dan areola serta bisa menjaga kelembaban payudara.
- f. Bayi diletakkan pada salah satu lengan dengan posisi kepala bayi berada di lengkung siku ibu. Bokong bayi diposisikan di lengan bawah ibu.
- g. Tempelkan bagian perut bayi dengan perut ibu. Posisi salah satu tangan bayi berada di belakang badan ibu serta tangan bayi yang satunya berada di depan. Kepala bayi hadapkan ke payudara ibu.
- h. Posisi bayi berada pada garis lurus antara telinga dan lengan bayi.
- i. Peganglah payudara menggunakan ibu jari diatas dan jari lain menopang bagian bawah. Jangan menekan puting puting susu dan areolanya.
- j. Rangsang bayi untuk membuka mulut dengan cara sentuh pipi bayi menggunakan puting susu atau menyentuhkan puting di sudut mulut bayi.
- k. Saat bayi membuka mulutnya segera dekatkan kepala bayi ke payudara ibu. Masukkan puting susu serta areola payudara ke dalam mulut bayi.
- l. Ibu tidak perlu untuk menyangga payudaranya lagi ketika bayi mulai menghisap payudara.
- m. Perhatikan bayi selama menyusui.
- n. Ajari ibu untuk melakukan pelepasan payudara saat bayi sudah selesai menyusui dengan memasukkan jari kelingking ke dalam mulut bayi melalui sudut mulut atau bisa juga dengan menekan dagu bayi kebawah.

## 5. Menjaga kebersihan mulut dan gigi

Kesehatan gigi dan mulut bisa dilakukan sejak dini serta merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak untuk optimalisasi tumbuh kembang. Kerusakan yang terjadi pada email gigi anak rentan terjadi karena email gigi anak tidak sekuat email gigi dewasa. Tumbuhnya gigi pertama pada bayi terjadi pada usia sekitar 6-8 bulan. Pertumbuhan gigi anak akan terus berlanjut sampai anak berusia 3 tahun dengan jumlah gigi sebanyak 20 buah. Gigi susu memiliki fungsi yang beragam, berikut merupakan fungsi dari gigi susu (Budiastuti, 2013):

- a. Mengoptimalkan tumbuhnya gigi permanen. Gigi susu pada anak akan copot dengan sendirinya jika sudah waktunya untuk pergantian gigi permanen. Copotnya gigi susu memberi celah untuk gigi permanen yang akan tumbuh dibawahnya. Perawatan gigi susu yang baik dapat merangsang rahang untuk berkembang.
- b. Membantu anak dalam mengunyah makanan sehingga nutrisi anak bisa terpenuhi untuk proses tumbuh kembangnya.
- c. Perkembangan otot rahang dan wajah anak dipengaruhi juga oleh kondisi gigi susu.
- d. Percaya diri anak menjadi meningkat dengan anak memiliki gigi bersih dan sehat. Gigi bersih dan sehat membuat anak terlihat menarik.

Kesehatan gigi dan mulut anak yang terjaga sejak dini memberikan banyak manfaat untuk anak kita. Berikut cara yang perlu dilakukan agar kesehatan gigi tetap terjaga yaitu:

- a. Gigi serta gusi anak dibersihkan pada waktu tumbuhnya gigi pertama. Tidak hanya membersihkan sisa makanan dan bakteri, namun juga membantu menciptakan kebiasaan menyikat gigi pada pagi dan malam hari untuk anak anak.
- b. Gigi dan gusi dibersihkan saat pagi dan malam hari sebelum tidur menggunakan sikat gigi yang memiliki bulu lembut atau bisa juga dengan kasa basah.
- c. Cegah gigi berlubang pada anak dengan menghindari memberikan anak susu atau minuman manis menjelang tidur menggunakan dot.
- d. Lakukan pemeriksaan gigi secara rutin dan berkala ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.

Menjaga kesehatan gigi anak sangatlah penting, sehingga diperlukan peran dari orang tua maupun pengasuh anak untuk mengajarkan dan mengingatkan anak dalam menjaga kesehatan gigi. Pantikan anak anda menyikat giginya secara benar. Orang tua bisa mengenalkan cara untuk melakukan perawatan menjaga kesehatan gigi anak yaitu memperkenalkan pada anak pentingnya merawat gigi sejak dini saat anak mempunyai gigi pertama kali. Orang tua mengingatkan anak untuk terbiasa menyikat giginya 2 kali dalam sehari. Apabila anak anda baru

memiliki satu gigi, orang tua bisa membersihkan gigi anak dengan menggunakan kasa. Bagi anak yang pertumbuhan giginya sudah banyak, bisa ajarkan anak menyikat gigi menggunakan sikat gigi anak. Orang tua perlu juga mengupayakan agar anak menggunakan empeng dan botol secara minim khususnya saat mereka tidur. Upaya ini bertujuan agar sisa susu yang anak minum tidak tertinggal di gigi dan gusi. Selain itu, pemberian susu menggunakan botol dan empeng bisa mengubah bentuk gigi mereka karena sedotan anak yang terlalu kuat. Selain itu ajarkan juga anak untuk mengurangi konsumsi minuman manis, termasuk obat sirup anak. Apabila terdapat kendala, orang tua bisa memberikan anak minum air untuk menetralkan mulut dan gigi anak dari minuman tersebut. Menarik minat anak untuk menyikat gigi bisa dilakukan dengan memberikan anak memilih sikat gigi yang disukai agar anak senang dan semangat untuk menjaga kebersihan mulut dan giginya. (Soetjiningsih & Ranuh G., 2014).

#### D. REFERENSI

- Bruno, L. (2019). Hubungan Pengetahuan Ibu Terhadap Pemberian Asi Pada Bayi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Budiastuti, N. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik*. Jakarta: EGC.
- Jamil S.N., Sukma, S., & H. (2017). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kemkes RI. (2019). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan RI*. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-penyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html>
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Perilaku Mencuci Tangan Pakai Sabun di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, Pusat data dan Informasi.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Panduan Kesehatan Balita Pada Masa Pandemi Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehatan*. Jakarta.
- Mann, J., & Truswell, S. A. (2014). *Buku Ajar Ilmu Gizi* (4th ed.). Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Niu Flora. (2017). *Konsep Kebidanan*. Jakarta: CV Trans Info Media.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Octa, D., Maita, Suputri, & Yulvia. (2014). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi/Balita dan Anak Prasekolah untuk Para Bidan* (Pertama). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Puteri, N. E., Laila, A., & Hasan, Z. (2018). Perbedaan Pertumbuhan dan Perkembangan Antara Balita Riwayat BBLR dengan Balita Lahir Normal Di Wilayah Puskesmas Payung Sekaki. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 104–111. Retrieved from <http://www.jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/download/94/85>
- Rahmawati, Kunia, Asih, Mani, Dewi, A. et. all. (2022). Determinan of Under-Five Mortality in Indonesia: A Nationwide Study. *Journal of Pediatric Nursing*, 65, E45–E48.
- Soetjiningsih & Ranuh G. (2014). *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.



**BAB 5**

**YOU SHOULD KNOW!**

**EVIDENCE BASED DALAM ASKEB BAYI, BALITA,  
DAN ANAK PRA SEKOLAH**

**Rahmah Fitria., S.ST.,M.Keb**



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**

## YOU SHOULD KNOW!

### EVIDENCE BASED DALAM ASKEB BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH

Rahmah Fitria., S.ST.,M.Keb

#### A. WHAT IS EVIDENCE BASED

*Evidence-based medicine* (EBM), Pengobatan berbasis bukti, yang pertama kali digunakan dalam literatur medis pada tahun 1991, telah berkembang menjadi *Evidence Based Practice* (EBP). EBM kadang-kadang digambarkan sebagai penggunaan data terbaru yang tersedia secara metodis, eksplisit, dan hati-hati saat membuat keputusan mengenai pengobatan pasien tertentu. Istilah *Evidence Based Practice* (EBP) pertama kali digunakan pada tahun 2005 oleh kelompok kerja EBM internasional, yang juga merilis “pernyataan sisilia tentang *Evidence Based Practice*,” yang mencakup definisi EBP yaitu keputusan mengenai perawatan medis didukung oleh bukti terbaik yang dapat diakses, terkini, valid, dan relevan. Pilihan ini harus dibuat oleh orang yang menerima perawatan, dipandu oleh pengetahuan implisit dan eksplisit dari mereka yang memberikan perawatan, dan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (Dawes et al., 2005).

*Evidence Based Practice* (EBP) memiliki beberapa definisi berbeda. Definisi, bagaimanapun, tidak cukup untuk membedakan antara proses berbasis bukti dan hasil berbasis bukti atau untuk menggambarkan prinsip dasar EBP. Ada kebutuhan akan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan Praktik Berbasis Bukti (EBP) (Dawes et al., 2005).

Dalam bahasa Inggris, *Evidence* artinya “bukti” dan *Based* artinya “dasar”. *Evidence based* berarti “berdasarkan bukti”. *Practice* artinya adalah praktik. Jadi *Evidence Based Practice* adalah Praktik yang dilakukan berdasarkan dari bukti. Bukti disini berasal dari penelitian-penelitian yang dibuktikan secara ilmiah.

*Evidence Based Practice* atau Praktik berbasis bukti didefinisikan sebagai pendekatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam praktik yang melibatkan penggunaan bukti (penelitian) terbaik saat ini, keahlian klinis, & preferensi pasien. Praktik berbasis bukti melibatkan penilaian kritis terhadap informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan klinis. *Evidence Based Practice* (Praktik berbasis bukti) secara universal diakui sebagai cara paling efektif untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi yang aman dan menghasilkan hasil yang positif. Akibatnya, menggunakan praktik berbasis bukti adalah keterampilan penting bagi praktisi kesehatan (Waite R., 2010).

*Evidence-based midwifery* adalah asuhan yang memastikan bahwa keputusan dibuat dalam praktik di lingkungan kebidanan berdasarkan bukti yang jelas dan dapat diterima yang mendukung praktik klinis mereka. Karena panduan mereka

dalam melakukan penelitian menyeluruh dalam praktiknya, pertanyaan PICOT memainkan peran penting dalam mengarahkan praktik berbasis bukti (Shadap, 2022).

Sepanjang karir mereka, petugas profesional pelayanan kesehatan harus dapat memperoleh, mengevaluasi, menerapkan, dan mengintegrasikan pengetahuan baru serta dapat berubah seiring waktu. Model EBP lima langkah harus menjadi dasar dari setiap kurikulum yang digunakan untuk mengajarkan keterampilan ini, dan penelitian yang berkelanjutan juga harus digabungkan. Instrumen penilaian inti untuk setiap langkah harus dibuat, diuji, dan dibuat dapat diakses public (Dawes et al., 2005). Semua tenaga kesehatan harus memahami dasar-dasar EBP, mengenali tindakan EBP, mempraktikkan EBP, dan mengadopsi pola pikir kritis terhadap penilaian klinis mereka sendiri dan penelitian yang tersedia. Tanpa keterampilan ini, para profesional dan organisasi akan kesulitan untuk memberikan 'praktik terbaik' (Dawes et al., 2005). Implementasi pedoman berdasar *Evidence Based Practice* dapat meningkatkan kualitas pelayanan perawatan pasien dengan mendukung intervensi yang terbukti bermanfaat, sementara mencegah intervensi yang tidak efektif atau berpotensi membahayakan (WHO, n.d.).

## **B. EVIDENCE BASED DALAM ASKEB BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH**

Beberapa *Evidence Based* dalam Askeb Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah:

1. *Evidence Based* pada penelitian Dinkevich, et al (2001) tentang *Evidence based well child care*:
  - a. Kunjungan yang lebih sedikit daripada jadwal standar untuk anak-anak hingga usia 2 tahun cukup untuk mendeteksi kelainan fisik dan hasil psikososial dan perkembangan
  - b. Asuhan yang diberikan secara kelompok dan asuhan yang diberikan secara individu memiliki keefektifan yang sama untuk pemeriksaan rutin
  - c. Tes *Adams forward bend* tidak cukup akurat untuk skrining skoliosis idiopatik
  - d. Membuktikan pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak dan menemukan cara baru dan lebih efektif untuk memberikan perawatan pencegahan kepada semua anak tetap menjadi tantangan utama (Dinkevich et al., 2001)
2. The US Preventive Services Task Force (USPSTF), Satuan Tugas Layanan Pencegahan AS merekomendasikan pemberian intervensi selama kehamilan dan setelah melahirkan untuk mendukung menyusui – Grade B (US Preventive Services Task Force, 2016)

Petugas kesehatan pelayanan primer dapat mendukung wanita sebelum dan sesudah melahirkan dengan memberikan intervensi secara langsung atau melalui rujukan untuk membantu mereka membuat pilihan yang tepat tentang

cara memberi makan bayi mereka dan agar berhasil dalam pilihan mereka. Intervensi termasuk mempromosikan manfaat menyusui, memberikan nasihat praktis dan dukungan langsung tentang cara menyusui, dan memberikan dukungan psikologis.

Intervensi dapat dikategorikan sebagai dukungan profesional, dukungan sebaya, dan pendidikan formal, meskipun tidak satu pun dari kategori ini yang saling eksklusif, dan intervensi dapat digabungkan di dalam dan di antara kategori. Intervensi juga dapat melibatkan pasangan wanita, anggota keluarga lain, dan teman (Barraza et al., 2020; US Preventive Services Task Force, 2016).

3. 2011 IOM Report = Merekomendasikan dukungan dan konseling laktasi yang komprehensif, dan biaya sewa peralatan menyusui. Penyedia yang terlatih harus memberikan layanan konseling kepada semua wanita hamil dan mereka yang berada dalam periode pascapersalinan untuk memastikan keberhasilan inisiasi dan durasi menyusui (Barraza et al., 2020).
4. 2016 Women's Preventive Services Initiative (WPSI) = Merekomendasikan layanan dukungan laktasi yang komprehensif (termasuk konseling, pendidikan, dan peralatan serta perlengkapan menyusui) selama periode antenatal, perinatal, dan pascapersalinan untuk memastikan keberhasilan inisiasi dan pemeliharaan menyusui (Barraza et al., 2020).
5. *Evidence Based* pada faktor pendukung peningkatan ASI Eksklusif:
  - a. Meningkatkan proporsi bayi yang disusui.
  - b. Meningkatkan proporsi lapangan pekerjaan yang memiliki program yang memberi dukungan laktasi.
  - c. Mengurangi proporsi bayi baru lahir yang mendapat ASI yang menerima suplementasi susu formula dalam 2 hari pertama kehidupan.
  - d. Meningkatkan proporsi kelahiran hidup yang terjadi di fasilitas yang menyediakan pelayanan yang direkomendasikan untuk ibu menyusui dan bayinya (Barraza et al., 2020).
6. *Evidence* pada upaya keberhasilan untuk memperbaiki pola makan pada anak:
  - a. Konseling gizi dan komunikasi perubahan sosial dan perilaku.
  - b. Konseling dan edukasi pakan responsif dan stimulasi.
  - c. Akses terhadap makanan pelengkap yang beragam dan bergizi di tingkat rumah tangga.
  - d. Penggunaan suplemen vitamin dan mineral pada tempat mana diet miskin nutrisi pada.
  - e. Akses terhadap pangan fortifikasi seperti kebutuhan, sesuai dengan standar global dan nasional.
  - f. Akses terhadap makanan bergizi dan terjangkau melalui program perlindungan sosial dan layanan penyuluhan.

- g. Akses terhadap air yang aman dan lingkungan rumah tangga yang bersih untuk anak-anak muda (UNICEF, 2020).

### **C. YOU CAN FIND THEM EVERYWHERE BUT PLEASE DON'T USE IT TO YOUR CHILDREN**

Semakin bertambah tahun, semakin banyak inovasi - inovasi terkini yang ditawarkan kepada Anda termasuk dalam hal merawat anak. Anda pasti ditawarkan pilihan-pilihan menarik yang membuat Anda ingin mengambil pilihan tersebut karena beranggapan itu akan mempermudah Anda merawat Anak dan terlihat sesuai jaman.

Namun sadarkah Anda bahwa tidak semua yang ditawarkan, viral, modern dan terlihat sesuai jaman itu aman? Anda diharapkan untuk berfikir kembali Apakah penawaran inovasi tersebut baik dan aman untuk buah hati Anda. Yuk kita bersama mempelajari benda-benda yang sering kita temui saat ini dalam merawat anak namun ternyata dilarang untuk digunakan karena dianggap berbahaya atau tidak bermanfaat untuk anak.

Berikut beberapa benda yang umum kita temui dalam perawatan buah hati kita namun ternyata dilarang digunakan:

#### **1. *Baby Neck Floats* (Pelampung Leher pada Bayi)**

Jangan Gunakan Pelampung Leher Bayi Karena Berisiko Meninggal atau Cedera. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (The U.S. Food and Drug Administration- FDA) telah mengeluarkan peringatan kepada orang tua, pengasuh, dan tenaga kesehatan profesional untuk tidak menggunakan pelampung leher kepada bayi selama intervensi terapi air, terutama jika bayi memiliki kebutuhan khusus atau keterlambatan perkembangan seperti spina bifida, sindrom Down, atau atrofi otot tulang belakang tipe 1 (SMA-1). Penggunaan produk ini membawa risiko kematian atau cedera yang sangat serius (FDA, 2022).

##### **a. Rekomendasi untuk Orang Tua dan Pengasuh oleh FDA (2022)**

- Jangan gunakan pelampung leher bayi untuk intervensi terapi air. Penggunaan produk ini, terutama pada bayi dengan keterlambatan perkembangan atau kebutuhan khusus, dapat menyebabkan kematian atau cedera serius.
- Ketahuilah bahwa penggunaan pelampung leher pada bayi berkebutuhan khusus dapat meningkatkan risiko ketegangan dan cedera leher.
- Ketahuilah bahwa pelampung leher ini belum dievaluasi oleh FDA dan kami tidak mengetahui adanya manfaat yang ditunjukkan dengan penggunaan pelampung leher untuk intervensi terapi air.
- Jika bayi atau orang yang Anda rawat terluka oleh pelampung leher, kami mendorong Anda untuk melaporkannya ke FDA. Laporan Anda, bersama

dengan informasi dari sumber lain, dapat membantu FDA mengidentifikasi dan lebih memahami risiko yang terkait dengan perangkat medis (FDA, 2022).

b. Rekomendasi untuk Penyedia Layanan Kesehatan

- Tinjau komunikasi keselamatan ini dengan kolega Anda, tim perawatan, orang tua, dan pengasuh bayi yang menggunakan pelampung leher untuk intervensi terapi air, untuk memastikan mereka mengetahui potensi risiko kematian atau cedera yang terkait dengan pelampung leher.
- Hindari penggunaan pelampung leher pada bayi dengan kondisi ini.
- Jika seorang pasien mengalami masalah dengan pelampung leher, laporkan ini ke FDA. Pelaporan efek samping yang cepat dapat membantu FDA mengidentifikasi dan lebih memahami risiko yang terkait dengan perangkat medis (FDA, 2022).

Bahaya menggunakan pelampung leher bayi termasuk tercekik, kerusakan leher, dan kematian karena tenggelam dan mati lemas. Bayi yang mengalami kelainan, termasuk spina bifida atau SMA Tipe 1, mungkin lebih rentan mengalami cedera parah (FDA, 2022).

Satu bayi yang meninggal dunia dan satu bayi yang dirawat di rumah sakit akibat penggunaan pelampung leher bayi keduanya diketahui oleh FDA. Dalam kedua kasus tersebut, bayi menderita kerugian karena tidak diawasi dengan ketat oleh pengasuhnya (FDA, 2022).

Tenaga kesehatan profesional, orang tua, dan pengasuh harus diberi tahu bahwa insiden ini dapat dan memang terjadi meskipun FDA percaya bahwa pelampung leher jarang menyebabkan kematian atau kerusakan serius. Kemungkinan lain adalah tidak semua kasus telah dilaporkan ke FDA (FDA, 2022).

2. *Baby Walker*

*Baby walker* digunakan di seluruh dunia sebagai perlengkapan menyenangkan tanpa bahaya. *Baby walker* adalah perangkat populer, yang digunakan orang tua untuk hiburan, menjaga keamanan bayi, dan promosi membantu berjalan pada anak. Berbeda dengan kepercayaan publik, beberapa peneliti mengklaim bahwa mereka dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan. Meskipun sumber penelitian yang menghasilkan efek negative penggunaan baby walker masih minim namun sebagian besar hasil penelitian menunjukkan tidak ada keuntungan dari walker dalam perkembangan anak (Badihian et al., 2017; Yaghini et al., 2020).

Kebanyakan orang tua percaya *baby walker* dapat membantu anak berjalan lebih awal, tetapi berdasarkan bukti saat ini keyakinan ini mungkin tidak benar. Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan tidak ada

keterlambatan perkembangan pada pengguna *baby walker*, orang tua harus menyadari kemungkinan efek dan bahaya negatifnya (Yaghini et al., 2020).

Hasil penelitian oleh Bezgin (2021) menunjukkan bahwa penggunaan *baby walker* dapat berdampak buruk pada perkembangan motorik bayi dan hal ini mungkin disebabkan oleh gangguan kontrol batang tubuh (Bezgin et al., 2021). Telah ditunjukkan bahwa penggunaan *baby walker* memiliki efek negatif pada neuromuskuler. Efek ini muncul pada setiap tahap perkembangan motorik dan di setiap bagian tubuh. Poin utama perkembangan motorik, terutama di tahun-tahun pertama kehidupan, adalah pengulangan dan pengalaman yang sering. Bayi yang mengalami gerakan yang sama berulang kali mengembangkan keterampilan motorik dengan cara ini. Setiap keterampilan motorik yang diperoleh membentuk dasar dari tahap perkembangan motorik selanjutnya. Di sisi lain, kontrol batang tubuh adalah poin kunci dari perkembangan motorik (Bezgin et al., 2021).

Bayi yang tidak membutuhkan kontrol karena penyangga tubuh yang disediakan oleh *baby walker* mengalami sedikit pelatihan neuromuskular dalam perkembangan motorik. Otot-otot yang harus sering mengalami posisi ekstensi melawan gravitasi pada tahap perkembangan motorik normal tetap tidak mencukupi dalam pengalaman ini di dalam sistem kursi. Sistem *baby walker* menyebabkan seorang anak menjadi pasif dalam arti tertentu, menyebabkan keterlambatan perkembangan dan kontrol batang tubuh dan ekstremitas bawah. Efek ini mungkin tidak tercermin dalam keseluruhan proses perkembangan motorik dengan menciptakan efek domino. Hal ini diduga menjadi alasan rendahnya skor kontrol batang tubuh pada bayi yang menggunakan *baby walker* (Bezgin et al., 2021).

*Baby walker* juga sering menjadi penyebab cedera bayi. Meskipun menyebabkan banyak cedera termasuk cacat dan kematian, *Baby walker* masih banyak digunakan oleh hampir semua keluarga. Pemerintah dan tenaga kesehatan harus membuat strategi untuk mempromosikan dampak penggunaan *Baby walker* secara lebih luas (Barss et al., 2016).

### 3. *Pacifier* (empeng/dot)

Penggunaan dot tersebar luas di kalangan bayi dan anak-anak di seluruh dunia. Dot sering digunakan untuk menenangkan bayi yang menangis, untuk meningkatkan kesejahteraan orang tua dan bayi, dan untuk mencegah mengisap jempol atau jari. Penggunaan dot di beberapa negara maju secara budaya ditetapkan sehingga prevalensinya mencapai 42,5% pada anak kecil pada usia 12 bulan. Mengisap dot adalah kebiasaan non-nutrisi yang umum dan telah mendapat banyak perhatian selama bertahun-tahun (Schmid et al., 2018).

Dot dikutip untuk pertama kalinya dalam literatur medis pada tahun 1473, dijelaskan oleh dokter Jerman Bartholomäus Metlinger dalam bukunya

"Kinderbüchlein," yang diberi judul ulang pada edisi selanjutnya sebagai "Ein Regiment der jungen Kinder" ("Panduan untuk Anak Muda"). Dot terdiri dari dot lateks atau silikon dengan pelindung dan pegangan plastik yang kokoh dan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada banyak jenis dot seperti dot konvensional NUK, dot fungsional Dentistar], dan dot ortodontik Curaprox Baby. Namun, definisi yang tepat untuk dot fungsional atau ortodontik tidak ada (Schmid et al., 2018).

Menurut penelitian non-acak, penggunaan dot konvensional dapat mengganggu perkembangan struktur orofasial, menyebabkan infeksi, mempersingkat durasi menyusui, dan menyebabkan maloklusi gigi. Efek dari penggunaan dot bergantung pada durasi dan frekuensi. Namun, penggunaan dot telah digambarkan memiliki efek perlindungan terhadap Sindrom Kematian Bayi Mendadak, tetapi tingkat buktinya sangat rendah, karena tidak ada RCT yang dapat menguji hipotesis yang disebutkan di atas secara andal (Schmid et al., 2018).

Dot yang dirancang untuk mengurangi efek samping, yang disebut dot ortodontik, telah diperkenalkan ke pasar atau telah digunakan untuk mengoreksi gigitan terbuka. Terdapat bukti moderat bahwa penggunaan empeng dikaitkan dengan gigitan terbuka anterior dan gigitan silang posterior, sehingga memengaruhi perkembangan harmonis struktur orofasial. Dot fungsional/ortodontik mengurangi prevalensi gigitan terbuka jika dibandingkan dengan dot konvensional, tetapi diperlukan bukti terkait efeknya pada gigitan silang posterior (Schmid et al., 2018).

Penggunaan dot dapat menjadi faktor risiko untuk penghentian dini pemberian ASI eksklusif. Para ibu harus diberi tahu tentang bahaya ini.

1. Ibu harus diajari teknik menenangkan bayinya yang tidak melibatkan penggunaan dot.
2. Studi kohort prospektif yang dirancang dengan baik dalam latar sosial-ekonomi dan budaya yang beragam diperlukan untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa penggunaan dot hanyalah penanda kesulitan menyusui atau motivasi ibu untuk menghentikan ASI eksklusif.
3. Studi kualitatif diperlukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang alasan di balik pengenalan penggunaan dot pada populasi yang beragam.
4. Rekomendasi penggunaan dot perlu didasarkan pada pendekatan manfaat-risiko yang berfokus pada pertukaran antara hasil menyusui terkait dot dan SIDS (Buccini et al., 2017).

#### D. REFERENSI

- Badihian, S., Adihian, N., & Yaghini, O. (2017). The Effect of Baby Walker on Child Development: A Systematic Review. *Iranian Journal of Child Neurology*, 11(4), 1–6.
- Barraza, L., Lebedevitch, C., & Stuebe, A. (2020). The Role of Law and Policy in Assisting Families to Reach Healthy People ' s Maternal , Infant , and Child Health Breastfeeding Goals in the United States. *ODHP*.
- Barss, P., Grivna, M., Al-Hanaee, A., Al-Dhahab, A., Al-Kaabi, F., & Al-Muhairi, S. (2016). Baby walker injury, disability, and death in a high-income middle eastern country, as reported by siblings. *Injury Epidemiology*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.1186/s40621-016-0082-7>
- Bezgin, S., Uzun Akkaya, K., Çelik, H. İ., Duyan Çamurdan, A., & Elbasan, B. (2021). Evaluation of the effects of using a baby walker on trunk control and motor development. *Turkish Archives of Pediatrics*, 56(2), 159–163. <https://doi.org/10.14744/TurkPediatriArs.2020.48742>
- Buccini, G. D. S., Pérez-Escamilla, R., Paulino, L. M., Araújo, C. L., & Venancio, S. I. (2017). Pacifier use and interruption of exclusive breastfeeding: Systematic review and meta-analysis. *Maternal & Child Nutrition*, 13(3). <https://doi.org/10.1111/mcn.12384>
- Dawes, M., Summerskill, W., Glasziou, P., Cartabellotta, N., Martin, J., Hopayian, K., Porzolt, F., Burls, A., & Osborne, J. (2005). Sicily statement on evidence-based practice. *BMC Medical Education*, 5(1), 1. *BMC Medical Education*, 5, 1. <https://doi.org/10.1186/1472-6920-5-1>
- Dinkevich, E., Hupert, J., & Moyer, V. A. (2001). Evidence based well child care. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 323(7317), 846–849. <https://doi.org/10.1136/bmj.323.7317.846>
- FDA. (2022). *Do Not Use Baby Neck Floats Due to the Risk of Death or Injury: FDA Safety Communication*. FDA. <https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-baby-neck-floats-due-risk-death-or-injury-fda-safety-communication>
- Schmid, K. M., Kugler, R., Nalabothu, P., Bosch, C., & Verna, C. (2018). The effect of pacifier sucking on orofacial structures: a systematic literature review. *Progress in Orthodontics*, 19(1), 8. <https://doi.org/10.1186/s40510-018-0206-4>

- Shadap, A. (2022). *Evidence based practice in midwifery care*. February. <https://doi.org/10.33545/26642298.2022.v4.i1a.75>
- UNICEF. (2020). Improving Young Children's Diets During The Complementary Feeding Period. *UNICEF Programming Guidance.*, 76.
- US Preventive Services Task Force. (2016). Primary Care Interventions to Support Breastfeeding. *JAMA*, 316(16). <https://doi.org/10.1001/jama.2016.14697>
- Waite R., K. P. (2010). *Evidence-Based Practice – Nurses need to apply all sources of evidence relate to their practice area to develop effective nursing practice strategies*. <http://nursing.advanceweb.com/Article/Evidence-Based-Practice-6.aspx>
- WHO. (n.d.). *Promoting evidence-based care in childbirth and maternal health*. <https://www.who.int/europe/activities/promoting-evidence-based-care-for-child-birth>
- Yaghini, O., Goodarzi, M., Khoei, S., & Shirani, M. (2020). Effect of Baby Walker Use on Developmental Status based on Ages and Stages Questionnaire Score (ASQ). *Iranian Journal of Child Neurology*, 14(1), 105–111.

**BAB 6**

**POLA ASUH ORANG TUA**

**DAN KECANDUAN SMARTPHONE PADA ANAK**

**Brivian Florentis Yustanta., SST., M.Kes**



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**

# **POLA ASUH ORANG TUA DAN KECANDUAN SMARTPHONE PADA ANAK**

Brivian Florentis Yustanta., SST., M.Kes

## **A. PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi, kemajuan teknologi di Indonesia semakin meningkat. Penggunaan teknologi telah menyebar di kalangan masyarakat, terutama smartphone. Smartphone merupakan perangkat handphone yang mempunyai kapasitas dan fungsi serupa dengan komputer. Smartphone memiliki fungsi dalam berbagai bidang, sehingga banyak digunakan oleh berbagai kalangan termasuk anak-anak. Bahkan banyak orang tua yang memperkenalkan smartphone kepada anak berusia dibawah 5 tahun dengan alasan untuk mengalihkan anak mereka agar tidak rewel (Purnama, 2018).

Indonesia termasuk dalam peringkat 5 besar negara pengguna gadget, khususnya smartphone. Terdapat 40% anak Indonesia usia 0-8 tahun telah mengenal smartphone. Di Jawa Timur dijumpai 34% anak usia prasekolah mendapatkan smartphone dari ibunya. Pengguna smartphone dari golongan anak-anak sesuai dengan tingkat pendidikannya, yaitu sebanyak 21,08% anak-anak belum sekolah, 40.87% anak-anak tingkat Sekolah Dasar, 59.89% anak-anak dari tingkat SMP, dan 79.56% anak-anak SMA telah menggunakan smartphone. Anak-anak berusia 4-6 tahun yang belajar di salah satu TK di Yogyakarta telah menggunakan smartphone sebanyak 94% (Fatkuriyah, 2021).

Pada tahun 2021 terdapat lebih dari 5 miliar orang dari 7 miliar manusia di seluruh dunia telah menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Data tersebut menunjukkan lebih dari 66% populasi telah terikat dengan smartphone. *National Information Society Agency South Korea* menyebutkan bahwa prevalensi kecanduan smartphone sekitar 8,4%. Angka tersebut melebihi angka prevalensi kecanduan internet. Sebagai orang terdekat dalam keluarga, kontrol sosial dari orang tua sangat penting dalam mengarahkan anak agar mampu menggunakan smartphone dengan bijak dan memiliki batasan dalam penggunaan. Smartphone memiliki berbagai fitur dan aplikasi yang menarik dan berbagai variasi di dalamnya sehingga menyebabkan anak selalu ingin menggunakannya (Primihastuti, 2022).

Pemakaian smartphone yang tidak mempunyai batasan serta penggunaan dalam waktu yang lama dan berulang-ulang dapat berdampak negatif bahkan dapat menyebabkan kecanduan smartphone. Akibatnya, anak akan mencari kesenangan dengan bermain smartphone, karena sudah terpola sejak awal perkembangannya. Kehadiran smartphone seakan menggantikan posisi orang tua dalam penerapan pola asuh anak. Anak senang dan sibuk dengan smartphonenya, sedangkan orang tua kurang mengawasi dan mengontrol anak dalam menggunakan smartphone. Sehingga

banyak anak yang menarik diri di kamar dengan smartphonenya, sedangkan orang tua tidak mengetahui apa yang dilihatnya (Hafilda, 2021).

## **B. POLA ASUH ORANG TUA**

### **1. Definisi Pola Asuh**

- a. Pola asuh merupakan pola perilaku yang diterapkan kepada anak dalam waktu yang relatif konsisten (Kyle, 2015).
- b. Pola asuh merupakan suatu sikap, mendidik, membimbing, dan interaksi orang tua kepada anak untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan anak dan harapan orang tua semoga anak bisa sukses (Raudhati, 2022).
- c. Pola asuh merupakan pola asuh pada anak yang terjadi dalam keluarga, yaitu bagaimana cara keluarga membentuk perilaku anak atau generasi berikutnya yang sesuai dengan tatanan norma dan nilai yang baik serta berlaku dalam kehidupan masyarakat (Susilowati, 2012).
- d. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai perilaku atau interaksi antara orang tua dan anak dengan waktu yang relatif konsisten dalam mendidik, memelihara, membimbing, serta cara orang tua mengatur sekaligus mendisiplinkan anak supaya anak dapat mencapai kedewasaan sesuai dengan tatanan dan norma yang baik di masyarakat (Samsudin, 2019).
- e. Menurut penulis, pola asuh merupakan perilaku atau interaksi antara orang tua dengan anak dalam memelihara, membimbing, mendidik, sekaligus bagaimana cara mendisiplinkan anak supaya dapat mencapai kedewasaan sesuai dengan tatanan dan norma yang baik di masyarakat. Pola asuh orang tua sangat diperlukan dalam mengawasi dan mengontrol anak dengan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat berkembang pesat. Supaya anak tetap dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang sesuai.

### **2. Jenis Pola Asuh**

Pola asuh orang tua dibagi menjadi tiga jenis, yaitu otoriter (authoritarian), pola asuh demokratis (authoritative), pola asuh permisif (permissive) (Adawiyah, 2014).

#### **a. Pola Asuh Otoriter**

Pola asuh otoriter adalah cara mendidik anak dengan kepemimpinan otoriter, kepemimpinan otoriter yaitu pemimpin menentukan semua kebijakan, langkah dan tugas yang harus dilaksanakan.

Pola asuh otoriter ditandai pada cara pengasuhan anak-anak yang bertindak keras, ketat, terdapat hukuman-hukuman, sering memaksa anak supaya seperti orang tua (dirinya), membatasi anak untuk bebas bertindak atas nama sendiri,

jarang mengajak anak berkomunikasi, bercerita, bercengkerama, dan bertukar pikiran dengan orang tua.

Orang tua dengan pola asuh otoriter cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan, dan kedekatan emosi orang tua dan anak sehingga seakan memiliki dinding pembatas antara orang tua dengan anak.

b. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ditandai adanya pengakuan dari orang tua pada kemampuan anak, serta anak diberi kesempatan supaya tidak selalu bergantung pada orang tua.

Pola asuh ini sedikit memberi kebebasan kepada anak supaya anak dapat memilih sesuatu yang terbaik bagi dirinya, mendengarkan pendapat anak, melibatkan anak dalam pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan dalam mengontrol internalnya sehingga anak dapat berlatih bertanggung jawab kepada dirinya sendiri.

c. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif yaitu membiarkan anak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, tanpa hukuman dan pengendalian dari orang tua.

Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa serta orang tua tidak memberikan aturan dan pengarahan kepada anak. Sehingga anak akan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, meskipun terkadang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

### **3. Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh**

a. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang muncul dari dalam diri yang dapat memengaruhi orang tua dalam memberikan pola asuh mendidik anak (Jannah, 2017).

1) Hereditas atau keturunan

Hereditas atau keturunan merupakan faktor pertama yang memengaruhi perkembangan individu. Pada kenyataannya dalam suatu keluarga akan berusaha melahirkan keturunan yang dapat menjalankan atau mewarisi apa yang dimiliki orang tuanya, meliputi : harta, jabatan, dan segala bentuk kebudayaan.

Keturunan dipandang sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau semua potensi baik psikis maupun fisik yang dimiliki individu. Yang diturunkan orang tua kepada anak adalah watak (sifat strukturnya) bukan tingkah laku yang berasal dari hasil belajar atau pengalaman.

Sebagai contoh pada orang tua yang berasal dari cendekiawan maka keturunannya tidak jauh berbeda dari orang tuanya, seperti berwibawa, pintar, dan kutu buku. Contoh lain dari keturunan dari orang tua saudagar maka keturunannya juga tidak jauh berbeda dengan orang tua, seperti wataknya perhitungan dan pekerja keras.

2) Usia orang tua

Orang tua dengan usia muda cenderung lebih demokratis dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Semakin dekat jarak usia antara orang tua dan anak, maka semakin kecil perbedaan budaya dalam kehidupan mereka sehingga orang tua lebih mudah dalam memahami anaknya.

3) Jenis kelamin orang tua

Orang tua perempuan (ibu) cenderung lebih mengerti dan memahami tentang anaknya, sedangkan orang tua laki-laki (ayah) akan cenderung memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi dan memenuhi segala kebutuhan anaknya.

4) Usia anak

Pada anak yang masih usia anak-anak orang tua cenderung memberikan pola asuh otoriter dan permisif, sedangkan pada anak dengan usia remaja maka orang tua cenderung memberikan pola asuh demokrasi dan situasional.

5) Jenis kelamin anak

Pada orang tua yang mempunyai anak perempuan, umumnya mendidik dan mengasuh anak secara ketat, berbeda dengan pola pengasuhan anak laki-laki.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang muncul dari luar yang dapat memengaruhi orang tua dalam memberikan pola asuh mendidik anak (Ajhuri, 2019).

1) Budaya

Orang tua cenderung memegang teguh konsep tradisionalnya tentang konsep mendidik anak. Apabila orang tua merasa bahwa orang tua mereka mendidik mereka dengan baik, maka mereka akan menggunakan teknik sama dengan dalam mendidik anaknya. Sedangkan jika mereka merasa teknik yang digunakan orang tua mereka kurang baik atau salah, maka mereka akan mencari teknik pengasuhan yang lain.

Selain itu, orang tua sering mengikuti cara-cara pengasuhan anak dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak menuju kematangan. Orang tua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima di masyarakat dengan baik, sehingga kebudayaan atau kebiasaan yang ada di masyarakat dalam

mengasuh dan mendidik anak dapat memengaruhi orang tua dalam memberikan pola asuh kepada anaknya.

2) Pengetahuan orang tua

Orang tua dengan tingkat pengetahuan yang lebih rendah cenderung kurang berhati-hati dalam mendidik anak dibandingkan dengan orang tua dengan tingkat pengetahuan lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan orang tua terkait pola asuh anak, maka semakin tinggi cara memahami orang tua terhadap anaknya. Sehingga akan berdampak pada perkembangan kepribadian dan perilaku anak.

3) Status sosial ekonomi

Orang tua dengan status sosial ekonomi yang kurang atau kelas menengah ke bawah cenderung lebih keras, memaksa, dan kurang toleran pada sang anak dibandingkan dengan orang tua dari kelas atas, tetapi mereka lebih konsisten.

4) Lingkungan

Lingkungan termasuk faktor yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan kepribadian perilaku sosial budaya anak. Lingkungan dengan sosial budaya yang cukup baik cenderung memungkinkan tercapainya pembentukan kepribadian anak yang baik. Sedangkan lingkungan dengan sosial budaya yang kurang baik maka akan menghambat perkembangan pembentukan kepribadian dan perilaku anak.

#### 4. Kepribadian Anak Berdasarkan Pola Asuh

Pembentukan kepribadian anak dipengaruhi oleh semua unsur lingkungan yaitu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dari ketiga lingkungan tersebut yang paling berpengaruh terhadap kepribadian anak yaitu lingkungan keluarga, karena dalam keluarga semua anggota dapat saling membantu dan saling memengaruhi (Susanti, 2021).

**Tabel 6.1 Kepribadian Anak Berdasarkan Pola Asuh**

| Ragam Pola Asuh                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Penerapan Pola Asuh                                                      | Kecenderungan Kepribadian Anak          |
| <b>Otoriter :</b>                                                        |                                         |
| - Hukuman yang keras                                                     | - Mudah tersinggung                     |
| - Suka menghukum secara fisik                                            | - Penakut                               |
| - Bersikap mengomando                                                    | - Pemurung tidak bahagia                |
| - Bersikap kaku (keras)                                                  | - Mudah terpengaruh dan mudah stress    |
| - Emosional dalam bersikap menolak                                       | - Tidak mempunyai masa depan yang jelas |
| - Harus mematuhi peraturan-peraturan orang tua dan tidak boleh membantah | - Tidak bersahabat                      |
|                                                                          | - Gagap (rendah diri)                   |

---

**Demokratis :**

- |                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| - Menyediakan waktu                          | - Bersikap bersahabat                        |
| - Berkomunikasi secara pribadi               | - Percaya kepada diri sendiri                |
| - Menghargai anak                            | - Mampu mengendalikan diri                   |
| - Mengerti anak                              | - Memiliki rasa sopan                        |
| - Mempertahankan hubungan                    | - Mau bekerja sama                           |
| - Menerima kritik/diskusi                    | - Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi       |
| - Sikap terbuka antara orang tua dan anaknya | - Mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas |
|                                              | - Berorientasi terhadap prestasi             |
- 

**Permisif :**

- |                                                                  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| - Kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah                   | - Agresif                                                   |
| - Memberikan kebebasan kepada anak untuk keinginannya            | - Menentang atau tidak dapat bekerja sama dengan orang lain |
| - Anak dibiarkan melakukan sesuatu yang dianggap benar oleh anak | - Emosi kurang stabil                                       |
| - Tidak diberikan hukuman karena tidak ada aturan yang mengikat  | - Selalu berekspresi bebas                                  |
| - Kurang membimbing                                              | - Selalu mengalami kegagalan karena tidak ada bimbingan     |
| - Anak lebih dominan berperan daripada orang tua                 |                                                             |
| - Kurang tegas dan kurang komunikasi                             |                                                             |
- 

Sumber : Ayun, 2017

### C. KECANDUAN SMARTPHONE PADA ANAK

#### 1. Definisi Smartphone

Smartphone merupakan ponsel yang dapat menjalankan sistem operasi terbuka yang mengunduh aplikasi yang ditulis oleh pengembang dari luar. Smartphone membuat dunia maya menjadi bagian yang penting dalam interaksi sosial sehari-hari, mudah diakses secara nirkabel, dan menjadikan hubungan online dapat dilakukan selama 24 jam. Smartphone juga memiliki fitur yang biasanya tidak digunakan oleh ponsel biasa, seperti layar sentuh, tampilan dengan kualitas yang tinggi, browser berforma internet lengkap, perangkat lunak canggih yang secara otomatis dapat menjangkau fitur e-mail, kamera dengan kualitas tinggi, serta pemutar musik dan video (Nurhidayah, 2021).

#### 2. Dampak Penggunaan Smartphone

Penggunaan smartphone memiliki dampak positif dan negatif bagi anak, berikut penjelasannya (Agusta, 2016).

a. Dampak Positif

- 1) Berkembangnya imajinasi dan kreativitas anak. Ketika anak melihat sebuah gambar lalu menggambar kembali sesuai dengan imajinasinya dapat melatih daya pikir tanpa dibatasi kenyataan.
- 2) Melatih kecerdasan dan menambahkan wawasan anak. Anak dapat terbiasa dengan tulisan, gambar, angka yang membantu melatih proses belajar.
- 3) Meningkatkan rasa percaya diri. Ketika anak memenangkan suatu permainan maka akan termotivasi untuk menyelesaikan permainan yang lain.
- 4) Melatih kemampuan dalam membaca, matematika, serta pemecahan masalah.
- 5) Memudahkan dalam mencari dan mengetahui informasi terbaru. Anak akan timbul sifat dasar rasa ingin tahu pada suatu hal yang membuat timbulnya kesadaran pada anak untuk kebutuhan belajar dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa.
- 6) Memperbanyak teman tanpa dibatasi jarak dan waktu.

b. Dampak Negatif

1) Penurunan konsentrasi ketika belajar

Ketika anak belajar, anak menjadi tidak fokus dan hanya teringat smartphone, misalnya anak akan teringat dengan game yang ada di smartphone seolah-olah dia menjadi seperti pemeran dalam permainan tersebut.

2) Malas membaca dan menulis

Ini diakibatkan dari pemakaian smartphone, seperti ketika anak membuka video di youtube maka anak cenderung hanya melihat gambar tanpa harus menulis apa yang mereka cari.

3) Kemampuan bersosialisasi menurun

Sebagai contoh ketika anak kurang bermain dengan teman yang ada di lingkungannya serta tidak menghiraukan keadaan disekitarnya.

4) Kecanduan

Dalam hal ini anak akan sulit terlepas dari ketergantungan smartphone karena telah menjadi suatu hal yang menjadi kebutuhan bagi anak.

3. Definisi Kecanduan Smartphone

Kecanduan merupakan kebiasaan untuk terlibat dalam suatu aktivitas tertentu atau menggunakan substansi tertentu, tanpa memperhatikan konsekuensi yang buruk baik dari segi kesehatan fisik, mental, sosial, spiritual, maupun finansial dari tiap individu.

Jenis kecanduan ada dua macam yaitu kecanduan fisik dan kecanduan non fisik. Bentuk dari kecanduan fisik misalnya berkaitan dengan kecanduan alkohol,

kokain, dan zat zat psikotropika lainnya. Sedangkan bentuk dari kecanduan non fisik yaitu smartphone addiction, game addiction, internet addiction, dan lainnya. Kecanduan smartphone diartikan sebagai:

- a. Seseorang tidak dapat mengendalikan keterikatannya pada penggunaan teknologi berbasis internet (Oliveira, 2012).
- b. Keadaan ketidakmampuan seseorang menyesuaikan kehidupan sehari-hari, serta selalu terobsesi atau ketergantungan dengan penggunaan smartphone dan merasa cemas apabila tidak menggunakan smartphone (Ula, 2021).
- c. Perilaku keterikatan atau kecanduan terhadap smartphone yang menimbulkan masalah seperti menarik diri serta kesulitan dalam performa aktivitas sehari-hari, atau juga sebagai gangguan kontrol terhadap diri seseorang (Setianingsih, 2018).
- d. Menurut penulis, kecanduan smartphone merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan diri baik dari segi fisik maupun emosi dalam menggunakan smartphone sehingga berdampak pada kehidupan sehari-hari.

#### 4. Aspek Kecanduan Smartphone

##### a. Aktivitas Kehidupan Sehari-hari Terganggu (Daily Life Disturbance)

Gangguan pada aktivitas meliputi gangguan tidur, istirahat, tidak melakukan pekerjaan yang telah direncanakan, kesulitan dalam berkonsentrasi, pusing, penglihatan kabur, sakit pada pergelangan tangan dan leher bagian belakang. Pengguna smartphone mengalami kesulitan konsentrasi karena smartphone selalu ada di pikiran. Sakit pada pergelangan dan leher belakang disebabkan karena intensitas penggunaan smartphone yang terlalu lama.

##### b. Positive Anticipation

Seseorang merasa bersemangat menjadikan smartphone sebagai sarjana penghilang stres dan seseorang akan merasa hampa tanpa smartphone. Menurut sebagian besar pengguna, smartphone bukan hanya perangkat alat komunikasi dan sarana bermain game. Smartphone dianggap sebagai teman yang dapat memberikan rasa aman, kesenangan, mengurangi kelelahan, dapat mengurangi rasa cemas sehingga seseorang akan bersemangat dan terus menerus menggunakan smartphone.

##### c. Mengalami Penarikan (Withdrawal)

Penarikan ini meliputi tidak sabaran, tidak toleran, dan tidak dapat bertahan tanpa smartphone. Jika tidak sedang menggunakan smartphone, seseorang akan terus memikirkannya. Perubahan yang terjadi jika tanpa menggunakan smartphone meliputi perubahan suasana hati, ketidakstabilan, dan kekhawatiran.

##### d. Berhubungan di Dunia Maya (Cyberspace Oriented-Relationship)

Seseorang akan merasa bahwa pertemanan di dunia maya lebih menyenangkan daripada dunia nyata, serta merasa pertemanan di dunia nyata menjadi tidak

akrab. Sehingga jika seseorang tidak dapat menggunakan smartphone maka akan merasa kehilangan dan terus mengecek smartphone.

e. Penggunaan berlebih (Overuse)

Tidak ada kontrol atau kendali dalam menggunakan smartphone, menghabiskan waktu sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. lebih memilih mencari suatu hal yang ada di smartphone daripada meminta bantuan orang sekitar, menyiapkan pengisian daya setiap saat, selalu merasa ingin menggunakan smartphone saat tidak sedang menggunakan smartphone.

f. Toleransi (Tolerance)

Pengguna smartphone berusaha mengendalikan waktu penggunaan smartphone tetapi selalu gagal melakukannya.

(Nurjanah, 2018)

5. Ciri-ciri kecanduan Smartphone

- a. Anak menghabiskan sebagian banyak waktunya untuk bermain smartphone.
- b. Anak tidak menghiraukan kebutuhan lain yang wajib dilakukan seperti lupa mandi dan makan.
- c. Anak tidak menghiraukan teguran dari orang sekitar.
- d. Anak malas untuk beraktivitas.
- e. Sering membantah perintah yang menghalangi anak untuk memakai smartphone.
- f. Sensitif atau mudah tersinggung.
- g. Egois dan sulit berbagi waktu.
- h. Sering berbohong.

(Feryando, 2022)

6. Penilaian Penggunaan Smartphone

Penilaian penggunaan smartphone yang baik pada anak prasekolah yaitu dengan kategori rendah dimana menggunakan smartphone kurang dari 30 menit dalam sehari serta maksimal 2 kali penggunaan. Apabila anak menggunakan smartphone lebih dari 75 menit dalam sehari dan lebih dari 3 kali penggunaan, maka akan menimbulkan kecanduan dalam penggunaan smartphone. Pemakaian smartphone yang lebih dari empat jam dalam sehari dapat menyebabkan parahnya kecenderungan kecanduan (Kwon, 2013).

7. Faktor Penyebab Kecanduan Smartphone

a. Faktor Internal

Faktor internal ini meliputi faktor-faktor yang menggambarkan karakteristik individu, yaitu :

1) Tingkat sensation seeking tinggi

Sensation seeking atau bisa disebut dengan pencarian sensasi adalah sifat yang diartikan sebagai kebutuhan-kebutuhan yang beragam, baru, dan

sensasi-sensasi kompleks dan keinginan untuk mengambil resiko, baik secara fisik maupun secara sosial.

2) Self-esteem yang rendah

Self esteem merupakan evaluasi diri seseorang terhadap kualitas atau keberhargaan diri sebagai manusia.

3) Kepribadian ekstraversi tinggi

4) Kontrol diri rendah

Kontrol diri yaitu kemampuan seseorang untuk menyusun, membimbing, mengatur, serta mengarahkan langkah-langkah dan tindakannya untuk mendapatkan yang diinginkan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini berkaitan dengan tingginya paparan smartphone dan berbagai fasilitasnya. Faktor eksternal meliputi :

1) Attachment to significant others

2) Family disfunction

3) Positive reinforcement

4) Aktivitas ponsel

5) Student-student relationship

6) Kualitas persahabatan

7) Stres akademik.

c. Faktor Situasional

Faktor situasional ini meliputi faktor-faktor penyebab yang mengacu pada pemakaian smartphone sebagai sarana agar seseorang merasa nyaman secara psikologis saat menghadapi situasi yang tidak nyaman. Dalam hal ini seseorang akan bertindak cepat saat berada di lingkungan yang tidak nyaman dengan mengalihkan perhatian ke smartphone.

d. Faktor Sosial

Faktor sosial ini meliputi faktor penyebab kecanduan smartphone sebagai sarana interaksi dan menjaga kontak dengan orang lain. Dalam hal ini, seseorang akan melakukan interaksi melalui smartphone karena cenderung malas untuk berinteraksi secara langsung(36).

e. Faktor Demografi

1) Jenis kelamin

2) Demografi dan school life

3) Durasi penggunaan smartphone

(Aulia, 2019)

8. Dampak Kecanduan Smartphone

Dampak yang ditimbulkan dari kecanduan smartphone meliputi :

a. Kompulsivitas

Pemakaian smartphone yang berlebihan dapat berdampak pada psikologis, fisik, serta lingkungan sosial seseorang sehingga berakibat pada perilaku impulsif. Sebagai contoh nyata yaitu ketika seseorang selalu melihat smartphone sebelum tidur, lalu ketika bangun tidur hal pertama yang dilakukan adalah melihat smartphone.

b. Functional disorder

Gangguan fungsional yaitu permasalahan yang disebabkan oleh ketergantungan smartphone seperti pengelolaan waktu, kesehatan fisik dan mental, serta interpersonal. Dampak yang ditimbulkan dari kecanduan smartphone dilihat dari interpersonal yaitu empati berkurang, kepedulian dan penarikan diri pada lingkungan sosial dan lebih memilih untuk berinteraksi di dunia maya dengan smartphone. Radiasi yang dihasilkan layar smartphone dapat memengaruhi fungsi otak dan dapat menimbulkan sakit kepala serta gangguan tidur.

c. Interaksi sosial

Akibat dari pemakaian smartphone yang berlebihan, menyebabkan kualitas hubungan sesama di lingkungan sosial terganggu. Banyak anak lebih memilih memainkan smartphone yang dimilikinya dibandingkan bermain dengan teman sebayanya (Chiu, 2016).

9. Pencegahan Kecanduan Smartphone

Kualitas pola asuh dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pengasuhan merupakan faktor utama yang memengaruhi perkembangan anak. Jika di rumah terdapat internet, diperlukan seseorang yang dapat memantau apa yang dilakukan anak dalam mengakses internet (Park, 2014).

Orang tua perlu memberi batasan waktu pada anak dalam memakai smartphone dan internet. Orang tua juga memberikan pemahaman dan kesadaran terkait dampak negatif dari internet dan atau smartphone. Diperlukan pengawasan khusus dari orang tua agar anak tidak terpengaruh ketergantungan smartphone, karena orang tua perlu memberi batasan kepada anak dalam menggunakan smartphone serta tidak membiarkan anak melalaikan tanggung jawabnya, seperti mandi, belajar, makan, juga bermain dengan teman untuk bersosialisasi dengan baik (Bahadir, 2014).

**D. POLA PENGAWASAN ORANG TUA DALAM PENGGUNAAN SMARTPHONE / INTERNET (*INTERNET PARENTING STYLE*)**

Pola pengawasan orang tua yang berkaitan dengan pemanfaatan internet (*internet parenting style*) dibagi menjadi beberapa model pengawasan. Model pengawasan tersebut terdiri dari *active mediation*, *restrictive*, dan *coviewing* (Adi, 2017).

### 1. Active Mediation

Model pengawasan jenis ini diwujudkan dengan adanya percakapan antara orang tua dan anak dalam pembahasan internet. Percakapan ini merupakan inisiatif dari orang tua yang bertujuan mendorong anak-anaknya sehingga lebih kritis dalam menggunakan internet.

### 2. Restrictive Mediation

Pola pengawasan ini dinyatakan dalam bentuk pembatasan dari orang tua dengan mengatur secara tegas apa yang bisa diakses, serta berapa lama mengakses termasuk game online yang bisa dimainkan anak-anak.

### 3. Coviewing

Pola pengawasan ini merupakan suatu upaya melakukan tindakan secara bersama-sama antara orang tua dan anak dalam aktivitasnya dengan internet.

## **E. HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DAN KECANDUAN SMARTPHONE PADA ANAK**

Smartphone telah digunakan oleh berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak bahkan pada usia pra sekolah. Anak menjadi salah satu pengguna aktif smartphone. Smartphone mempunyai dampak positif bagi anak yaitu membangun kreativitas, menambah wawasan, memperbanyak teman, dan mudah mendapatkan informasi terbaru. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan smartphone yaitu penurunan konsentrasi ketika belajar, malas membaca dan menulis, penurunan kemampuan bersosialisasi, serta kecanduan smartphone (Mulawarman, 2020).

Pengenalan smartphone bermula dari memperlihatkan video atau game pada anak, sehingga memicu timbulnya rasa keingintahuan anak. Terdapat hormon endorfin di bagian otak belakang, yang berfungsi mengatur kesenangan dan kenyamanan. Pada saat anak bermain smartphone, maka akan muncul rasa senang sehingga memicu munculnya hormon endorfin. Anak akan cenderung mengulangi hal yang membuat dirinya senang. Jika hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berkepanjangan, maka akan berhubungan dengan kecanduan (Suherman, 2019).

Pemakaian smartphone yang tidak mempunyai batasan serta penggunaan dalam waktu yang lama dan berulang-ulang dapat berdampak negatif bahkan dapat menyebabkan kecanduan smartphone. Akibatnya, anak akan mencari kesenangan dengan bermain smartphone, karena sudah terpolakan sejak awal perkembangannya. Kehadiran smartphone seakan menggantikan posisi orang tua dalam penerapan pola asuh anak. Anak senang dan sibuk dengan smartphonenya, sedangkan orang tua kurang mengawasi dan mengontrol anak dalam menggunakan smartphone. Sehingga banyak anak yang menarik diri di kamar dengan smartphonenya, sedangkan orang tua tidak mengetahui apa yang dilihatnya (Primiastuti, 2022).

Dalam sebuah penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kecanduan gadget pada anak prasekolah. Dalam penelitian

Anggreni (2019) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan lama penggunaan gadget anak prasekolah. Penelitian yang serupa menunjukkan bahwa terdapat hubungan pola asuh orang tua pada anak sekolah dasar dengan kecanduan gadget di masa pandemi Covid-19 (Theopilus, 2022). Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat diartikan bahwa pola asuh orang tua berhubungan dengan kecanduan smartphone pada anak.

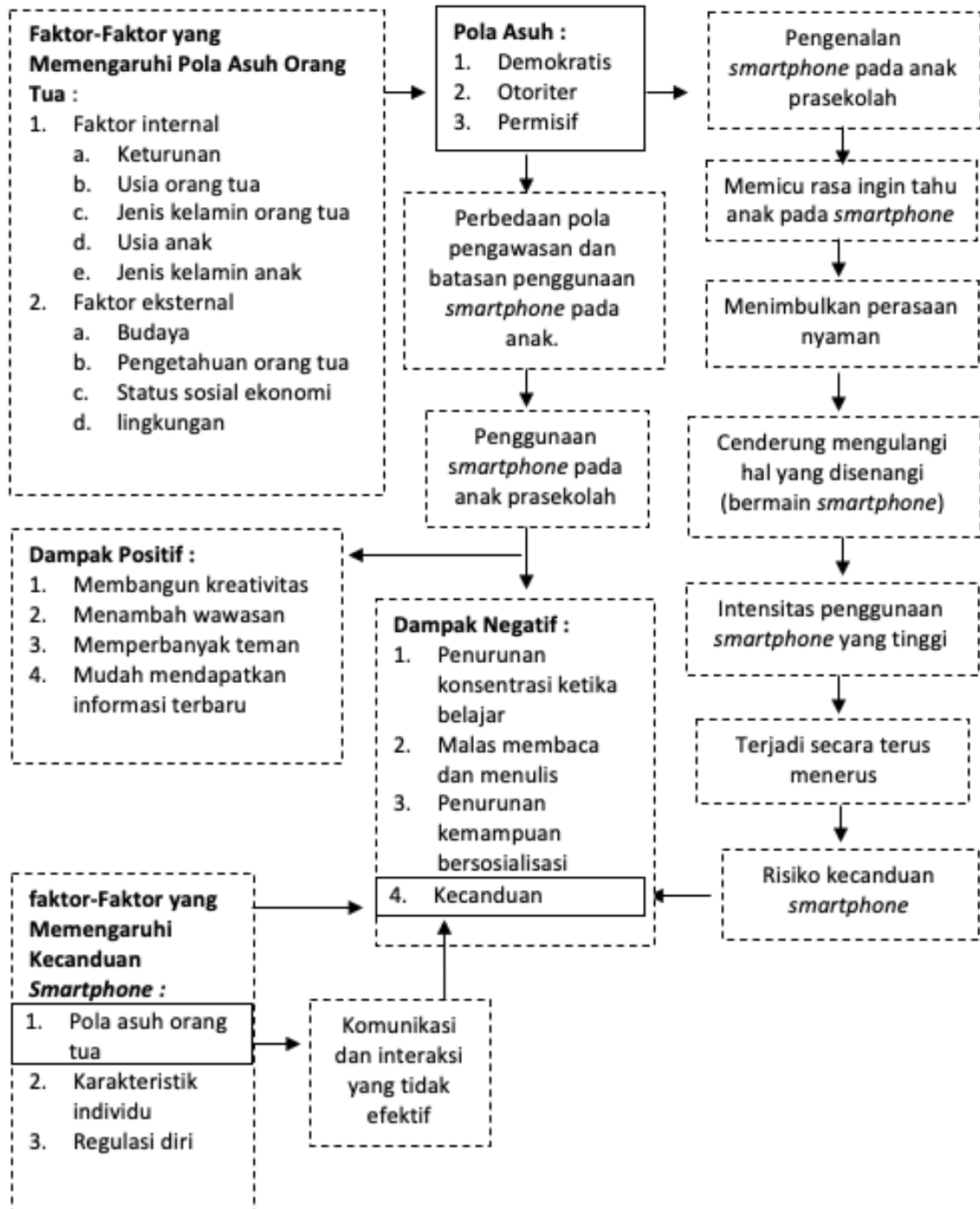
Salah satu faktor yang memengaruhi kecanduan smartphone yaitu pola asuh orang tua. Perilaku anak juga dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Perilaku yang ditunjukkan anak tergantung dari cara orang tua memberi arahan kepada anaknya. Oleh karena itu diperlukan pemilihan dalam menerapkan jenis pola asuh yang efektif kepada anak dalam mengawasi dan memberi aturan pada saat menggunakan smartphone. sehingga hal tersebut dapat meminimalisir kecanduan smartphone pada anak prasekolah (Hasanah, 2020).

Pola asuh merupakan suatu sikap, mendidik, membimbing, dan interaksi orang tua kepada anak untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan anak dan harapan orang tua semoga anak bisa sukses. Dimana setiap orang tua memiliki macam-macam pola asuh yang berbeda-beda bagi anaknya. Teori Baumrind mengatakan pola asuh ada tiga yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Tingkah laku yang diperlihatkan anak berkaitan dengan penerapan pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak. Pembentukan kepribadian anak dipengaruhi oleh semua unsur lingkungan yaitu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Dari ketiga lingkungan tersebut yang paling berpengaruh terhadap kepribadian anak yaitu lingkungan keluarga, karena dalam keluarga semua anggota dapat saling membantu dan saling memengaruhi (Suherman, 2019).

Pola asuh otoriter cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan, serta kedekatan emosi orang tua dan anak sehingga seakan memiliki dinding pembatas antara orang tua dengan anak. Perilaku anak dengan pola asuh otoriter cenderung penakut, mudah tersinggung, tidak bersahabat, dan mudah terpengaruh serta mudah stres. Pada pola asuh demokratis, anak diberi kesempatan untuk mengembangkan dalam mengontrol internalnya sehingga anak dapat berlatih bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Sedangkan pada pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak sesuai dengan keinginannya sendiri, serta orang tua tidak memberikan aturan dan pengarahan kepada anak. Sehingga anak akan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, meskipun bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat (Erviana, 2022).

## F. KERANGKA BERPIKIR

Gambar 6.1 Kerangka Berpikir Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Kecanduan Smartphone Pada Anak



## G. KESIMPULAN

Dari ketiga jenis pola asuh yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif, dapat disimpulkan bahwa pola asuh demokratis dianggap sebagai pola asuh yang paling efektif, karena pola asuh tersebut menghasilkan dampak yang positif pada anak.

## H. REFERENSI

- Adawiyah R. Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak. J Pendidik Kewarganegaraan. 2017;7(1):33–48.
- Adi TN. Pola Pengawasan Orang Tua Terhadap Aktivitas Anak di Dunia Maya. J Online Soedirman - Univ Jenderal Soedirman. 2017;13(2):1–20.
- Agusta D. Faktor-Faktor Resiko kecanduan Menggunakan Smartphone pada Siswa di SMK Negeri 1 Kalasan Yogyakarta. J Ris Mhs Bimbingan dan Konseling [Internet]. 2016;5(3):86–96. Available from: <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fipbk/article/view/1021>
- Ajhuri KF. Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Lukman, editor. Penebar Media Pustaka. Yogyakarta; 2019.
- Anggreni NKDA, Lindayani IKo, Budiani NN. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Lama Penggunaan Gadget pada Anak Prasekolah. J Ilm Kebidanan. 2019;9(1):8–12.
- Aulia DS. Faktor – faktor yang mempengaruhi adiksi smartphone pada remaja. Jakarta; 2019. p. 20–9.
- Ayun Q. Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak. ThufuLA J Inov Pendidik Guru Raudhatul Athfal. 2017;5(1):102.
- Bahadir B. Multifaceted approach to digital addiction and its treatment. IGI Glob. 2016;55:172–7.
- Chiu SI. The relationship between life stress and smartphone addiction on taiwanese university student: A mediation model of learning self-Efficacy and social self-Efficacy. Comput Human Behav. 2014;34.
- Erviana EE, Peni T, Laili SI. Hubungan Digital Parenting dengan Kecanduan Smartphone pada Anak Prasekolahdi RA Al Ghazali. Stikes Bina Sehat PPNI [Internet]. 2022; Available from: [https:// www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders).
- Fatkuriyah L, Sun-mi C. The Relationship among Parenting Style, Self-Regulation, and Smartphone Addiction Proneness in Indonesian Junior High School Students. Indones J Nurs Pract. 2021;5(1):51–9.

- Feryando DA, Wibowo APE, Darmawan A. Edukasi Dini Penggunaan Smartphone Yang Baik Pada Anak-Anak. *J Masy Mandiri*. 2022;6(2):1102–13.
- Hafilda A, Lestari S, Ratnasari F. 2021. Hubungan Pola Asuh Orang Tua pada Anak Sekolah Dasar dengan Kecanduan Gadget di Desa Mauk Barat Pada Masa Pandemi Covid
- Hasanah U, Hijrianti UR, Iswinarti I. Pengaruh Smartphone Addiction Terhadap Perilaku Agresif Pada Remaja. *Proyeksi*. 2020;15(2):182.
- Jannah MM. Identifikasi Pola Asuh Orang Tua di Taman Kanak-Kanak ABA Jogokaryan Yogyakarta. *J Pendidik Anak Usia Dini*. 2017;547–51.
- Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn C, et al. Development and Validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS). *PLoS One*. 2013;8(2).
- Kyle T, Carman S. Buku Ajar Keperawatan Pediatri Vol.1. 2nd ed. Jakarta; 2015.
- Mulawarman. Problematika Penggunaan Internet. Kencana; 2020.
- Nurhidayah I, Ramadhan JG, Amira I, Lukman M. Peran Orangtua Dalam Pencegahan Terhadap Kejadian Adiksi Gadget Pada Anak: Literatur Review. *J Ilmu Keperawatan Jiwa*. 2021;4(1):129–40.
- Nurjanah D. Penggunaan Gadget dengan Perkembangan Interaksi Sosial Anak Usia Prasekolah Berbasis Teori Adaptasi Sister Callista Roy di TK Dharma Wanita Sidoarjo. *Nurs J STIKES Insa Cendekia Med Jombang*. 2018;15(1):6–11
- Oliveira NRC de, Melo CVI de, Padovani R da C. Internet addiction : a handbook and guide to evaluation and treatment Internet addiction. *Bras Psiquiatr*. 2012;
- Park C, Park YR. The Conceptual Model on Smartphone Addiction among Early Childhood. *Int J Soc Sci Humanit*. 2014;4(2):147–50.
- Primiastuti D, Mahayati L, Chayani EE. Studi Tentang Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Smartphone Bagi Anak Prasekolah Di Kecamatan Asemrowo Surabaya. *J Kebidanan*. 2022;11(1):16–21.
- Purnama D, Rahayu MS, Khasanah AN. Kecanduan Smartphone dan Perilaku Agresif pada Anak Prasekolah. *Pros Psikol*. 2018;6(2):641–7.
- Raudhati S, Agustina. Development of Preschool Age Children in Ash Shafiyah Kindergarten Bireuen District. *J Healthc Technol Med*. 2022;8(2):762–72.
- Samsudin. Pentingnya Peran Orang Tua dalam Membentuk Kepribadian Anak. *J Pendidik Islam dan Multikulturalisme*. 2019;1(2):50–61.
- Setianingsih S. Dampak Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Prasekolah Dapat Meningkatkan Resiko Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas. *Gaster*. 2018;16(2):191.

- Suherman RN. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tingkat Kecanduan Gadget pada Anak Prasekolah. Surabaya: Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah; 2019.
- Susanti. Peran Orang Tua Pada Pengawasan Penggunaan Smartphone Anak Usia Sekolah Dasar Di Desa Pontanakayang Kabupaten Mamuju Tengah. Respir Softw Univ Negeri Makassar [Internet]. 2021; Available from: <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/18180>
- Susilowati E. Pola Asuh Orang Tua dan Perkembangan Anak Usia Prasekolah. Maj Ilm Sultan Agung. 2012;L(126):87–111.
- Theopilus Y, Atmadja BC. Pengembangan Sistem Persuasif pada Smartphone untuk Mengatasi Perilaku Kecanduan Smartphone pada Anak menggunakan Metode Design with Intent (Dwl). J Ergon dan K3 [Internet]. 2022;7(1):8–18. Available from: <https://jurnalergonomik3.ti.itb.ac.id/index.php/ergonomik3/article/view/183>
- Ula WRR. Dampak Kecanduan Smartphone Terhadap Prestasi Belajar Siswa. J Pendidik Dasar J Tunas Nusantara. 2021;3(1):290–8.

# **BAB 7**

## **ANEMIA ANTARA NON INFEKSI DAN INFEKSI**

**dr. Evi Istiqamah, M.Biomed**

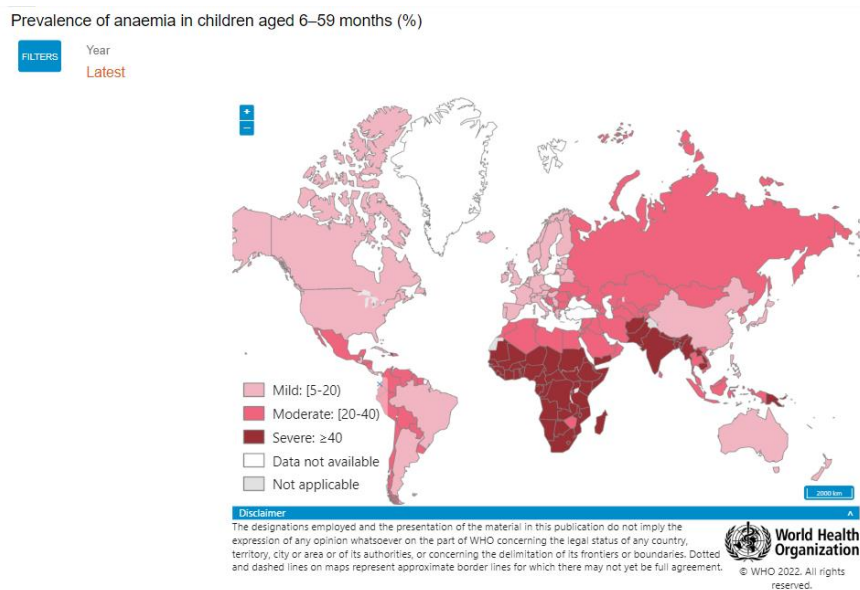


## ANEMIA ANTARA NON INFEKSI DAN INFEKSI

dr. Evi Istiqamah, M.Biomed

### A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki masalah kesehatan masyarakat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas pada anak yaitu **anemia**. Data WHO menunjukkan angka kejadian di asia tenggara menempati tempat kedua setelah afrika selatan. Untuk Indonesia didapatkan bahwa prevalensi anemia usia 6 - 59 bulan 20 – 40% terlihat pada gambar 7.1.



**Gambar 7.1 Prevalensi Anemia pada anak umut 6 - 59 bulan**

Anemia pada anak merupakan masalah kesehatan penting yang menjadi manifestasi beberapa penyakit pada anak. Permasalahan yang terjadi adalah masih tumpang tindihnya beberapa penyebab anemia, sehingga penanganan yang tepat bisa terkaburkan akibat penyebab yang berbeda. Kebutuhan tenaga kesehatan mengetahui penyebab anemia menjadi pengetahuan esensial agar dapat menangani anemia dengan tepat.

Anemia yang banyak dijelaskan didalam beberapa referensi di indonesia adalah anemia defisiensi besi (ADB). Kekurangan zat besi gizi adalah gangguan yang dihasilkan dari asupan zat besi yang rendah, peningkatan kebutuhan zat besi atau kehilangan zat besi, serta penyerapan zat besi yang rendah dari nutrisi. Namun permasalahan yang perlu dipahami bahwa bukan zat besi saja yang menjadi pemicu tunggal penyebab anemia, namun ada penyebab infeksi yang juga bisa menjadi penyebab anemia. Selain itu anemia juga menjadi gejala untuk penyakit leukemia dan penyakit bawaan.

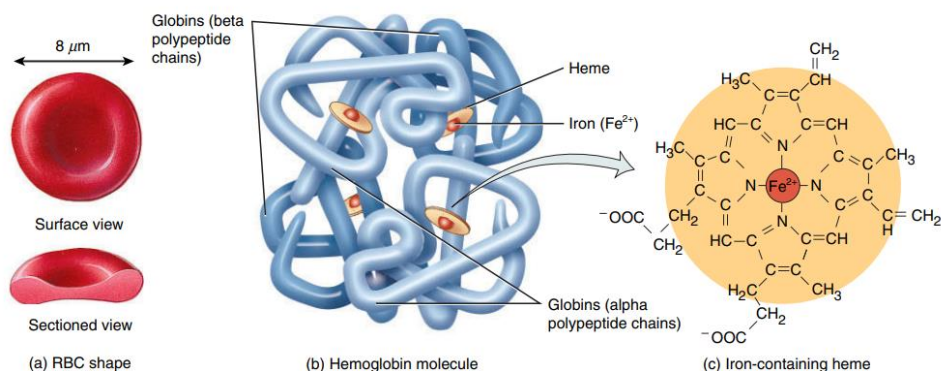
## B. DEFINISI ANEMIA, SIKLUS HIDUP DAN PEMBENTUKAN ERITROSIT

### 1. Definisi Anemia

Anemia didefinisikan konsentrasi hemoglobin (Hb) dan/atau jumlah sel darah merah (eritrosit) lebih rendah dari normal sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Pada definisi ini kita ketahui bahwa bukan hanya terkait defisiensi besi saja yang bermasalah namun jumlah sel darah juga menjadi permasalahan.

Kebutuhan fisiologis yang menjadi kata kunci juga karena hemoglobin dan jumlah sel darah merah ini diperlukan kadarnya sesuai disebabkan adanya kebutuhan pada anak. Kerja utama atau eritrosit menjadi media membawa oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel tubuh ke paru-paru. Protein yang berada di sel darah merah untuk membawa oksigen adalah hemoglobin. Iron (Fe) merupakan bagian dari hemoglobin. Hemoglobin menyebabkan warna merah pada sel darah merah, semakin tinggi maka semakin merah. Hubungan sel darah merah, hemoglobin dan Iron dapat dilihat pada gambar 7.2.

Kebutuhan oksigen digunakan untuk menghasilkan adenosine triphosphate (ATP), ATP dibutuhkan untuk mendorong reaksi metabolisme. Tanpa ATP maka tidak akan ada kehidupan sel tubuh. Semakin kurang ATP (dibawah standar kebutuhan), maka akan terjadi kelainan orga secara perlahan diakibatkan karena kerja organ yang tidak optimal diawali karena kekurangan sel darah merah dan atau hemoglobin yang mengangkut oksigen untuk menghasilkan ATP.



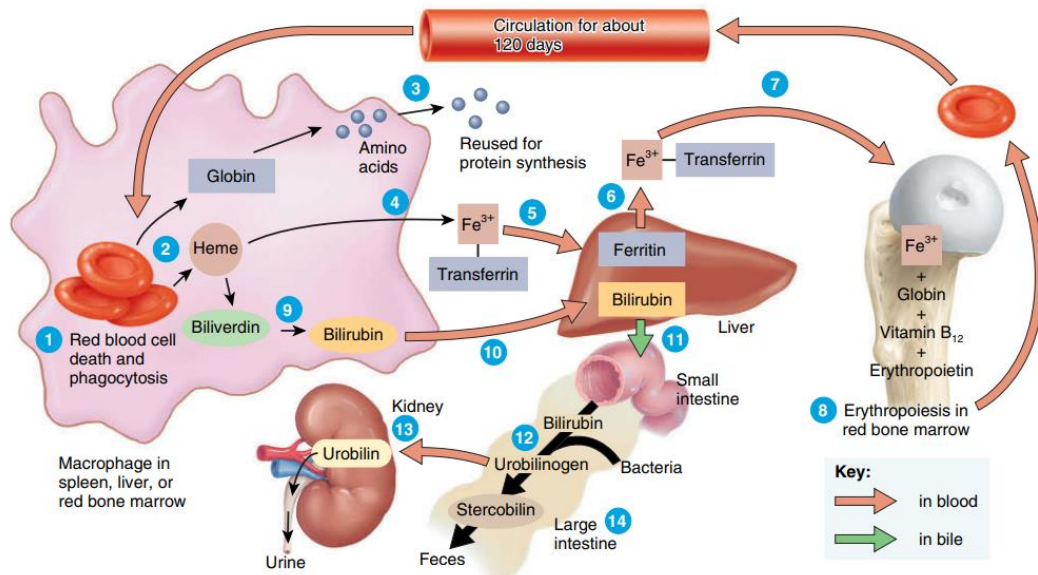
Gambar 7.2 Eritrosit, Hemoglobin, Iron(6)

### 2. Siklus Hidup dan Pembentukan Eritrosit

#### a. Siklus Hidup Eritrosit

Sel darah merah hanya hidup sekitar 120 hari karena keausan dan merobek membran plasma mereka mengalami saat mereka meremas melalui kapiler darah. Tanpa nukleus dan organel lain, sel darah merah tidak dapat mensintesis komponen baru untuk menggantikan komponen yang rusak. Itu membran plasma menjadi lebih rapuh dengan usia, dan sel-sel lebih mungkin

untuk meledak, terutama saat mereka menekan melalui sempit saluran di limpa. Sel darah merah yang pecah dikeluarkan dari sirkulasi dan dihancurkan oleh makrofag fagositik tetap di limpa dan hati, dan hasil pemecahannya didaur ulang dan digunakan dalam berbagai proses metabolisme, termasuk pembentukan sel darah merah baru. Daur ulang terjadi (lihat gambar 7.3a dan b) sebagai berikut:



**Gambar 7.3a. Pembentukan sel darah**

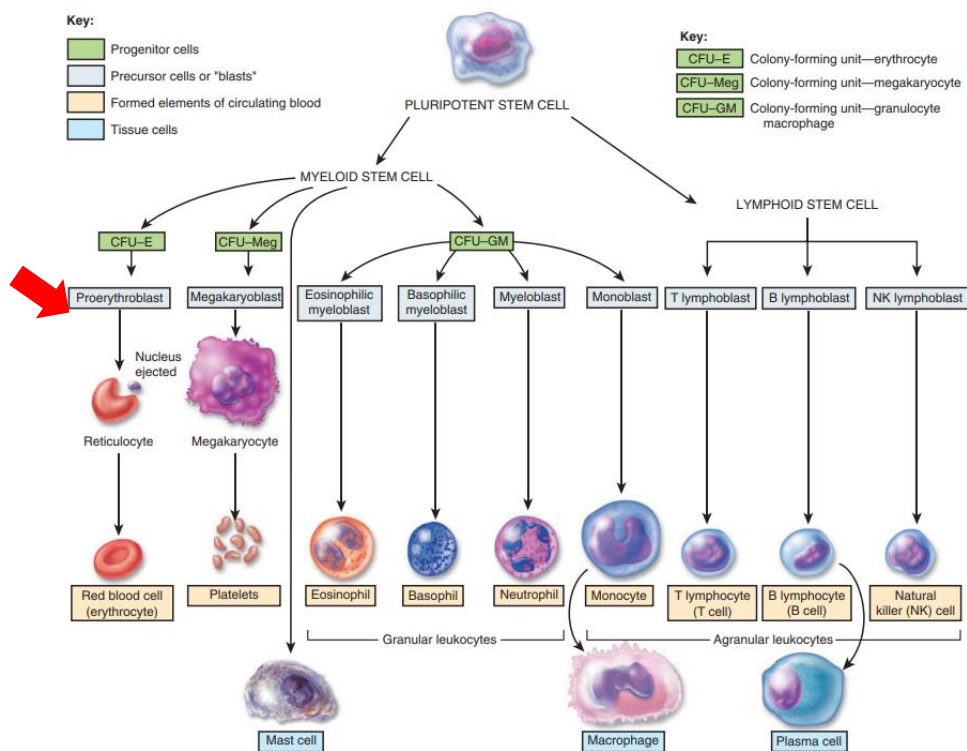
- Langkah 1. Makrofag di limpa, hati, atau sumsum tulang merah memfagosit sel darah merah yang pecah dan rusak.
- Langkah 2. Bagian globin dan heme dari hemoglobin dipisahkan.
- Langkah 3. Globin dipecah menjadi asam amino, yang dapat digunakan kembali untuk mensintesis protein lain.
- Langkah 4. Besi dikeluarkan dari bagian heme dalam bentuk  $Fe^{3+}$ , yang berasosiasi dengan protein plasma transferin, sebuah transporter untuk  $Fe^{3+}$  dalam aliran darah.
- Langkah 5. Di serat otot, sel hati, dan makrofag limpa dan hati,  $Fe^{3+}$  terlepas dari transferin dan menempel pada protein penyimpanan besi yang disebut ferritin.
- Langkah 6. Pada pelepasan dari tempat penyimpanan atau penyerapan dari saluran pencernaan,  $Fe^{3+}$  menempel kembali ke transferin.
- Langkah 7. Langkah 7. Transferin  $Fe^{3+}$  kemudian diangkut ke sumsum merah, di mana sel-sel prekursor mengambil keuntungan dari endositosis untuk mensintesis hemoglobin. Zat besi, asam amino, dan vitamin B<sub>12</sub> juga diperlukan untuk produksi hemoglobin. Eritropoiesis di sumsum tulang merah dapat

mengakibatkan perkembangan sel darah merah yang kemudian dapat memasuki sirkulasi.

- Langkah 8. Ketika besi dikeluarkan dari heme, bagian non-besi dari heme diubah menjadi biliverdin, pigmen hijau, dan kemudian menjadi bilirubin, pigmen kuning-jingga.
- Langkah 9. Bilirubin memasuki darah dan diangkut ke hati.
- Langkah 10. Di dalam hati, bilirubin dilepaskan oleh sel-sel hati ke dalam empedu, yang masuk ke usus halus kemudian ke usus besar usus.
- Langkah 11. Di usus besar, bakteri mengubah bilirubin menjadi urobilinogen.
- Langkah 12. Beberapa urobilinogen diserap kembali ke dalam darah, diubah ke pigmen kuning yang disebut urobilin, dan diekskresikan dalam urin.
- Langkah 13. Sebagian besar urobilinogen dieliminasi melalui feses dalam bentuk pigmen coklat yang disebut stercobilin yang memberikan feses warna yang khas.

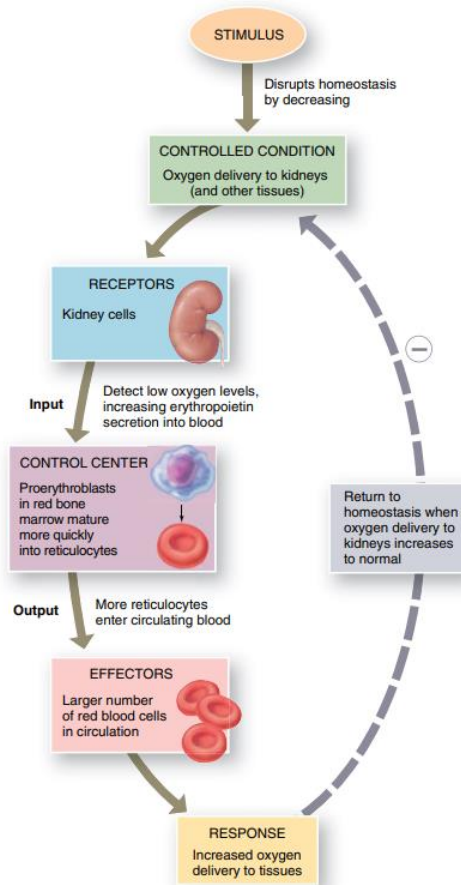
#### **b. Pembentukan Eritrosit**

Pembentukan eritrosit disebut juga **eritropoiesis**. Eritropoiesis atau produksi sel darah merah, dimulai di sumsum tulang merah dengan sel prekursor yang disebut *proerythroblast* (lihat Gambar 6.3b). **Proerythroblast** membelah beberapa kali, memproduksi sel-sel yang mulai membelah mensintesis hemoglobin. Pada akhirnya, sebuah sel di dekat ujung urutan pengembangan mengeluarkan nukleusnya dan menjadi *reticulocyt*. Hilangnya nukleus menyebabkan pusat dari sel menjadi indent, menghasilkan sel darah merah yang khas bentuk cekung ganda. Retikulosit mempertahankan beberapa mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma.



**Gambar 7.3b Pembentukan Eritrosit dimulai dari proerutroblast (panah merah)**

Sel-sel yang berhasil lewat dari tulang merah sumsum ke dalam aliran darah dengan masuk melalui sel-sel endotel kapiler darah. Retikulosit berkembang menjadi sel darah merah matang dalam satu sampai dua hari setelah pelepasannya sumsum tulang merah. Eritropoiesis dan penghancuran sel darah merah berlangsung dengan kecepatankurang lebih sama. Mekanisme sistem umpan balik negatif untuk meningkatkan produksi eritrosit (Gambar 7.4). Produksi eritrosit dikendalikan oleh jumlah oksigen yang dikirim ke jaringan tubuh. Kekurangan oksigen di tingkat seluler disebut hipoksia, dapat terjadi jika terlalu sedikit oksigen yang masuk ke dalam darah. Hipoksia merangsang ginjal untuk melangkah pelepasan erythropoietin, yang mempercepat perkembangan proeritroblas menjadi retikulosit di sumsum tulang merah. Apabila jumlah sel darah merah yang bersirkulasi meningkat, maka lebih banyak oksigen yang bisa untuk dikirim ke jaringan tubuh.



Gambar 7.4. Pembentukan eritrosit akibat dari penurunan oksigen menyebabkan kerja dari sel di ginjal menghasilkan EPO

### C. PENYEBAB ANEMIA PADA ANAK

#### 1. Anemia disebabkan Nutrisi (non Infeksi)

##### a. Akibat kekurangan zat besi (paling umum terjadi)

- 1) Akibat dari keseimbangan besi negatif yang berkepanjangan, yang disebabkan oleh asupan atau penyerapan zat besi yang tidak memadai,
- 2) Peningkatan kebutuhan zat besi selama masa pertumbuhan  
 Tiap anak juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Besarannya zat besi yang dibutuhkan oleh anak akan disesuaikan oleh usia. Jumlah zat besi yang dibutuhkan oleh anak saat usia balita. Bayi baru lahir hingga usia **6 bulan** nyatanya membutuhkan **0,27 miligram zat besi per hari**. Sedangkan anak-anak usia **7–12 bulan** membutuhkan sekitar **11 miligram**, **1–3 tahun** membutuhkan **7 miligram**, dan **4–8 tahun** membutuhkan sekitar **10 miligram** zat besi setiap harinya.
- 3) Penyerapan, pengangkutan, dan penyimpanan zat besi yang buruk, termasuk hemoglobinopati.

**b. Akibat asupan mikronutrien yang tidak memadai**

**1) Folat, Vitamin B2 Riboflavin, Vitamin B12**

Individu yang tidak mendapatkan cukup vitamin B vitamin dapat mengembangkan anemia. Kekurangan riboflavin, yang merupakan jenis vitamin B2, dapat mempengaruhi metabolisme zat besi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan penyerapan zat besi dan perpindahan dari tempat penyimpanan, serta mengganggu produksi globin. Sebuah studi mengungkapkan bahwa mengonsumsi suplemen riboflavin bersama suplemen zat besi secara signifikan meningkatkan konsentrasi hemoglobin. Defisiensi riboflavin sangat umum di daerah di mana asupan daging dan susu/produk susu rendah, dan telah didokumentasikan pada wanita hamil dan menyusui, bayi, anak usia sekolah dan orang tua.

Defisiensi vitamin B12 (kobalamin) dan defisiensi folat dapat menyebabkan anemia makrositik (megaloblastik), karena defisiensi nutrisi ini memengaruhi sintesis DNA, pembelahan sel, dan dengan demikian eritropoiesis. Defisiensi vitamin B12 paling sering terjadi akibat asupan nutrisi yang rendah, terutama jika pola makan rendah pada makanan sumber hewani, tetapi juga dapat terjadi akibat malabsorpsi, terutama pada lansia, di antaranya atrofi lambung sering terjadi (68). Data prevalensi defisiensi vitamin B12 di tingkat nasional masih kurang; namun, di lima dari tujuh negara dengan data nasional, prevalensi defisiensi vitamin B12 yang dilaporkan adalah 5% atau lebih besar di antara kelompok usia dan biologis yang berbeda. Demikian pula, kekurangan folat diperkirakan penting bagi kesehatan masyarakat di enam dari delapan negara dengan data nasional. Defisiensi folat cenderung lebih umum pada populasi yang bergantung pada gandum atau nasi yang tidak difortifikasi sebagai makanan pokok dan yang juga mengonsumsi kacang-kacangan dan sayuran berdaun hijau dalam jumlah rendah. Wanita hamil, bayi prematur dan individu yang tinggal di daerah endemik malaria juga berisiko tinggi kekurangan folat. Namun, kontribusi defisiensi vitamin B12 dan folat terhadap kejadian anemia global dianggap minimal, kecuali dalam kasus wanita dan bayi serta anak mereka yang mengonsumsi diet vegetarian yang kekurangan vitamin B12. Tinjauan bukti defisiensi vitamin B12 dan folat dan anemia menunjukkan bahwa prevalensi tinggi vitamin B12 atau defisiensi folat tidak selalu berkorelasi dengan prevalensi tinggi jenis anemia ini. Vitamin B6 sangat penting untuk sintesis hem, dan dapat menyebabkan mikrositik, anemia hipokromik yang sama dengan defisiensi besi, serta anemia normositik atau sideroblastik. Kekurangan vitamin B6 jarang terjadi, dan signifikansi kesehatan masyarakat dari kekurangan ini untuk anemia tidak diketahui.

## **2) Vitamin A**

Berbagai mekanisme peran defisiensi vitamin A dalam perkembangan anemia telah didokumentasikan. Retinoid telah terbukti memodulasi eritropoiesis, dan kekurangan vitamin A, karena perannya yang penting dalam fungsi kekebalan, dapat berkontribusi pada perkembangan anemia akibat infeksi pada individu yang kekurangan vitamin A. Vitamin A juga berperan dalam metabolisme zat besi, dengan penurunan mobilisasi zat besi dari simpanan di hati dan limpa selama kekurangan vitamin A yang juga dapat berkontribusi pada perkembangan anemia. Berbeda dengan anemia defisiensi besi yang ditandai dengan penipisan simpanan besi (penurunan feritin serum), anemia akibat defisiensi vitamin A ditandai dengan peningkatan simpanan besi di hati dan limpa, serta peningkatan konsentrasi feritin serum. Kekurangan vitamin A lazim di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, terutama di antara anak-anak prasekolah, wanita hamil dan wanita usia subur. Pada tahun 2013, prevalensi defisiensi adalah 29% di antara anak usia 6–59 bulan di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pada 2013, prevalensi defisiensi tertinggi di sub-Sahara Afrika (48%) dan Asia Selatan (44%). Suplementasi vitamin A telah terbukti meningkatkan konsentrasi hemoglobin di banyak tempat dan populasi yang berbeda, termasuk ketika diberikan tanpa adanya suplemen zat besi.

## **3) Vitamin C, D dan E**

Vitamin C diketahui memengaruhi metabolisme zat besi, khususnya meningkatkan penyerapan zat besi nonhem, tetapi juga meningkatkan mobilisasi zat besi dari simpanan. Defisiensi vitamin C juga dapat menyebabkan hemolisis, melalui kerusakan oksidatif pada eritrosit dan juga perdarahan kapiler yang menyebabkan kehilangan darah. Populasi yang berisiko kekurangan vitamin C termasuk wanita hamil, bayi yang diberi susu sapi secara eksklusif, lansia, dan perokok. Suplementasi vitamin C telah terbukti meningkatkan konsentrasi hemoglobin dan feritin serum pada anak-anak dan wanita tidak hamil. Tingkat vitamin D yang rendah telah dikaitkan dengan anemia pada anak-anak dan orang dewasa dari Amerika Serikat, dan individu dengan penyakit ginjal kronis, gagal jantung stadium akhir, dan diabetes tipe 2 dari beberapa negara. Mekanisme yang menghubungkan defisiensi vitamin D dengan penurunan konsentrasi hemoglobin tidak sepenuhnya dipahami, tetapi terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah dapat menyebabkan penurunan produksi kalsitriol lokal di sumsum tulang, yang dapat membatasi eritropoiesis. Anemia yang terkait dengan kekurangan vitamin E ditandai sebagai anemia hemolitik, karena efek

perlindungan vitamin E pada asam lemak tak jenuh ganda dalam membran sel darah merah. Kekurangan vitamin E diperkirakan sebagian besar terbatas pada bayi prematur dan berat badan lahir rendah, dan individu dengan sindrom malabsorpsi patologis, karena vitamin E umum terdapat pada makanan, terutama minyak sayur dan biji (65). Vitamin E secara rutin diberikan kepada bayi prematur/bayi dengan berat lahir rendah di negara berpenghasilan tinggi, untuk menghindari “anemia prematuritas”.

#### **4) Tembaga (Cooper)**

Tembaga diperlukan untuk beberapa enzim yang diperlukan untuk metabolisme besi, termasuk caeruloplasmin, yang bertanggung jawab untuk oksidasi besi dan transfer besi dari penyimpanan ke tempat sintesis hemoglobin, dan dengan demikian penting untuk metabolisme besi normal dan eritropoiesis. Salah satu tanda klinis defisiensi tembaga adalah anemia (paling sering normositik dan hipokromik, tetapi kadang-kadang normokromik dan mikrositik. Namun, defisiensi tembaga jarang terjadi, pada individu berisiko tinggi termasuk bayi prematur dan bayi berat lahir rendah yang diberi diet susu, bayi dan anak yang pulih dari malnutrisi, individu yang menerima nutrisi parenteral total berkepanjangan, bayi dengan diare berkepanjangan, dan individu dengan sindrom malabsorpsi. misalnya penyakit celiac atau sariawan non-tropis). Asupan zat besi atau seng yang tinggi juga dapat mengganggu penyerapan tembaga, seperti halnya asupan logam divalen yang tinggi (tembaga, kalsium, seng, mangan), yang memiliki transporter yang sama dengan besi, dapat mengganggu penyerapan zat besi dan menyebabkan defisiensi zat besi.

#### **c. Akibat asupan asam amino esensial**

Pembentukan hemoglobin bukan sekedar zat besi saja yang dibutuhkan, namun ada protein yang akan membentuk hemoglobin. Histidin berperan dalam metilasi protein, struktur dan fungsi hemoglobin. Histidin merupakan salah satu asam amino esensial yang harus diberikan melalui asupan makanan. Apabila asupan asam amino esensial ini tidak terpenuhi maka pembentukan hemoglobin juga akan bermasalah.

### **2. Anemia disebabkan kondisi genetik (non infeksi)**

Penyakit sel sabit yang disebut juga talasemia, penyakit akibat kelainan darah bawaan. Eritrosit berbentuk kecil (mikrositik), pucat (hipokromik), dan berumur pendek.

### 3. Anemia disebabkan racun, radiasi gamma, dan obat-obatan tertentu

Racun, radiasi gamma, dan obat-obatan tertentu yang menghambat enzim yang diperlukan untuk hemopoiesis. Tanda khas terjadinya penghancuran sumsum tulang merah disebut juga **anemia aplastik**. Anemia aplastik ini merupakan tanda dari leukemia

### 4. Anemia disebabkan infeksi

#### a. Peningkatan kehilangan zat besi sebagai akibat cacingan (usus).

##### 1) Cacing tambang (*Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale*)

Cacing tambang (*Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale*) adalah cacing yang ditularkan melalui tanah utama yang berhubungan dengan kehilangan darah (dan besi), dan anemia defisiensi besi. Diperkirakan bahwa cacing tambang tunggal dapat menyebabkan **kehilangan darah 0,03-0,26 mL/hari**. Berdasarkan perkiraan hilangnya hemoglobin melalui feses ini, infeksi cacing tambang intensitas ringan (1 sampai <2000 telur per gram feses) terkait dengan hilangnya kurang dari 2 mg hemoglobin per gram feses, sedangkan infeksi cacing tambang intensitas berat (> 4000 telur per gram feses) berhubungan dengan hilangnya lebih dari 5 mg hemoglobin per gram feses.

Sekitar 900 juta manusia saat ini terinfeksi, 50.000–60.000 per tahun meninggal karena penyakit parasit ini. *A. duodenale*, berlaku di negara-negara subtropis dan *N. americanus* mendominasi di daerah tropis.

Infeksi cacing tambang diperoleh melalui paparan kulit terhadap larva di tanah yang terkontaminasi oleh kotoran manusia. Tanah menjadi infeksius sekitar 9 hari setelah kontaminasi dan tetap seperti itu selama berminggu-minggu, tergantung pada kondisinya. Mereka mendiami **mukosa usus kecil**. Mereka menjadi tertanam di dalam vili dan menggunakan mulut mereka yang menggigit untuk memberi makan darah. Mereka mampu mengeluarkan anti-koagulan agar **darah tetap mengalir**. Infeksi oleh *A. duodenale* juga dapat terjadi melalui pengambilan larva secara oral.

##### 2) Schistosomiasis

Infeksi parasit lain yang juga dapat menyebabkan anemia adalah schistosomiasis, yang terutama terjadi di Afrika sub-Sahara, dengan perkiraan 192 juta kasus per tahun di antara anak-anak dan dewasa muda. Schistosomiasis juga menyebabkan kehilangan darah, tetapi juga dapat menyebabkan anemia melalui **peningkatan hemolisis**.

Di Indonesia, penyakit ini hanya ditemukan di 28 desa yang ada di enam kecamatan di Kabupaten Poso dan Sigi, Sulawesi Tengah. Untuk dapat mengentaskan penyakit ini, upaya pengendalian perlu difokuskan

untuk dapat memutus rantai penularan dari keong perantara dan hewan ternak pada manusia.

**b. Akibat Infeksi tuberkulosis**

Anemia pada pasien TB paru diduga akibat dari **peningkatan kehilangan darah akibat hemoptisis (darah dalam sputum); penurunan produksi sel darah merah; nafsu makan dan asupan makanan yang buruk**, menyebabkan status gizi yang buruk (zat besi, tetapi juga nutrisi lain, termasuk selenium dalam satu penelitian); dan anemia pada penyakit/peradangan kronis.

**c. Akibat Infeksi HIV**

Anemia adalah salah satu kelainan hematologi yang paling umum di antara orang yang hidup dengan HIV, mempengaruhi antara 1,3% dan 95% dari orang-orang ini, dan biasanya ditandai sebagai anemia normokromik dan normositik, dengan **jumlah retikulosit rendah, simpanan besi normal dan gangguan eritropoietin**.

Efek tidak langsung dari infeksi HIV pada anemia termasuk: infeksi oportunistik, yang umum di antara orang yang hidup dengan HIV, menyebabkan anemia (misalnya malaria, cacing tambang); defisiensi nutrisi yang berkontribusi terhadap perkembangan anemia.

Terapi antiretroviral memiliki **efek negatif pada erythropoiesis**. Virus HIV juga tampaknya memiliki efek langsung pada anemia, dengan mempengaruhi **sel-sel progenitor hematopoietik dan menurunkan respons terhadap eritropoietin**.

**d. Akibat Infeksi malaria**

Plasmodium falciparum adalah spesies parasit yang paling patogen menyebabkan malaria, dan infeksi P. falciparum dapat menyebabkan anemia berat, hipoksia berikutnya dan gagal jantung kongestif. Malaria mengganggu **metabolisme besi dalam berbagai cara dan mekanisme anemia terkait malaria mungkin terkait dengan peningkatan hemolisis (destruksi eritrosit) dan penurunan produksi sel darah merah**. Hepcidin diregulasi pada infeksi malaria, yang mungkin berkontribusi terhadap anemia melalui redistribusi besi ke makrofag, dan **menurunkan atau mencegah penyerapan besi** dari makanan.

**D. DAMPAK ANEMIA PADA ANAK**

Anemia berkaitan dengan kemampuan kognitif pada anak. Kebutuhan energi (ATP) dibutuhkan untuk pembentukan organ yang baik termasuk sistem saraf. Anak cerdas menjadi impian setiap ibu dan menjadi cita-cita bangsa karena sumber daya manusia yang akan membangun suatu bangsa. Kelainan kognitif pada

anak diakibatkan anemia menjadi faktor utama mengapa anemia butuh segera dideteksi dan ditangani sesuai dengan penyebabnya.

#### E. GEJALA ANEMIA PADA ANAK (TANDA SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF)

Tahap awal anemia tidak dapat dideteksi karena tidak ada gejala khas dan seringnya tanpa ada keluhan dari anak. Kesulitan deteksi diawal menyebabkan deteksi bisa didapatkan ketika sudah ada komplikasi yaitu gangguan tumbuh kembang anak dan gangguan sistem organ tertentu seperti jantung, otak, bahkan ginjal.

Adapun gejala yang bisa muncul pada anemia sebelum komplikasi terjadi.

##### 1. Tanda Subjektif (melalui anamnesis)

- a. Keluhan lemas atau cepat lelah
- b. Keluhan anak malas bermain dan berinteraksi dengan orang sekitarnya
- c. Keluhan jantung berdebar
- d. Keluhan sesak napas
- e. Keluhan sakit kepala dan atau pusing
- f. Keluhan nyeri pada tulang atau bagian tubuh tertentu
- g. Keluhan sering terkena infeksi
- h. Keluhan luka sulit sembuh

##### 2. Tanda Objektif

###### a. Fisik

- 1) Kongjungtiva Pucat
- 2) Kulit pucat atau kekuningan

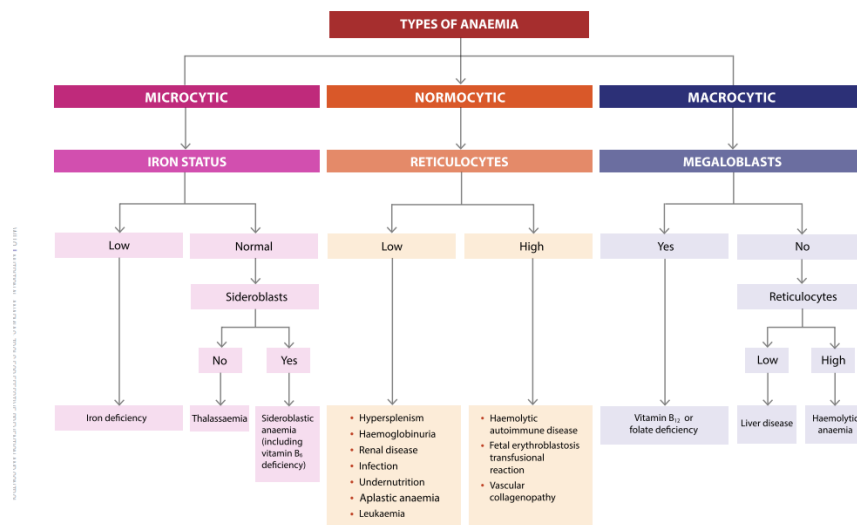
###### b. Pemeriksaan Laboratorium

###### 1) Tes darah

Pengukuran konsentrasi hemoglobin darah untuk menentukan anemia. Pemeriksaan pada hematokrit (packed cell volume), volume sel rata-rata, jumlah retikulosit darah, apusan darah tepi (bentuk sel darah merah (mikrositik, normositik, atau makrositik), serum feritin/ plasma feritin (kandungan zat besi pada serum/plasma darah). Hemoglobin diketahui secara alami bervariasi berdasarkan usia dan jenis kelamin (Tabel 7.1) dan pembagian.

| Population, age       | Anaemia    |         |          |        |
|-----------------------|------------|---------|----------|--------|
|                       | No anaemia | Mild    | Moderate | Severe |
| Children, 6–59 months | ≥110       | 100–109 | 70–99    | <70    |
| Children, 5–11 years  | ≥115       | 110–114 | 80–109   | <80    |

**Tabel 7.1 Nilai anemia pada anak umur 6- 59 bulan (bayi) dan anak 5-6 tahun (balita dan anak pra sekolah)**



**Gambar 7.5 Tipe anemia berdasarkan bentuk sel, kandungan serum feritin, jumlah retikulosit**

## 2) Aspirasi sumsum tulang

Terkadang sampel sumsum tulang merah harus diperoleh untuk mendiagnosa kelainan darah tertentu, seperti leukemia dan anemia berat. Pemeriksaan sumsum tulang mungkin melibatkan tulang aspirasi sumsum (penarikan sejumlah kecil sumsum tulang merah dengan jarum halus dan jarum suntik) atau biopsi sumsum tulang (pengangkatan dari inti sumsum tulang merah dengan jarum yang lebih besar). Kedua jenis sampel biasanya diambil dari krista iliaka tulang pinggul, meskipun sampel terkadang disedot dari tulang dada. Pada anak kecil, sampel sumsum tulang diambil dari vertebra. Sampel jaringan atau sel kemudian dikirim ke laboratorium patologi untuk analisis. Secara khusus, teknisi laboratorium terlihat untuk tanda-tanda sel neoplastik (kanker) atau sel berpenyakit lainnya untuk membantu diagnosa.

## 3) Pemeriksaan genetik (apabila anemia dicurigai disebabkan kelainan genetik)

## 4) Tes Infeksi (apabila anemia dicurigai disebabkan tuberkulosis, HIV, cacing tambang, dan malaria)

## F. PENANGANAN ANEMIA PADA ANAK

Untuk dapat menangani anemia, hal awal yang harus dilakukan adalah deteksi dini anak anemia sebelum terjadi komplikasi. Oleh sebab itu kerjasama tenaga kesehatan dengan kader kesehatan pada untuk mendeteksi gejala awal pada saat deteksi tumbuh kembang anak untuk segera dites darah untuk menegakkan diagnosa sesuai penyebab anemia.

Hal utama penanganan anemia adalah memastikan tidak ada infeksi, kelainan genetik, penyebab obat selain defisiensi zat besi. Ibarat menangani anemia adalah seperti menguras air yang ada diperahu, kita tidak akan pernah menyelesaikan penanganannya apabila tidak diketahui penyebab bocornya perahu. Pemberian zat besi tidak akan efektif jika tidak diketahui pasti penyebab yang menyebabkan defisiensi zat besi tersebut.

## **1. Non farmakologis**

### **a. Pemberian makanan bergizi**

- 1) Kebutuhan zat besi anak yang baru lahir hingga usia 6 bulan  
Proses menyusui yang dilakukan nyatanya dapat membantu memenuhi kebutuhan zat besi bayi. Sedangkan jika ibu menggunakan susu formula, ibu bisa berkonsultasi pada dokter anak mengenai jenis susu yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan zat besi bayi.
- 2) Anak yang sudah memulai MPASI atau mengonsumsi makanan keluarga, ibu bisa memberikan beragam makanan yang kaya zat besi. Dengan begitu, kebutuhan zat besi anak dapat terpenuhi dengan optimal.
  - a) Daging merah;
  - b) Kerang;
  - c) Ikan;
  - d) Hati;
  - e) Sayuran hijau, seperti brokoli dan bayam;
  - f) Kacang-kacangan;
  - g) Tahu;
  - h) Kacang kedelai;
  - i) Tomat;
  - j) Kentang; dan
  - k) Telur.

Tambahkan juga makanan yang mengandung vitamin C. Kandungan vitamin ini dapat membantu penyerapan zat besi dalam tubuh.

### **b. Penghentian dan penggantian obat penyebab anemia**

## **2. Farmakologis dan tindakan medis**

- a. Pemberian suplemen zat besi dan vitamin
- b. Pemberian antibiotik dan obat cacing
- c. Transfusi darah
- d. Transplantasi sumsum tulang

## G. REFERENSI

- Chaparro, C. M., & Suchdev, P. S. (2019). Anemia epidemiology, pathophysiology, and etiology in low- and middle-income countries. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1450(1), 15–31. <https://doi.org/10.1111/nyas.14092>
- Hal-Hal yang Perlu Anda Ketahui tentang Anemia pada Anak*. (2019, November 1). Alodokter. <https://www.alodokter.com/penanganan-anemia-pada-anak-dan-gejala-apa-saja-yang-harus-diperhatikan>
- Halodoc, R. (n.d.). 11 Makanan Kaya Zat Besi yang Baik untuk Balita. halodoc. Retrieved 25 December 2022, from <https://www.halodoc.com/artikel/11-makanan-kaya-zat-besi-yang-baik-untuk-balita>
- IDAI | ANEMIA DEFISIENSI BESI PADA BAYI DAN ANAK. (n.d.). Retrieved 25 December 2022, from <https://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/anemia-defisiensi-besi-pada-bayi-dan-anak>
- IDAI | ANEMIA KEKURANGAN ZAT BESI. (n.d.). Retrieved 25 December 2022, from <https://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/anemia-kekurangan-zat-besi>
- Infeksi cacing tambang atau Hookworm (Cutaneous Larva Migrans) – Menara Ilmu Parasitologi Kedokteran UGM*. (n.d.). Retrieved 25 December 2022, from <https://parasito.fkkmk.ugm.ac.id/infeksi-cacing-tambang-atau-hookworm-cutaneous-larva-migrans/>
- Media, K. C. (2022, August 18). *Apakah Indonesia Negara Berkembang atau Maju?* Halaman all. KOMPAS.com. <https://internasional.kompas.com/read/2022/08/18/175700170/apakah-indonesia-negara-berkembang-atau-maju->
- Prevalence of anaemia in children aged 6–59 months (%)*. (n.d.). Retrieved 25 December 2022, from [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-anaemia-in-children-under-5-years-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-anaemia-in-children-under-5-years-(-))
- Roadmap Eradikasi Schistosomiasis 2018-2025: Wujud Komitmen Pemerintah Atasi Penyakit Demam Keong | Kementerian PPN/Bappenas*. (n.d.). Retrieved 25 December 2022, from <https://www.bappenas.go.id/berita/roadmap-eradikasi-schistosomiasis-2018-2025-wujud-komitmen-pemerintah-atasi-penyakit-demam-keong>
- Semba, R. D., Shardell, M., Sakr Ashour, F. A., Moaddel, R., Trehan, I., Maleta, K. M., Ordiz, M. I., Kraemer, K., Khadeer, M. A., Ferrucci, L., & Manary, M. J. (2016). Child Stunting is Associated with Low Circulating Essential Amino Acids. *EBioMedicine*, 6, 246–252. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.02.030>
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2014). *Principles of anatomy & physiology* (14th edition). Wiley.

- Turawa, E., Awotiwon, O., Dhansay, M. A., Cois, A., Labadarios, D., Bradshaw, D., & Pillay-van Wyk, V. (2021). Prevalence of Anaemia, Iron Deficiency, and Iron Deficiency Anaemia in Women of Reproductive Age and Children under 5 Years of Age in South Africa (1997-2021): A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(23), 12799. <https://doi.org/10.3390/ijerph182312799>
- World Health Organization. (2017). *Nutritional anaemias: Tools for effective prevention and control*. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/259425>
- World Health Organization. Global Nutrition Targets 2025: Anaemia Policy Brief; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2014; Available online: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/148556> (accessed on 25 Desember 2022).
- Jain, P., Bauskar, S., & Gyanchandani, M. (2020). Neural network based non-invasive method to detect anemia from images of eye conjunctiva. *International Journal of Imaging Systems and Technology*, 30(1), 112–125. <https://doi.org/10.1002/ima.22359>
- Jangan Dianggap Sepele, Ini 5 Penyebab Mata Kuning yang Perlu Diwaspadai. (2015, September 17). Alodokter. <https://www.alodokter.com/mata-kuning-mungkin-ini-sebabnya>



**BAB 8**

**DETEKSI DINI KOMPLIKASI DAN PENANGANAN  
AWAL KEGAWATDARURATAN PADA NEONATUS,  
BAYI DAN BALITA**

**Melly Damayanti, SST., M.Keb**



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**

## **DETEKSI DINI KOMPLIKASI DAN PENANGANAN AWAL KEGAWATDARURATAN PADA NEONATUS, BAYI DAN BALITA**

Melly Damayanti, SST., M.Keb

### **A. PENDAHULUAN**

Usia atau umur diartikan sebagai lamanya seseorang untuk dapat menjalani hidup. Banyak faktor yang memengaruhi lamanya kehidupan seseorang. Salah satu hal yang menjadi faktor penentu lamanya kehidupan seseorang adalah status kesehatannya. Secara teoritis, semakin baik derajat kesehatan seseorang, maka semakin panjang usia atau umurnya. Hal ini selalu diselaraskan dengan status kesehatan seorang wanita. Angka kesakitan dan angka kematian ibu dan janin merupakan salah satu indikator penting pada derajat kesehatan suatu Negara.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang relatif masih cukup tinggi. Pada tahun 2020, AKI di Indonesia berada pada angka 4.627 kematian. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu 4.221 kematian. Terlihat adanya peningkatan AKI pada dua tahun tersebut. AKI disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan gangguan sistem peredaran darah. Adapun jumlah AKB sebesar 24 per 1.000 KH. Angka ini masih jauh dari target Kemenkes RI sebesar 16 per 1000 KH pada tahun 2024 (Kemenkes RI, 2020). Penyebab kematian tersebut dikarenakan kasus *Intra Uterine Fetal Death* (IUFD) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). (Kemenkes RI, 2019).

Periode emas merupakan periode penting pada masa balita, terutama menyangkut pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan mental dan juga keadaan emosional anak. Adapun hal yang harus dipenuhi diantaranya status gizi yang baik, personal hygiene anak, kelengkapan pemberian imunisasi, pemberian kapsul vitamin A dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, balita juga harus mendapatkan perhatian, kasih sayang dan stimulasi yang tepat dan sesuai dengan usianya, sehingga dapat mengoptimalkan kualitas hidup balita kelak. Melalui berbagai programnya, pemerintah berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan segala pelayanan kesehatan pada anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan.

### ***HILANGNYA NYAWA YANG SANGAT BERHARGA ADA APA DENGAN IBU DAN JANIN?***

Kesehatan dan keselamatan ibu sangat dipengaruhi sejak perencanaan kehamilan, masa kehamilan hingga persalinan. Hal ini sangat memengaruhi kualitas hidup bayi yang akan dilahirkan nantinya. Perencanaan kehamilan yang sehat dan baik akan melahirkan seorang bayi yang sehat dan berkualitas. Kematian ibu dapat

disebabkan oleh 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu sering, terlalu pendek jarak kehamilan, terlalu tua). Istilah 4T ini merupakan bagian dari penyebab kehamilan resiko tinggi. Atau sering disebut sebagai factor resiko kehamilan atau kehamilan dengan resiko tinggi. Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar baik terhadap ibu maupun terhadap janin yang di kandungnya selama masa kehamilan, persalinan ataupun nifas bila dibandingkan dengan kehamilan persalinan dan nifas normal (Syafuruddin, dkk, 2020). Untuk itu, 4T yang dialami pada saat kehamilan, harus segera diatas dengan baik agar tidak berlanjut hingga ke janin, bayi dan balita.

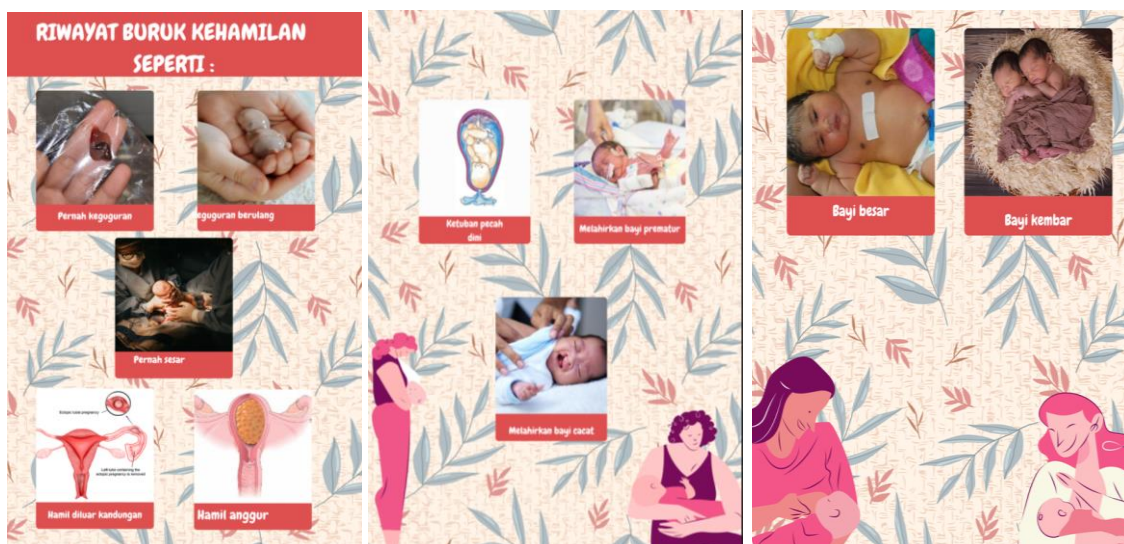
Menurut Puji Rochjati, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi ibu hamil dengan resiko tinggi diantaranya primigravida muda dengan usia dibawah 16 tahun, primipara tua yang lebih dari 35 tahun, primipara sekunder dengan usia anak terkecil lebih dari 5 tahun, tinggi badan ibu dibawah 145cm, grande multipara yang memiliki anak 4 atau lebih, memiliki masalah / komplikasi pada kehamilan sebelumnya (diantaranya riwayat keguguran, kelahiran prematur, lahir mati, dan memiliki riwayat persalinan dengan tindakan (ekstraksi forseps, ekstraksi vakum, dan operasi sesar), menderita pre-eklamsia dan eklamsia, kehamilan lewat bulan atau serotinus, pendarahan dalam kehamilan, kelainan letak dalam kehamilan, kehamilan dengan penyakit penyerta yang diderita ibu.



**Gambar 8.1 Faktor Resiko Kehamilan Yang Dapat Memengaruhi Kesehatan Neonatus. Bayi dan balita**



**Gambar 8.2 Penyakit Ibu Yang Dapat Membahayakan Kesehatan Neonatus. Bayi dan Balita**



**Gambar 8.3 Riwayat Kehamilan Yang Dapat Memperburuk Kesehatan Neonatus, Bayi dan Balita**

Adapun dampak kehamilan berisiko bagi kesehatan janin, bayi maupun balita yaitu, keguguran, bayi lahir dengan asfiksia, bayi meninggal di dalam rahim, bayi premature, bayi lahir dengan Bayi berat lahir rendah (BBLR), dan gangguan perkembangan janin di dalam kandungan. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dampak tersebut berlanjut hingga usia balita, seperti gangguan pada tingkat kecerdasan, sistem sensorik dan motorik anak, dan lain-lain.

## **B. KOMPLIKASI YANG TERJADI PADA NEONATUS, BAYI DAN BALITA**

Deteksi dini terjadinya komplikasi pada neonatus, bayi dan balita penting dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tanda dan gejala awal yang sering terjadi, diantaranya:

1. Neonatus, bayi ataupun balita tidak mau minum atau menyusui. Bahkan ada yang sampai memuntahkan kembali setiap yang masuk ke dalam mulutnya.
2. Adanya riwayat kejang pada neonates, bayi dan balita
3. Neonatus, bayi ataupun balita terlihat letargis atau bergerak jika hanya diberikan rangsangan
4. Frekuensi pernafasan kurang dari 30 kali permenit atau lebih dari 60 kali permenit
5. Suhu tubuh kurang dari 36,5°C atau lebih dari 37°C.
6. Adanya tarikan dinding dada yang sangat kuat
7. Neonatus, bayi ataupun balita merintih
8. Munculnya pustule pada kulit
9. Tubuh berwarna kuning dan atau tinja berwarna pucat
10. Berat badan menurut umur tergolong rendah dan atau memiliki masalah dalam pemberian ASI
11. Berat badan lahir rendah yaitu < 2500 gram
12. Bayi besar dengan lahir > 4000 gram
13. Adanya cacat kongenital, seperti labioschizis, dan lain-lain

Berikut beberapa komplikasi yang terjadi segera setelah lahir dan membutuhkan penanganan awal oleh tenaga kesehatan di ruangan/ kamar bersalin :

1. Bayi lahir tidak bernafas
2. Mengalami sesak nafas
3. Adanya Sianosis sentral di seluruh tubuh bayi (kulit berwarna biru)
4. Bayi BBLR dengan berat < 2500 gram
5. Bayi letargis
6. Bayi mengalami stress dingin (hipotermi) dengan suhu < 36,5°C
7. Bayi mengalami kejang

Apabila neonatus lahir dengan kondisi berikut ini, maka perlu diberikan tindakan awal oleh tenaga kesehatan. Kondisi tersebut yaitu :

1. Potensial menderita infeksi bakteri, misalnya bayi yang lahir dengan ibu yang mengalami Ketuban Pecah Dini (KPD) atau partus macet/ partus lama
2. Potensial menderita sifilis, misalnya lahir dari ibu yang menderita sifilis atau ibu dengan serologis positif.
3. Bayi yang lahir dengan kondisi malformasi

Beberapa komplikasi yang terjadi pada neonatus dan BBL yaitu

1. Prematuritas dan BBLR
2. Asfiksia neonatorum
3. Infeksi bakteri
4. Kejang
5. Bayi kuning (Ikterus)
6. Diare
7. Stress dingin (Hipotermi)
8. Tetanus neonatorum
9. Masalah dalam pemberian ASI
10. Trauma lahir
11. Sindroma gangguan pernafasan
12. Kelainan/ cacat kongenital

Berikut beberapa kondisi bayi dengan resiko tinggi

1. Asfiksia

Menurut WHO, asfiksia adalah kegagalan bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir atau beberapa saat setelah lahir. Asfiksia neonatorum merupakan salah satu komplikasi intrapartum yang menjadi penyebab terjadinya kematian neonatus. Asfiksia juga memberikan dampak jangka panjang dalam kehidupan bayi, yaitu menimbulkan palse serebral, retardasi mental, dan gangguan belajar.

Tata laksana Asfiksia

Tanpa memandang penyebab asfiksia dan seberapa berat asfiksia, **“langkah awal”** yang dilakukan merupakan upaya penyelamatan utama bagi bayi asfiksia. Sambil melakukan langkah awal, beritahukan ibu dan keluarga bahwa bayinya perlu pertolongan pertama. Kemudian mintalah salah seorang keluarga mendampingi ibu untuk memberi dukungan moral, menjaga ibu dan melaporkan bila ada masalah.

Langkah awal perlu dilakukan dalam 30 detik. Bagi kebanyakan bayi baru lahir, 6 langkah awal ini cukup untuk merangsang bayi bernapas spontan dan teratur. Langkah tersebut meliputi: (JAIKAN).

- a. Jaga bayi tetap hangat dengan menempatkan bayi di bawah alat pemancar panas.
  - 1) Meletakkan bayi diatas kain yang ada di atas perut ibu
  - 2) Membungkus bayi dan segera kemudian melakukan pemotongan tali pusat
  - 3) Memindahkan bayi ke atas meja resusitasi yang telah disiapkan



**Gambar 8.4 Menjaga Kehangatan Bayi Baru Lahir**

Jika bayi BBLR dengan berat badan kurang dari 1500 gram, maka bayi dibungkus dengan plastik untuk mencegah hipotermi.

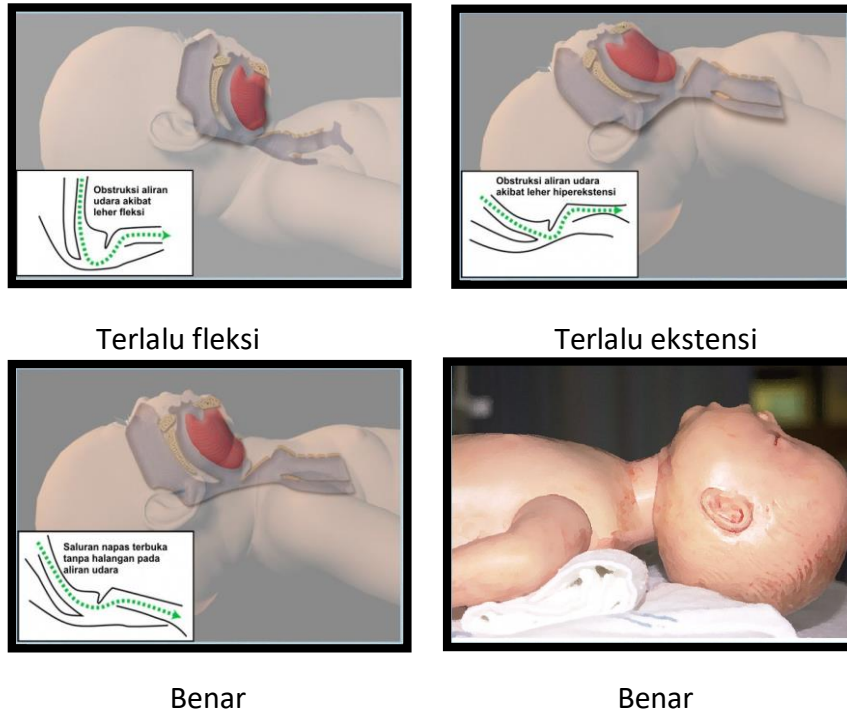


**Gambar 8.5 Menjaga Kehangatan Bayi BBLR < 1500 gram**

Bayi yang lahir dengan usia kehamilan dibawah 32 minggu atau bayi dengan berat badan  $\leq 1.500$  gram, harus dibungkus menggunakan kantong plastic polietilen untuk mencegah hipotermi.

b. Atur posisi bayi

- 1) Membaringkan bayi telentang dengan kepala didekat penolong
- 2) Memberikan ganjalan pada bahu bayi agar kepala sedikit ekstensi (kira-kira 5 cm)
- 3) Apabila bayi terlihat kurang bugar atau air ketuban bercampur dengan mekonium, segera lakukan penghisapan mekonium dari trakea dengan bantuan intubasi trakeal. Pipa Endotrakeal berfungsi sebagai kateter penghisap.



**Gambar 8.6 Posisi Ganjal Bahu Bayi**

c. Isap lendir

Untuk melakukan penghisapan lendir pada jalan nafas bayi, dapat digunakan alat penghisap lendir De Lee:

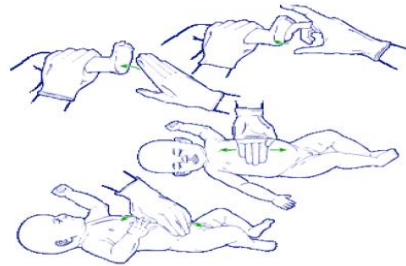
- 1) Lakukan penghisapan lendir pada bagian mulut terlebih dahulu, kemudian baru hidung jika diperlukan
- 2) Hisapan dilakukan secara kontinyu dan dibatasi selama 5 detik pada setiap penghisapan
- 3) Hisap lendir dilakukan pada saat alat penghisap tersebut ditarik keluar, jangan dilakukan penghisapan pada saat alat dimasukkan
- 4) Pengisapan tidak boleh dilakukan terlalu dalam karena dapat menyebabkan penurunan frekuensi denyut jantung dan bahkan bayi dapat berhenti bernafas secara tiba-tiba. (tidak lebih dari 5 cm ke dalam mulut dan tidak lebih dari 3 cm ke dalam hidung)



**Gambar 8.7 Isap Lendir**

d. Keringkan dan rangsang bayi

- 1) Mengeringkan bayi dilakukan dengan sedikit tekanan dan dimulai dari bagian wajah, kepala bayi dan kemudian dilanjutkan pada bagian tubuh lainnya. Hal ini bertujuan untuk merangsang bayi menangis dan bernafas.
- 2) Melakukan rangsangan taktil. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menepuk atau menyentil telapak kaki bayi, atau menggosok bagian punggung, abdomen, dada serta kaki/ tungkai bayi



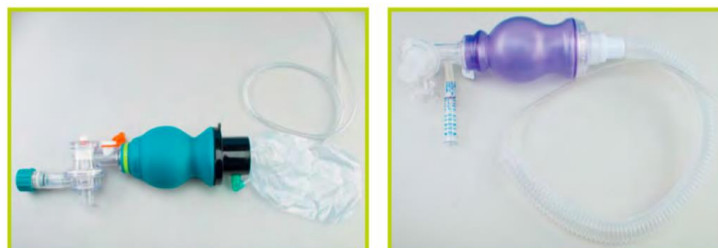
**Gambar 8.8 Tindakan Merangsang Bayi**

e. Atur kembali kepala bayi dan bungkus bayi

- 1) Mengganti kain yang telah basah dengan yang kering. (Kain pengganti dapat diletakkan di bagian bawah)
- 2) Membungkus bayi dengan kain kering tersebut. Tutuplah seluruh tubuh bayi kecuali bagian wajah dan dada bayi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penolong dalam melakukan pemantauan pernafasan bayi
- 3) Mengatur kembali posisi kepala bayi. Posisi kepala bayi harus tetap sedikit ekstensi

f. Lakukan penilaian bayi

Lakukan penilaian pernafasan bayi. Pastikan apakah bayi dapat bernafas dengan normal atau megap-megap. Hitung frekuensi jantung bayi. Apabila hasil penilaian bayi normal, maka bayi dapat diberikan kepada ibunya. Bayi dapat diletakkan diatas dada ibu dan diselimuti bersama ibu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehangatan dengan skin to skin antara ibu dan bayi. Ibu dianjurkan untuk menyusui bayinya. Namun, apabila bayi tidak bernafas atau megap-megap atau frekuensi jantung bayi  $< 100$  kali permenit, segera lakukan ventilasi pada bayi.



**Gambar 8.9 Sungkup untuk Ventilasi**

American Academic Pediatrics memberikan rekomendasi dalam melakukan stabilisasi neonatus dalam S.T.A.B.L.E terdiri dari:

*S : Sugar and safe care (S),*

*T : Temperature (T)*

*A : Airway (A)*

*B : Blood pressure (B)*

*L : Lab study (L)*

*E : Emotional support (E).*

## 2. Hipotermi

Suhu aksila normal pada bayi baru lahir berkisar antara 36,5–37,5°C, jika suhu tubuh <36,5°C maka disebut hipotermi. Pemeriksaan suhu tubuh bayi dilakukan setiap 15-30 menit. Hal ini dilakukan hingga suhu tubuh mencapai angka normal atau pemeriksaan suhu dilakukan minimal setiap jam. Pemeliharaan suhu tubuh normal harus dilakukan pada bayi sakit ataupun sehat.

Upaya pencegahan hipotermi selama stabilisasi, yaitu

- Mengatur suhu ruangan pada 25–28°C dan tetap menjaga kehangatan bayi dengan cara tidak meletakkan bayi di dekat pendingin ruangan.
- Memposisikan bayi pada *infant warmer* pada saat memberikan tindakan atau selama resusitasi.
- Menghangatkan benda yang akan bersentuhan langsung dengan bayi terlebih dahulu, seperti alas bayi, tempat tidur, stetoskop, selimut atau bedung bayi, dan juga tangan pemeriksa.
- Memasangkan topi pada bayi, membedung atau membungkus bayi terutama bayi dengan berat badan <1500 gram dengan menggunakan plastik bening. Perhatikan wajah bayi pada saat membungkus, jangan sampai menghambat jalan napas.
- Menghangatkan atau melembabkan oksigen yang akan diberikan kepada bayi.
- Sebelum memasukkan bayi ke dalam inkubator, hangatkan inkubator terlebih dahulu.
- Inkubator transport yang digunakan yaitu yang telah dihangatkan terlebih dahulu atau melakukan kontak kulit dengan bayi ketika memindahkan bayi dari ruang bersalin.

Bayi hipotermia akan mengalami vasokonstriksi/ penyempitan pada pembuluh darah, sehingga menyebabkan sirkulasi darah di dalam jaringan tubuh tidak tercukupi. Sistem metabolisme di dalam tubuh akan mengalami peningkatan jika bayi mengalami hipotermia, maka perlu ditingkatkannya kalori

di dalam tubuh. Keadaan ini akan meningkatkan kebutuhan oksigen di dalam tubuh.

Berikut beberapa metode untuk mencegah terjadinya hipotermi menurut Lunze dan hamer (2012)

a. *Skin to skin contact*/ metode kangguru pada bayi BBLR

Sering digunakan untuk mempertahankan stabilitas bayi dengan berat badan 1500-2500 gram. Namun, tidak dianjurkan bagi bayi yang sedang sakit atau kritis serta bayi dengan berat lahir sangat rendah.

b. *Radiant warmer*

Digunakan dalam peniaian resusitasi awal dan pencegahan hipotermi pada bayi dengan berat badan diatas 2500 gram. Alat ini mempertahankan suhu tubuh bayi seperti saat di dalam kandungan, yaitu 34-37°C

c. Inkubator

Sebagai tatalaksana bayi sakit dan dengan kondisi kritis. Inkubator dapat mempertahankan suhu yang konstan dan kelembaban bayi serta mempermudah dalam melakukan observasi pada bayi.

d. Ruangan hangat

Untuk bayi dalam masa pemulihan, dapat dirawat pada ruangan yang hangat. Ruangan diatur sedemikian rupa agar suhunya dapat mempertahankan keadaan bayi.

### 3. BBLR

Bayi lahir dengan berat lahir <2500 gram tanpa memandang usia gestasi. BBLR terdiri dari 2 tipe, yaitu

a. Prematur (Usia kehamilan < 37 minggu)

b. Dismatur / Kecil Masa Kehamilan (KMK)/ Intra Uterine Growth Restriction (IUGR), (Bayi cukup bulan ataupun post matur, namun berat badannya lebih kecil dibandingkan dengan usia kehamilannya)

Menurut hasil penelitian Van der Plight P, dkk tahun 2018, peningkatan resiko terjadinya BBLR dapat terjadi akibat kekurangan Vitamin D selama kehamilan.

Indikasi Bayi BBLR yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit adalah berat badan < 1800 gram, usia kehamilan < 34 minggu, bayi tidak dapat minum dan mengeluh sakit.

Berikut pemberian minum pada bayi BBLR

| <1000 gram           | 1000-1500 gram    | 1500-2000 gram    | 2000-2500 gram   |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| IVFD                 | Per OGT           | Per OGT/oral      | Per oral         |
| Bila stabil: per OGT | IVFD: bila sakit  | IVFD: bila sakit  | IVFD: bila sakit |
| Katori-spoon → BF    | Katori-spoon → BF | Katori-spoon → BF | BF               |
| Naikkan 1-2 ml       | Naikkan 1-2 ml    | Naikkan 2-4 ml    | Naikkan 3-5 ml   |
| Interval 1 jam       | Interval 2 jam    | Interval 3 jam    | Interval 3 jam   |

**Gambar 8.10 Pemberian Minum Pada Bayi BBLR**

Perawatan selanjutnya yang dapat diberikan kepada bayi dengan BBLR adalah mempertahankan suhu tubuh bayi agar tetap stabil yaitu dengan metode kangguru.

#### 4. Sepsis

Sindrom klinik yng terjadi akibat masuknya mikroorganisme ke dalam aliran darah dan biasanya terjadi dalam 28 hari kehidupan. Sepsis neonatorum terdiri dari:

- Sepsis neonatum awitan dini (SNAD)  
Sepsis terjadi saat bayi berusia  $\leq 72$  jam. Biasanya disebabkan oleh infeksi yang berasal dari mikroorganisme yang berasal dari ibu.
- Sepsis neonatorum awitan lanjut (SNAL)  
Sepsis terjadi setelah  $>72$  jam. Sepsis ini disebabkan karena adanya infeksi isebabkan mikroorganisme yang berasal dari lingkungan

Gejala klinis sepsis tidak spesifik, namun dapat ditandai dengan hipertermia, hipotermia, distress napas, apnu, ikterik, letargi, kesulitan minum, distensi abdomen, dan lain-lain.

Adapun faktor resiko sepsis diantaranya:

- Faktor risiko mayor
  - Ketuban pecah lebih dari 24 jam
  - Ibu mengalami demam dalam persalinan dengan suhu lebih dari  $38^{\circ}\text{C}$
  - Korioamnitis
  - DJJ yang menetap dengan frekuensi diatas 160x/menit
  - Ketuban berbau
- Faktor risiko minior
  - Usia kehamilan dibawah  $<34$  minggu
  - Nilai APGAR pada menit ke-5 rendah yaitu kurang dari 3

- 3) Ketuban pecah lebih dari 18 jam
- 4) BBLSR <1500 gram
- 5) Adanya Keputihan dan tidak diobati
- 6) Menderita Infeksi Saluran Kemih (ISK) atau seseorang yang diprediksi mengalami ISK yang tidak diobati

Menurut hasil penelitian Odabasi dan Bulbul tahun 2020, faktor resiko terjadinya sepsis neonatorum diantaranya prematuritas, berat lahir rendah, korioamnionitis, ketuban pecah dini, resusitasi, skor APGAR rendah, ketidakmampuan untuk menyusui, lama tinggal di rumah sakit dan adanya prosedur invasif.

#### 5. Hipoglikemi

Hipoglikemi adalah kadar glukosa darah <45mg/dL (2.6mmol/L). Adapun manifestasi klinis dari hipotermi yaitu

- a. Tremor
- b. Sianosis
- c. Kejang
- d. Hipotoni
- e. Masalah minum

Tata laksana bayi dengan hipoglikemi adalah

- a. Memberikan infus Glukose 10% 2 mL/kg secara Intravena bolus secara perlahan selama 5 menit
- b. Memberikan infus Glukose 10% sesuai kebutuhan rumatan, kemudian segera merujuk
- c. Menganjurkan ibu agar tetap menyusui bayinya

#### 6. Syok

Menurut Richmond dkk, beberapa tanda syok antara lain terjadinya peningkatan usaha bayi untuk bernapas sehingga terjadi takipnea, retraksi dada, atau adanya pernafasan cuping hidung, *grunting*, apnu, dan *gasping*. Kemudian diikuti dengan terjadinya perubahan denyut nadi, peningkatan lamanya waktu pengisian kapiler (lebih dari 3 detik), *mottling* dan kulit teraba dingin, adanya perubahan terhadap laju jantung (bradikardia dan takikardia), serta diikuti dengan penurunan tekanan darah (hipotensi). Tekanan nadi normal adalah 25-30 mmHg pada bayi aterm dan 15-25 mmHg pada bayi preterm.

Tanda klinis syok

- a. Waktu pengisian kapiler (CRT) melambat >3 detik

Cara memeriksa CRT yaitu tekan selama 5 detik di daerah dahi, dada, tangan dan kaki. Jika kurang dari 2 detik dikategorikan normal. Bila  $\geq 3$  detik menandakan terjadinya syok atau gangguan perfusi.

- b. Tangan dan kaki dingin, badan hangat
- c. Takikardia ( $>180x/\text{menit}$ ) atau bradikardia ( $<100x/\text{menit}$ )
- d. Tekanan darah rendah
- e. Pucat atau sianosis

#### Penyebab syok

Syok pada neonatus dapat disebabkan oleh keadaan hipovolemik, atau terjadinya distributif syok dan syok kardiogenik akibat adanya disfungsi miokardium. Pada keadaan awal terjadinya syok, tubuh akan mengkompensasi sehingga terjadi takikardi, kemudian berlanjut dengan vasokonstriksi perifer untuk mempertahankan tekanan darah normal. Apabila mekanisme ini gagal terlewati, maka akan terjadi kegagalan pada organ tubuh sehingga menyebabkan terjadinya hipoperfusi.

Berikut beberapa penyebab syok yang sering terjadi:

- a. Hipoksia
- b. Sepsis
- c. Perdarahan
- d. Gagal jantung
- e. Dehidrasi
- f. Perangsangan refleks vagal

#### Tata laksana syok

- a. Sesuai penyebab
  - 1) Jika penyebabnya adalah hipoksia, maka segera berikan oksigen
  - 2) Jika penyebabnya adalah perdarahan, maka lakukan transfuse darah untuk mengganti darah yang hilang
  - 3) Jika penyebabnya adalah sepsis, maka atasi sepsis dengan memberikan antibiotik yang sesuai
  - 4) Jika penyebabnya berasal dari jantung, maka atasi penyebab gangguan fungsi jantung
- b. Perbaiki perfusi, dengan cara pemberian cairan NaCl 0,9% 10ml/kgbb selama 30 menit, dapat diberikan 2 kali. Kemudian berikan obat-obatan (dopamin, dobutamin, epinefrin).

#### 7. Sesak nafas

Gejala klinis sesak nafas diantaranya:

- a. Takipnu ( $>60x/\text{menit}$ ), bradipnu ( $<30x/\text{menit}$ )
- b. Merintih

- c. Napas cuping hidung
- d. Retraksi
- e. Sianosis

Apabila bayi mengalami minimal 2 gejala klinis diatas maka didiagnosis menderita sesak nafas.

Berikut downe score yang digunakan untuk mengevaluasi sesak nafas pada bayi.

**Tabel 8.1 Downe Score untuk Evaluasi Sesak Nafas**

|                        | 0                  | 1                                     | 2                                      |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Frekuensi napas</b> | <60x/menit         | 60-80x/menit                          | >80x/menit                             |
| <b>Retraksi</b>        | Tidak ada retraksi | Retraksi ringan                       | Retraksi berat                         |
| <b>Sianosis</b>        | Tidak sianosis     | Sianosis hilang dengan O <sub>2</sub> | Sianosis menetap dengan O <sub>2</sub> |
| <b>Air entry</b>       | Udara masuk        | Penurunan udara masuk                 | Tidak ada udara masuk                  |
| <b>Merintih</b>        | Tidak merintih     | Dapat didengar dengan stetoskop       | Dapat didengar tanpa alat bantu        |

Keterangan:

Skor ≤3 : tidak terjadi sesak nafas

Skor 4-6 : mengalami sesak nafas, maka berikan oksigen

Skor ≥7 : terjadi gangguan napas berat/ terancam mengalami gagal napas, segera pasang ventilator

Evaluasi kondisi bayi harus dilakukan sesering mungkin. Hasil observasi dicatat dengan baik untuk melihat perkembangan/ kemajuan keadaan bayi. Pada beberapa situasi, dibutuhkan penilaian ulang setiap beberapa menit. Pada keadaan yang lebih ringan dapat dinilai ulang setiap 1–3 jam.

Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi dan pencatatan meliputi:

- a. Pemeriksaan tanda-tanda vital bayi seperti suhu, denyut jantung, frekuensi pernapasan dan usaha napas.
- b. Tanda bayi dalam keadaan bugar meliputi perfusi kulit, kesadaran bayi.
- c. Pemeriksaan penunjang  
Pemeriksaan penunjang perlu dilakukan pasca resusitasi atau pre transport/ pemindahan pasien meliputi pemeriksaan rontgen toraks dan perut, pemeriksaan terhadap gula darah, analisis gas darah (AGD) arterial atau kapiler, serta kultur darah.

### **C. UPAYA PENCEGAHAN KOMPLIKASI ATAU KEGAWATDARURATAN NEONATAL, BAYI DAN BALITA**

Transportasi neonatus ke tempat rujukan yang lebih baik seringkali menimbulkan permasalahan. Neonatus merupakan responden yang sangat rentan dan beban stabilisasi juga sangat besar. Keberhasilan proses rujukan sangat bergantung sepenuhnya pada tim rujukan. Sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan sejak dini agar tidak memperburuk keadaan neonates.

Pencegahan terjadinya komplikasi dan kegawatdarutan pada neonatus, bayi dan balita dapat dilakukan dengan beberapa tindakan preventif. Upaya preventif sudah harus dimulai pada saat perencanaan kehamilan hingga usia balita. Persiapan kehamilan yang baik dan sehat, proses kehamilan yang sehat, persalinan dan kelahiran yang sehat dan aman, nifas dan menyusui yang tepat serta upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi balita, hingga pemberian imunisasi merupakan sederetan upaya untuk mencetak generasi bangsa yang berkualitas.

Pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali pemeriksaan dan minimal 2 kali pemeriksaan dilakukan oleh dokter, yaitu pada trimester I dan III. Berikut uraian pemeriksaan kehamilan :

1. Sebanyak 2 kali pada trimester pertama (kehamilan hingga 12 minggu)
2. Sebanyak 1 kali pada trimester kedua (kehamilan diatas 12 minggu sampai 26 minggu)
3. Sebanyak 3 kali pada trimester ketiga (kehamilan diatas 24 minggu sampai 40 minggu)

Pemeriksaan kehamilan ini bertujuan untuk mendeteksi dini terjadinya komplikasi dan sebagai upaya untuk mempersiapkan bayi yang sehat dan berkualitas. Setelah lahir, sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan atau kunjungan neonates minimal 3 kali, yaitu

1. Kunjungan neonatus ke-1 (KN 1)  
Kunjungan dilakukan pada 6-48 jam setelah lahir. Asuhan yang diberikan berupa pemantauan pernafasan, warna kulit, gerakan bayi. Lakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan, lingkar lengan atas, dan juga pengukuran lingkar dada. Bayi diberikan obat salep mata, injeksi vitamin K1, imunisasi Hepatitis B. Lakukan perawatan tali pusat dan jaga kehangatan bayi.
2. Kunjungan neonatus ke-2 (KN 2)  
Kunjungan dilakukan pada hari ke-3 sampai hari ke-7 setelah lahir. Asuhan yang diberikan berupa pemeriksaan fisik, perawatan tali pusat bayi, pemberian ASI Eksklusif, personal hygiene, pola istirahat, keamanan dan tanda-tanda bahaya.
3. Kunjungan neonatus ke-3 (KN 3)  
Kunjungan dilakukan pada hari ke-8 sampai hari ke-28 setelah lahir. Asuhan

yang diberikan berupa penimbangan berat badan dan panjang badan bayi. Penting diberikan konseling tentang nutrisi.

Untuk memastikan kesehatan bayi balita, maka setiap bulannya dianjurkan untuk datang ke kegiatan posyandu. Hal ini bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian imunisasi, Vitamin A dan obat cacing.

Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan salah satu hal yang menjadi program pemerintah. Penyimpangan pada anak yang secara kontinyu dipantau oleh tenaga kesehatan meliputi penyimpangan pertumbuhan, penyimpangan perkembangan, gangguan pendengaran dan penglihatan, serta gangguan mental emosional, autisme, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.

| Umur Anak | Jenis Deteksi Tumbuh Kembang Yang Harus Dilakukan |    |                                        |     |     |                                                                      |        |      |
|-----------|---------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|------|
|           | Deteksi Dini Penyimpangan Pertumbuhan             |    | Deteksi Dini Penyimpangan Perkembangan |     |     | Deteksi Dini Penyimpangan Mental Emosional (dilakukan atas indikasi) |        |      |
|           | BB/TB                                             | LK | KPSP                                   | TDD | TDL | KMPE                                                                 | M-CHAT | GPPH |
| 0 bulan   | ✓                                                 | ✓  |                                        |     |     |                                                                      |        |      |
| 3 bulan   | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   |     |                                                                      |        |      |
| 6 bulan   | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   |     |                                                                      |        |      |
| 9 bulan   | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   |     |                                                                      |        |      |
| 12 bulan  | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   |     |                                                                      |        |      |
| 15 bulan  | ✓                                                 |    | ✓                                      |     |     |                                                                      |        |      |
| 18 bulan  | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   |     |                                                                      | ✓      |      |
| 21 bulan  | ✓                                                 |    | ✓                                      |     |     |                                                                      | ✓      |      |
| 24 bulan  | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   | ✓   |                                                                      | ✓      |      |
| 30 bulan  | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   | ✓   |                                                                      | ✓      |      |
| 36 bulan  | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   | ✓   | ✓                                                                    | ✓      | ✓    |
| 42 bulan  | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   | ✓   | ✓                                                                    |        | ✓    |
| 48 bulan  | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   | ✓   | ✓                                                                    |        | ✓    |
| 54 bulan  | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   | ✓   | ✓                                                                    |        | ✓    |
| 60 bulan  | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   | ✓   | ✓                                                                    |        | ✓    |
| 66 bulan  | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   | ✓   | ✓                                                                    |        | ✓    |
| 72 bulan  | ✓                                                 | ✓  | ✓                                      | ✓   | ✓   | ✓                                                                    |        | ✓    |

Keterangan:

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| BB/TB : Berat Badan terhadap Tinggi badan  | TDL : Tes Daya Lihat                                   |
| LK : Lingkar Kepala                        | KMPE : Kuesioner Masalah Perilaku Emosional            |
| KPSP : Kuesioner Pra Skrining Perkembangan | M-CHAT : Modified Checklist for Autism in Toddlers     |
| TDD : Tes Daya Dengar                      | GPPH : Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas |

**Gambar 8.11. Deteksi Dini Penyimpangan Tumbuh Kembang Pada Balita dan Anak Prasekolah**

Perkembangan dan kemajuan teknologi menyebabkan upaya promosi dan preventif terhadap kesehatan menjadi salah satu prioritas utama. Adanya pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang baru bagi pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan ibu dan bayi. Pemberian asuhan

kebidanan yang optimal kepada ibu dan bayi dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi. Masyarakat lebih menyukai pemanfaatan perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, karena dinilai lebih simple, menarik, praktis dan mudah untuk diakses. Saat ini, telah banyak diciptakan berbagai aplikasi atau media yang dapat diakses secara online untuk meningkatkan kesehatan (Safitri, 2018; Damayanti M; 2018). Bahkan beberapa aplikasi telah dirancang untuk membantu dalam pemantauan kesehatan pengguna aplikasi tersebut.

Beberapa aplikasi dan media konseling telah diciptakan dan dirancang untuk meningkatkan kesehatan bayi balita. Salah satunya yaitu Aplikasi e-Posyandu Kesehatan (ePoK). Aplikasi ini dapat membantu dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, baik oleh ibu atau orangtua ataupun bagi kader posyandu. Juga tersedia informasi sebagai tindak lanjut dari pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, dan juga dilengkapi dengan berbagai informasi kesehatan seputar balita, jadwal imunisasi dan vitamin A, dan lain-lain. Juga disediakan fitur *reminder* jadwal imunisasi dan jadwal Vitamin A, serta terdapat fitur *room chat* sebagai media untuk konsultasi dan *sharing* (Damayanti, 2022).

Selain itu, pemerintah juga sedang menggerakkan pemanfaatan bahan pangan lokal untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Pemanfaatan bahan pangan lokal ini juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat setempat.

#### **D. KESIMPULAN**

Untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kegawatdaruratan neonatal, bayi dan balita tidak dapat dilakukan setelah bayi lahir saja, namun sudah harus dilakukan sejak dini. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya:

1. Perencanaan kehamilan yang baik dan sehat
2. Proses kehamilan harus berjalan dengan baik dan lakukan kunjungan kehamilan dengan rutin
3. Proses persalinan harus dengan sehat dan berlangsung dengan lancar
4. Secara teratur lakukan kunjungan neonatus untuk memantau keadaan bayi
5. Bayi dan balita harus rutin dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya setiap bulan
6. Dukungan dari bidan dan lingkungan sekitar penting bagi ibu dan bayi

## E. REFERENSI

- Aprilia, dkk. 2020. Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Kebidanan di Era Pandemi Covid-19 Edisi-1. Malang: CV Penulis Cerdas Indonesia.
- AHA. 2020. Neonatal Resuscitation. American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. American Heart Association. 524-550.
- Damayanti M, Wirakusumah FF, Anwar R. Reproductive Health Game (KEPO Game) to self concept and adolescent reproductive health motivation. GHHC. 2018. Vol. 6(3). Hal. 162-168.
- Damayanti M., Darwitri. 2021. Booklet of “Si-JuRNalKu” (Preparation of Maternal-Neonatal Referrals in the Archipelago) to Increase. IJSS. Vol 4(12).
- Knowledge and Attitudes of Midwives Ershad M., Mostafa A., Cruz MD. Vearrier D. 2019. Neonatal Sepsis. Infections Disease. Current Emergency and Hospital Medicine Reports. Vol 7: 83-90. <https://doi.org/10.1007/s40138-019-00188-z>
- Iskandar W., Rochman HS., Galih VP., Indikurnia FQ., Hafiz MG. 2022. Survival of Respiratory Failure within the First 72 Hours in Preterm Infants with Respiratory Distress Based on the Downes Score Assessment. IJN. Vol. 13 (2).
- Kadir MR. 2018. Stabilisasi dan Transportasi Neonatus. Sriwijaya Journal of Medicine. Vol 1 (3): 201-208.
- Kawakami MD., Sanudo A., Teixeira MLP., Andreoni S., X de Castro J., Waldvogel B., Guinsburg R. Fernanda de Almeida M. Neonatal mortality associated with perinatal asphyxia: a population-based study in a middle-income country. BMC Pregnancy and Childbirth. 2021. Vol. 21 (169).
- Kemenkes RI. 2019. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Kemenkes RI
- Kemenkes RI. 2020. *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Kemenkes dan JICA
- Kemenkes RI. 2019. *Buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)*. Jakarta: Kemenkes RI
- Kostiana G., Damayanti M., Prabasari S.N, Ningsih D.A, Ivantatina D., Yuniarti F, dkk. 2021. Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Kebidanan di Era Pandemi Covid-19 Edisi-2. CV Penulis Cerdas Indonesia.
- Lunze K, Hamer D. 2012. Thermal protection of the newborn in resource-limited environments. Journal of Perinatology. Vol. 32: 317–324
- Moshiro R., Mdoe P., Perlman JM. Global View of Neonatal Asphyxia and Resuscitation. Front. Pediatr., 26 November 2019. <https://doi.org/10.3389/fped.2019.00489>
- Odabasi IO., Bulbul A. 2020. Neonatal Sepsis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. Vol 54 (2) : 142-158.

- Prisilia C., Susilo AP. 2021. Manajemen Resusitasi Neonatus pada Kelahiran Prematur. *J. Ked. Mulawarman* Vol. 8 (1).
- Razak R. Adisasmita A. Low Birth Weight and Asphyxia Neonatorum Risk: A Case-Control Study. *Proceedings of the 2nd Sriwijaya International Conference of Public Health (SICPH 2019)*. 19 June 2020. <https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200612.054>
- Safitri. 2018. Penerapan aplikasi sayang ke buah hati (SEHATI) terhadap pengetahuan ibu serta dampak pada keterampilan anak tentang cara menyikat gigi. *GMHC*. Vol. 6(1). Hal.68-73.
- Saputri NAS., Damayanti M., Rachmawati NC. 2022. The Satisfaction Of Toddler's Mother Toward The Use Of The E-Posyandu Kesehatan (E-Pok) Application In Island Territory. *IJSS*. Vol. 2(1).
- Van der Plight P., Willcox J., Szymlek-Gay, EA., Murray E., Worsley A., Daly RM. Associations of Maternal Vitamin D Deficiency with Pregnancy and Neonatal Complications in Developing Countries: A Systematic Review. *Nutrients*. 2018. 10(5), 640; <https://doi.org/10.3390/nu10050640>
- Yulianti NT. 2021 Prosedur Resusitasi pada Neonates dengan Asfiksia. *Jurnal IMJ: Indonesia Midwifery Journal*. Vol 4 (2).

## PROFIL PENULIS

**dr. Evi Istiqamah, M.Biomed**, panggilan Evi. Lahir di Nunukan Kalimantan Utara. Mengenyam pendidikan di Profesi Dokter Universitas Muslim Indonesia. Sejak tahun 2010, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di D3 Kebidanan UMI. Tahun 2016, penulis studi lanjut dengan beasiswa BUDI-DN di Magister Ilmu Biomedik Peminatan Reproduksi Manusia. Tahun 2022, penulis sementara melanjutkan studi di Program Doktor Ilmu Biomedis Hewan Peminatan Biologi Reproduksi dengan beasiswa BPI. Harapan menjadi penulis agar bisa memberi manfaat bagi orang lain terkhusus civitas akademik baik sesama rekan dosen maupun mahasiswa yang akan menjadi estafet memperjuangkan kesehatan anak di Indonesia.

Instagram @eviistiqamah. e-mail: evi.istiqamah@umi.ac.id.

Motto Hidup : Hidup ini hanya sekali (sementara), perjuangan dan manfaatkan untuk memberi manfaat agar hidup indah di akhirat yang abadi.

## PROFIL PENULIS



**Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T, MH, CBC, CPM**

Penulis Lahir di Semarang, 14 Februari 1980, lulus DIII Kebidanan AKBID Depkes Semarang tahun 2001, lulus DIV Bidan Pendidik STIKES Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2003, lulus AKTA Mengajar Universitas PGRI Semarang tahun 2006, lulus Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang tahun 2015. Pernah bekerja sebagai Bidan di PMB dan RSIA Bunda Semarang tahun 2001-2003, aktif di beberapa organisasi baik sebagai anggota atau pengurus organisasi seperti PC IBI Kota Semarang, DPW Jateng MHKI, Ikatan Alumni Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan beberapa organisasi lain di masyarakat, bekerja sebagai Dosen Kebidanan dan Hukum di Universitas Karya Husada Semarang mulai tahun 2003-sekarang. Hasil penelitian rutin dipublikasikan penulis tiap semester di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Prosiding baik nasional maupun internasional. Beberapa modul dan buku sudah dipublikasikan, ber-ISBN dan mendapat HKI antara lain Buku Ajar Natural Basic Therapy IV, Modul Inovasi Pijat Bayi Prematur dengan Music Lullaby, Buku Saku Olahan Buah Pisang dan Alpukat untuk Meningkatkan Berat Badan Balita Gizi Kurang, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan Fisiologis, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Persalinan dan BBL Fisiologis, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Nifas Fisiologis, Buku Sukses Ukom D III Bidan 2023, Buku Referensi Asuhan Kebidanan dan Keperawatan Pada Kasus Patologi Kehamilan dan Buku Referensi Pencegahan Penyakit dan Stimulasi Perkembangan Pada Anak.



**Nuril Absari, S.SiT.M.Kes**

Penulis lahir di Baturaja Sumatera Selatan, Tanggal 06 Juni 1988. Penulis Menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Universitas Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah tahun 2009, DIV Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo Ungaran bulan April Tahun 2011 dan S2 Kesehatan Masyarakat peminatan Kespro di Universitas Respati Indonesia Jakarta tahun 2015. Penulis sebelumnya pernah bekerja Di Akbid Rizki Patya Palembang tahun 2011-2012, sedangkan di tahun 2012 sampai sekarang penulis aktif sebagai seorang dosen tetap dan memiliki jabatan sebagai Sekretaris Prodi Kebidanan program sarjana di STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu. Penulis mengampu mata kuliah Asuhan Neonatus bayi, balita dan anak prasekolah, ASKEB Komunitas, Sistem informasi dalam Kebidanan dan Askeb Kegawatdaruratan. Selain mengajar penulis juga membimbing Skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa Prodi S1 Kebidanan dan membimbing Profesi di STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu. Aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian. Pengalaman sebelumnya penulis telah memiliki Buku Saku perawatan Bayi Baru Lahir yang Telah Ber ISBN, dan Haki Booklet tentang ASI Eksklusif.  
email: nurilsari23@gmail.com

## PROFIL PENULIS



**Rahmah Fitria, S.ST., M.Keb.** Penulis lahir di Bandar Lampung tanggal 04 Mei 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Panca Bhakti Bandar Lampung. Menyelesaikan D3 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang Bandar Lampung dan melanjutkan D4 Bidan Pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran UNPAD) Bandung. Gelar Magister Kebidanan (M.Keb) diperolehnya di Universitas Andalas (UNAND) Padang pada tahun 2018.

Penulis saat ini aktif menulis buku dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini menjabat sebagai kepala BAAK di STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung. email : rahmah@pancabhakti.ac.id



**Ni Putu Riza Kurnia Indriana, SST., M.Kes.** Penulis menyelesaikan pendidikan D4 Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat pada tahun 2016 di Universitas Udayana Denpasar Bali, Konsentrasi KIA-Kespro dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019. Saat ini penulis aktif mengajar di Prodi Sarjana dan Profesi Bidan, Fakultas Kesehatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Penulis aktif dalam pembuatan buku ajar, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal lainnya. Email penulis: rizakurnia1788.stikesbali@gmail.com

## PROFIL PENULIS



### **Royani Chairiyah, S.Si.T, M.Kes, M.Keb**

Penulis Lahir di Padang, 9 Mei 1979, lulus SPK Depkes Bukittinggi tahun 1998 dan Program Pendidikan Bidan Depkes Bukittinggi lulus 1999, D3 Kebidanan di Poltekkes Jakarta III lulus tahun 2004, terus melanjutkan D4 Kebidanan lulus 2006, S2 Kesehatan Masyarakat lulus 2012, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung lulus Januari 2023. Pernah bekerja sebagai Bidan PTT di Puskesmas X Koto I Tanah Datar

Sumatera Barat, dan RB Sayyidah tahun 2001-2010, Praktek Bidan Mandiri 2005 sampai sekarang, Dosen kebidanan dari 2005-sekarang, tahun 2019- sekarang dosen di Universitas Binawan dan aktif di beberapa organisasi baik sebagai anggota atau pengurus organisasi seperti Ranting IBI Bekasi. Hasil penelitian rutin dipublikasikan penulis tiap semester di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Prosiding baik nasional maupun internasional. Beberapa buku Chapter dan ajar ber-ISBN dan mendapat HKI antara lain Rancangan Aplikasi (Prototip) Go Zero , Buku Chapter Penyakit dan Kelainan dari kehamilan, Buku Chapter Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal, Buku Chapter Mikrobiologi Bab 5 Penyakit Parasit dalam Kebidanan, Buku Chapter Bab III Kesehatan Reproduksi, Buku Chapter Kesehatan Reproduksi, Buku Chapter asuhan Kebidanan pranikah, Buku Chapter Psikologi dalam Kebidanan, Buku Chapter Terapi Komplementer pada Kebidanan, Buku Ajar Asuhan Kehamilan DIII Kebidanan Jilid II, Buku Chapter Pijat dan Spa, Buku Chapter Asuhan Kebidanan kondisi rentan, Buku Chapter Konsep dasar kebidanan komunitas, Buku Referensi Evidence Based Natural Therapy dalam Kebidanan, Buku ajar Pelayanan Keluarga Berencana, Evidence based soal kasus kebidanan komunitas IV. Penulis dapat dihubungi melalui email [royanichairiyah@gmail.com](mailto:royanichairiyah@gmail.com)



**Brivian Florentis Yustanta., SST., M.Kes**, lahir di Tulungagung tahun 1989. Penulis merupakan dosen Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Karya Husada Kediri. Penulis menempuh Pendidikan perguruan tinggi pada program D-III Kebidanan di Akademi Kebidanan Griya Husada Surabaya (2008), D-IV Bidan Pendidik di STIKES Karya Husada Kediri (2011) dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) di Universitas Airlangga Surabaya (2013). Penulis merupakan anggota IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cabang Kabupaten Kediri. Penulis memiliki concern terhadap issue – issue terkini mengenai kesehatan bayi, balita

dan anak serta kesehatan reproduksi remaja. Penulis aktif dalam kegiatan menulis artikel di majalah kebidanan maupun karya ilmiah semenjak masih di bangku perkuliahan. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dimana hasil penelitian telah banyak dipublikasikan ke dalam jurnal penelitian maupun prosiding penelitian yang bereputasi baik berskala nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pembicara / narasumber dalam forum kegiatan ilmiah. Banyak ide dan gagasan dari penulis yang telah dituangkan dalam bentuk inovasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dimana dengan kegiatan memiliki dampak yang signifikan dalam mengatasi permasalahan di masyarakat diantaranya adalah corong posyandu (pemberdayaan kader dan masyarakat dalam meningkatkan kunjungan posyandu), kepo risti (kelompok peduli ibu hamil berisiko tinggi), rebahan produktif (remaja beraktivitas hadapi pandemi secara produktif), gemas si botak (gerakan bersama imunisasi booster pada anak untuk meningkatkan cakupan imunisasi booster), berinisiatif (berikan anak hanya asi eksklusif) dan masih banyak kegiatan inovasi lainnya. Email: [brivianflorentis@gmail.com](mailto:brivianflorentis@gmail.com).

## PROFIL PENULIS



### **Melly Damayanti, SST., M.Keb**

Penulis merupakan Dosen Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dan telah mengabdikan sejak tahun 2009. Penulis lahir di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan Program Diploma III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Padang pada tahun 2006. Gelar Sarjana Sains Terapan dan Magister Kebidanan telah didapatkan penulis di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2008 dan 2017. Penulis aktif melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas sebagai seorang dosen. Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan beberapa produk dan inovasi yang telah mendapatkan sertifikat HAKI, diantaranya *Game* KEPO (*Game* Kesehatan Reproduksi), Aplikasi ePoK (e-Posyandu Kesehatan) bagi ibu balita, Aplikasi ePoK Binke (e-Posyandu Kesehatan bagi Bidan dan Kader posyandu), Minuman RULA (Rumput Laut) untuk mencegah anemia, JENIPER (Jeruk Nipis Peras) untuk mengatasi emesis gravidarum, Modul Go-Anemi, Si-JuRNaLKu (Booklet rujukan maternal neonatal di daerah kepulauan), dan lain-lain. Hasil penelitian ini juga diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis juga berkontribusi dalam penyusunan beberapa buku diantaranya Buku Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Kebidanan di Era Pandemi Covid-19 Edisi 1, 2 dan 3, Buku Ajar Konsep Kebidanan, Buku Sukses UKOM D3 Bidan dan Buku Asuhan Kegawatdaruratan Persalinan. Email Penulis: apriyandimelly@gmail.com

## SINOPSIS

Buku Asuhan Kebidanan Kasus Patologis pada Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah disusun untuk menjawab tantangan masalah kesehatan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Tiga kelompok anak yang membutuhkan perhatian untuk dapat dilaksanakan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standar yang seharusnya. Ada kasus patologis yang membutuhkan perhatian serius, apabila tidak ditangani dengan baik akan mempengaruhi mortalitas dan morbiditas anak. Adapun Asuhan Kebidanan Kasus Patologis pada Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah terdiri dari: 1) Cegah Stunting pada Anak 2) Imunisasi Bayi, Balita, dan Anak 3) Manajemen Terpadu Balita Sakit 4) Pendidikan Kesehatan dalam Merawat Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah 5) You Should Know! Evidence Based Dalam Askeb Bayi, Balita, Dan Anak Pra Sekolah 6) Pola Asuh Orang Tua dan Kecanduan Smartphone 7) Anemia Antara Non Infeksi Dan Infeksi 8) Deteksi Dini Komplikasi Dan Penanganan Awal Kegawatdaruratan Pada Neonatus, Bayi Dan Balita. Harapannya tulisan ini dapat membantu civitas akademik dalam memberi pengajaran, penelitian dan pengabdian baik untuk tenaga pengajar maupun peserta didik yang menempuh pendidikan. Dengan buku ini dapat memenuhi kebutuhan kesehatan bayi, balita dan anak prasekolah. Kesehatan anak merupakan pondasi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila kebutuhan kesehatan ini terpenuhi, maka tumbuh kembang dapat lebih dioptimalkan.

Buku Asuhan Kebidanan Kasus Patologis pada Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah disusun untuk menjawab tantangan masalah kesehatan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Tiga kelompok anak yang membutuhkan perhatian untuk dapat dilaksanakan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standar yang seharusnya. Ada kasus patologis yang membutuhkan perhatian serius, apabila tidak ditangani dengan baik akan mempengaruhi mortalitas dan morbiditas anak. Adapun Asuhan Kebidanan Kasus Patologis pada Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah terdiri dari: 1) Cegah Stunting pada Anak 2) Imunisasi Bayi, Balita, dan Anak 3) Manajemen Terpadu Balita Sakit 4) Pendidikan Kesehatan dalam Merawat Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah 5) You Should Know! Evidence Based Dalam Askeb Bayi, Balita, Dan Anak Pra Sekolah 6) Pola Asuh Orang Tua dan Kecanduan Smartphone 7) Anemia Antara Non Infeksi Dan Infeksi 8) Deteksi Dini Komplikasi Dan Penanganan Awal Kegawatdaruratan Pada Neonatus, Bayi Dan Balita. Harapannya tulisan ini dapat membantu civitas akademik dalam memberi pengajaran, penelitian dan pengabdian baik untuk tenaga pengajar maupun peserta didik yang menempuh pendidikan. Dengan buku ini dapat memenuhi kebutuhan kesehatan bayi, balita dan anak prasekolah. Kesehatan anak merupakan pondasi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila kebutuhan kesehatan ini terpenuhi, maka tumbuh kembang dapat lebih dioptimalkan.

ISBN 978-623-8411-01-6



**IKAPI**  
IKATAN PENERBIT INDONESIA

**Anggota IKAPI**  
**No. 624/DKI/2022**

**Penerbit :**

**PT Nuansa Fajar Cemerlang**  
**Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F**  
**Jalan S. Parman Kav. 22-24**  
**Kel. Palmerah, Kec. Palmerah**  
**Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480**  
**Telp: (021) 29866919**